Đánh giá và sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện hữu nghị Việt Đức

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh đời sống xã hội phát triển, được coi trọng hơn lúc nào hết. Hiện nay nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế ngày càng tăng về số lượng cũng như chất lượng của người dân. Hài lòng của người bệnh là một yếu tố quan trọng trong chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đó là sự đáp ứng của người bệnh đối với những khía cạnh nổi bật trong trải nghiệm được cung ứng bởi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nó bao hàm sự đánh giá (về nhận thức) và phản ứng (về cảm xúc) đối với cấu trúc, xử lý và hệ quả của các dịch vụ, cụ thể là chất lượng của các thông tin y tế và mối quan hệ với nhân viên y tế hàng ngày [1].

Chất lượng hoạt động của bệnh viện là sự hài lòng của người bệnh và cán bộ, viên chức của chính bệnh viện. Bệnh viện khi không làm hài lòng người bệnh sẽ bị mất người bệnh tiềm năng, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện [2].

Vì vậy, sự hài lòng của người bệnh đã trở thành một trong những khía cạnh quan trọng để đánh giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay nói cách khác sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh không chỉ dừng lại ở việc chuyên môn chữa đúng, chữa đủ, chữa khỏi mà phải làm cho người bệnh hài lòng nhiều mặt: thái độ của nhân viên y tế, trang thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng tiện nghi, sạch đẹp.

Hiện nay, ở Việt nam đã có khá nhiều nghiên cứu về sự hài lòng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các nghiên cứu được thực hiện khoa học và bài bản, đã cho thấy nhiều kết quả đa chiều về sự hài lòng của người bệnh với bệnh viện.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, năm 2012, tác giả Nguyễn Bá Anh đã thực hiện đề tài: "*Đánh giá và sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện hữu nghị Việt Đức"*. Nghiên cứu xác định tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh với chất lượng chăm sóc của điều

dưỡng là 93,5% [3]. Tuy nhiên đề tài trên chỉ đề cập đến sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng, chưa đánh giá được hết các yếu tố của chất lượng dịch vụ và vẫn còn 6,5% người bệnh chưa hài lòng.

Ngày 10/9/2015, Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành phát động triển khai kế hoạch và ký cam kết về việc "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" [4]. Hàng năm số ca phẫu thuật bệnh lý cột sống tại khoa chiếm tỷ lệ khá cao, gần 75% tổng số người bệnh nội trú. Phẫu thuật cột sống có thể cải thiện một cách tích cực chất lượng cuộc sống cho người bệnh nên sự hài lòng của người bệnh đóng vai trò rất quan trọng. Cho tới nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá về chất lượng dịch vụ tại khoa nên việc thiết lập mô hình đo lường sự hài lòng của người bệnh sẽ là cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tiến chất lượng và định hướng chiến lược phát triển bền vững của Khoa. Vì vậy, đề tài này được nghiên cứu là cần thiết nhằm cung cấp thêm những bằng chứng khoa học giúp Ban Lãnh đạo bệnh viện nói chung và Khoa Phẫu thuật Cột sống nói riêng lập kế hoạch và triển khai cung cấp các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người bệnh với hai mục tiêu nghiên cứu:

1/ Mô tả sự hài lòng của người bệnh phẫu thuật bệnh lý cột sống với dịch vụ y tế của Khoa Phẫu thuật Cột sống, Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2014-2015

2/ Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh nói trên.

Trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị nhằm tăng cường sự hài lòng của người bệnh tại khoa.

Chương 1
TỔNG QUAN

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Khái niệm và phân loại sự hài lòng

Theo Brown (1992), sự hài lòng của khách hàng là một trạng thái trong đó những gì khách hàng cần, muốn, mong đợi ở sản phẩm và gói dịch vụ được thỏa mãn hay vượt quá sự thỏa mãn. Kết quả là có sự mua hàng lặp lại, lòng trung thành và giá trị của lời truyền miệng một cách thích thú [5].

Kotler (2001) cho rằng, sự hài lòng là mức độ của trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ sản phẩm/dịch vụ với những kỳ vọng của người đó. Kỳ vọng ở đây được xem là ước mong hay mong đợi của con người. Nó bắt nguồn từ nhu cầu cá nhân, kinh nghiệm trước đó và thông tin bên ngoài như quảng cáo, thông tin truyền miệng của bạn bè, gia đình [6].

Sự hài lòng của người bệnh liên quan đến chăm sóc sức khỏe là một khái niệm đa chiều rất quan trọng biểu hiện bằng kết quả chăm sóc. Phân tích sự hài lòng với chăm sóc y tế có sự khác biệt cho thấy sự hài lòng của người bệnh là tổng thể hiệu suất của một tổ chức với những khía cạnh sau: Chất lượng, tin cậy, uy tín, liên tục, thẩm quyền, thông tin, cơ sở vật chất, chú ý đến các vấn đề tâm lý xã hội, nhân đạo và kết quả chăm sóc [7].

Ngày nay, sự hài lòng của người bệnh đã trở thành một trong những khía cạnh quan trọng để đánh giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở y tế đã được tiến hành trong nhiều nghiên cứu trên thế giới với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cũng như sự nhận thức của người dân về quyền được hưởng những dịch vụ tốt nhất.

Nhìn chung, tuy có sự khác biệt giữa các tác giả về khái niệm sự hài lòng với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng vẫn có điểm tương đồng đó là tất cả đều xác định sự hài lòng như yếu tố khách quan xuất phát từ cảm nhận của người bệnh khi phải chịu tác động của các dịch vụ có chất lượng tốt hay không.

Có 3 loại sự hài lòng của khách hàng: Hài lòng tích cực (Demanding customer satisfaction), Hài lòng ổn định (Stable customer satisfaction), Hài lòng thụ động (Resigned customer satisfaction) [8], [9], [10], [11].

Nhận thức chất lượng dịch vụ là kết quả của khoảng cách giữa dịch vụ mong đợi và dịch vụ cảm nhận sự hài lòng cũng là sự so sánh hai giá trị này. Khi khoảng cách giữa dịch vụ mong đợi và dịch vụ cảm nhận về chất lượng dịch vụ được thu hẹp bằng "0" thì được xem là khách hàng hài lòng. Mức độ thỏa mãn là sự khác biệt giữa kết quả nhận được và kỳ vọng. Dựa vào nhận thức về chất lượng dịch vụ có thể chia sự hài lòng thành ba mức độ sau (khách hàng có thể có cảm nhận một trong ba mức độ thỏa mãn) [6]:

+ *Không hài lòng*: Khi mức độ cảm nhận của khách hàng nhỏ hơn mong đợi (nếu kết quả thực hiện kém hơn so với kỳ vọng thì khách hàng sẽ không hài lòng).

+ *Hài lòng*: Khi mức độ cảm nhận của khách hàng bằng mong đợi (nếu kết quả thực hiện tương xứng với kỳ vọng thì khách hàng sẽ hài lòng).

+ *Rất hài lòng*: Khi mức độ cảm nhận của khách hàng lớn hơn mong đợi (nếu kết quả thực tế vượt quá sự mong đợi thì khách hàng rất hài lòng và thích thú).

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đánh giá về sự hài lòng của người bệnh.

1.1.2. Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Ngày nay, chất lượng dịch vụ y tế là một trong những vấn đề đang được quan tâm tại các cơ sở y tế và có vai trò then chốt trong việc so sánh giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế. Vì vậy, chất lượng dịch vụ y tế là nhân tố tác động nhiều nhất đến sự hài lòng của người bệnh.

Thực tế cho thấy rằng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng vẫn có sự khác biệt. Chất lượng dịch vụ là khái niệm khách quan, mang tính lượng giá và nhận thức. Trong khi đó hài lòng là kết hợp của các thành phần chủ quan, dựa vào cảm giác và cảm xúc. Chất lượng dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, còn hài lòng chỉ đánh giá được sau khi đã sử dụng dịch vụ đó [12].

Đánh giá chất lượng chăm sóc sức khỏe rất khó, bởi vì chất lượng dịch vụ y tế không chỉ phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc mà còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bản thân người bệnh, sự quan tâm chăm sóc của người thân, sự chẩn đoán của thầy thuốc và cả điều kiện chăm sóc. Theo Donabian (1980), có 3 nhóm tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng trong chăm sóc sức khỏe, đó là [13]:

- *Nhóm tiêu chuẩn cấu trúc*: tập trung vào các tiêu chuẩn tổ chức, mô hình quản lí, trang thiết bị, cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe.

- *Nhóm tiêu chuẩn quy trình*: tập trung vào các tiêu chuẩn thực hành nghề nghiệp của bác sĩ, ĐD.

- *Nhóm tiêu chuẩn kết quả*: tập trung vào tình trạng sức khỏe của người bệnh, những lợi ích mà người bệnh nhận được từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sự hài lòng của người bệnh và đặc biệt là ý kiến của người bệnh rất có giá trị để đánh giá chất lượng.

Có nhiều phương thức để đánh giá chất lượng dịch vụ y tế, nhưng ngày nay, sự hài lòng của người bệnh là một nội dung quan trọng của chất lượng bệnh viện và được nhận biết như là một khía cạnh quan trọng của chất lượng chăm sóc sức khỏe [14].

1.1.3. Mối quan hệ giữa sự hài lòng và chất lượng dịch vụ

Theo Shemwell & cộng sự (1998) và Thongsamak (2001), chất lượng dịch vụ là khái niệm khách quan, mang tính lượng giá và nhận thức, trong khi đó, sự hài lòng là sự kết hợp của các thành phần chủ quan, dựa vào cảm giác và cảm xúc [9].

Các nhà nghiên cứu khác như Cronin, Taylor (1992), Spreng, Mackoy và Oliver (1996) cho rằng chất lượng dịch vụ là nguyên nhân (nguồn gốc) tạo nên sự hài lòng khách hàng, là tiền tố cho sự hài lòng khách hàng. Hiện vẫn chưa có được sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu về các khái niệm, nhưng đa số các nhà nghiên cứu cho rằng giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng có mối liên hệ với nhau [15], [16], [17], [18], [19].

Bên cạnh đó, một số nhà nghiên cứu như Parasuraman, Zeithaml, Berry, Bitner, Bolton ủng hộ quan điểm sự hài lòng của khách hàng dẫn đến chất lượng dịch vụ. Họ cho rằng chất lượng dịch vụ là sự đánh giá tổng thể dài hạn trong khi sự hài lòng của khách hàng chỉ là sự đánh giá một giao dịch cụ thể [20], [21].

Quan điểm nào đúng hiện vẫn chưa khẳng định vì cả hai quan điểm đều có cơ sở lý luận cũng như kết quả nghiên cứu chứng minh (Thongsamak, 2001) [22].

Do vậy, muốn nâng cao sự hài lòng khách hàng nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng có quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái được tạo ra trước và sau đó quyết định đến sự hài lòng của khách hàng [10], [23].

1.2. Sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế.

1.2.1. Các nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh.

Nghiên cứu ở trên thế giới.

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sự hài lòng của khách hàng đối với công tác chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện cũng như các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng.

Nghiên cứu của Al- Doghaither (2004) trên 400 người bệnh nội trú tại bệnh viện King Khalid, Ai Cập, đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế về các khía cạnh như: tiếp nhận, khám và chẩn đoán bệnh, giao tiếp và chăm sóc trong quá trình điều trị bệnh. Nghiên cứu này cho thấy người bệnh hài lòng về các dịch vụ trên ở mức độ rất khác nhau: điểm hài lòng trung bình cao nhất cho thủ tục tiếp đón người bệnh là 4,7 (theo thang điểm Likert 5 mức độ), và thấp nhất cho việc giao tiếp giữa nhân viên y tế và người bệnh 2,3 [24].

Thêm một nghiên cứu khác về "Nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng về nhân viên chăm sóc người cao tuổi ở thủ đô Băng Cốc" của tác giả Penchan S Monaiyapong được thực hiện vào tháng 8 năm 2002 tại Thái Lan cho thấy, toàn bộ sự hài lòng của khách hàng về chất lượng chăm sóc sức khỏe đều đạt mức từ trung bình đến hài lòng cao. Các khách hàng nhấn mạnh đến 3 khía cạnh, đó là: năng lực của cán bộ y tế chăm sóc lão khoa, sự đào tạo của cán bộ y tế lão khoa và trách nhiệm từ các tổ chức chính phủ [25].

Nghiên cứu của tác giả Santhat Sermsri thực hiện trên 236 người bệnh cho thấy kết quả, điểm trung bình sự hài lòng của người bệnh là 4,2 (theo thang điểm Likert 5 mức độ) và có 23,3% người bệnh hài lòng cao với các dịch vụ y tế. Người bệnh rất hài

lòng với nguồn lực y tế sẵn có (37,3%), môi trường tự nhiên (36,9%) và dịch vụ cung ứng quản lý (30,9%), chất lượng chăm sóc (24,1%), tài chính y tế (14,8%) và khả năng tiếp cận (13,9%) [26].

Thêm một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện để mô tả sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em của Asma Hasan tại Bangladesh, đã chỉ ra kết quả rằng, hầu hết người trả lời có thu nhập hàng tháng ít hơn 3000 taka đến 5000 taka, ở nhóm tuổi từ 20-24 và có trình độ tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài ra, phần lớn đối tượng nghiên cứu là phụ nữ nội trợ có 2 con, chỉ có dưới 30 phút tiếp cận được với trung tâm y tế, trong đó có 76,6% trả lời rằng rất hài lòng với hỗ trợ của nhà cung cấp và 57,8% rất hài lòng với những tiện nghi của trung tâm dịch vụ. Tóm lại, nghiên cứu này đã cho thấy phần lớn các bà mẹ đều hài lòng với sự tiện nghi và giúp đỡ của nhà cung ứng [27].

Tóm lại có nhiều nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng chăm sóc sức khỏe. Phạm vi của các nghiên cứu có sự khác nhau, từ việc chỉ đánh giá thái độ, sự giao tiếp của nhân viên cho đến sự đo lường cả sự hài lòng của người bệnh đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các dịch vụ khác trong bệnh viện. Các nghiên cứu thu được kết quả đa dạng, phong phú và đã phần nào làm cơ sở để các nhà quản lý bệnh viện lập kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh hơn nữa.

Các nghiên cứu tại Việt Nam

Ở Việt Nam, những nghiên cứu về sự hài lòng đối với chất lượng chăm sóc người bệnh đã được nhiều tác giả quan tâm.

Nghiên cứu của Phan Văn Tường năm 2002 cho thấy 10,5% đối tượng nghiên cứu nhận xét thời gian chờ đợi khám bệnh tại các bệnh viện công là lâu so sánh với 4,8% ở bệnh viện bán công và 0% ở bệnh viện tư; 4,1% đối tượng nghiên cứu nhận xét thời gian chờ đợi xét nghiệm tại các bệnh viện công là lâu so sánh với 1% ở bệnh viện bán công và 0% ở bệnh viện tư; 4,7% đối tượng nghiên cứu nhận xét thời gian chờ đợi làm thủ tục xuất viện tại các bệnh viện công là lâu so sánh với 1,4% ở bệnh viện bán công và 0% ở bệnh viện tư; 0,3% đối tượng nghiên cứu nhận xét về thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại các bệnh viện công là kém so sánh với 0% ở

bệnh viện bán công và ở bệnh viện tư; 2,2% đối tượng nghiên cứu biểu thị sự không tín nhiệm với bệnh viện công qua việc sẽ không giới thiệu người quen tới KCB, so sánh với 0,5% tại các bệnh viện bán công và 0% ở bệnh viện tư [28].

Nghiên cứu của Nguyễn Đức Thành về sự hài lòng của người bệnh nội trú với chất lượng CSSK tại các bệnh viện tỉnh Hòa Bình trên các yếu tố về thời gian chờ đợi, giao tiếp và tương tác với NVYT, CSVC và kết quả CSSK. Hòa Bình là một tỉnh miền núi, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân còn nhiều hạn chế, đó là tình trạng thiếu nhân lực, thiếu kinh phí, trang thiết bị thiếu là lạc hậu…vì thế mà có sự chênh lệch giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Với mức điểm tối thiểu để đạt trung bình hài lòng là 4 (theo thang điểm Likert 5 mức độ), kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các yếu tố về sựu hài lòng của người bệnh đều <4, trong đó điểm trung bình hài lòng chung về chất lượng CSSK là 3,6. Với kết quả này người bệnh chưa thật sự hài lòng với chất lượng CSSK tại bệnh viện [29].

Nghiên cứu của Trương Thị Bích Ngọc (2011) về đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú tại một số khoa của bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cho thấy: 50,7% người bệnh hài lòng đối với yếu tố thời gian chờ đợi khi tiếp cận dịch vụ; 39,7% người bệnh hài lòng với yếu tố thông tin; 77,2% người bệnh hài lòng với yếu tố chăm sóc và điều trị; 71,1% người bệnh hài lòng với yếu tố nhu cầu và 50% người bệnh hài lòng với yếu tố cơ sở vật chất [30].

Trong nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ KCB của Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Bạch Mai, tác giả Lý Thị Thúy cũng cho biết: Đa số người bệnh và người nhà của họ hài lòng với dịch vụ KCB tại Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Bạch Mai với từng yếu tố như: Giao tiếp của nhân viên y tế (84,1%); Cơ sở vật chất-trang thiết bị y tế (88,3%); Yếu tố tài chính (75,9%); Chất lượng phục vụ (85,8%). Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra rằng: Phần lớn người bệnh và người nhà của họ chưa hài lòng với thời gian chờ đợi khi tiếp cận với các dịch vụ KCB tại Khoa Khám bệnh, sự hài lòng rất thấp (chỉ chiếm 28,4%). Nhưng nhìn chung, đa số người bệnh và người thân của họ đều hài lòng chung với dịch vụ KCB tại Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Bạch Mai, với tỷ lệ là 79,3% [31].

Nghiên cứu của Trần Thị Hà Giang năm 2011, tại bệnh viện Da liễu Trung ương chỉ ra rằng: Hài lòng của người bệnh đối với thời gian chờ đợi thực hiện dịch vụ KCB đạt 21,3%. Hài lòng của người bệnh với thời gian chờ kết quả xét nghiệm 26,3%. Hài lòng của người bệnh với yếu tố giao tiếp và tương tác với NVYT là 43,8%. Hài lòng của người bệnh với yếu tố giao tiếp và tương tác với bác sĩ đạt 66,7%. Hài lòng của người bệnh với yếu tố CSVC/TTB/Môi trường của bệnh viện đạt 78,3%. Hài lòng của người bệnh với kết quả KCB đạt 57,3% [32].

Nghiên cứu khác của Trịnh Thị Thúy Hằng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương vào năm 2014 cũng cho thấy, tỷ lệ khách hàng hài lòng với sự thuận tiện trong khám bệnh tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện là 49,52%. Hài lòng với chi phí khám bệnh là 46,17%; Hài lòng với thời gian khám bệnh đạt tỷ lệ hài lòng là 31,10%, trong khi hài lòng với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của Khoa Khám bệnh theo yêu cầu là 42,82%. Ngoài ra, tỷ lệ khách hàng hài lòng với thái độ của, hướng dẫn của nhân viên y tế và chất lượng kỹ thuật khám bệnh là 53,59%. Tóm lại, tỷ lệ hài lòng chung là 46,65% [33].

Tác giả Trần Thị Cẩm Tú thực hiện nghiên cứu tại bệnh viện Trung ương Huế vào năm 2012 đã cho biết, tỷ lệ 86,4% người bệnh hài lòng chung về dịch vụ KCB tại bệnh viện; Trong đó tỷ lệ hài lòng chung về tiếp cận dịch vụ và thuận tiện là 86,9%; Thời gian chờ là 85,2%; Chi phí xét nghiệm là 67,4%; Giao tiếp với nhân viên y tế là 83,5%; Giao tiếp với bác sỹ là 87,9%; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ, vệ sinh 82,0% và về kết quả điều trị là 89,4% [34].

Tác giả Nguyễn Văn Phi và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu trên 277 người bệnh tại Trung tâm y tế quận Từ Liêm thành phố Hà Nội năm 2015, kết quả cho thấy sự hài lòng của người bệnh với: Thời gian tiếp cận dịch vụ y tế là 41,2 đến 82,5%; Hài lòng về sự giao tiếp, tương tác với nhân viên y tế khá cao với 89,7% đến 94,5%; Hài lòng về sự giao tiếp, tương tác với bác sỹ là 86,9-93,7% và tỷ lệ hài lòng chung đạt rất cao, gần 98% [35].

Nghiên cứu tại các khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên của Đinh Ngọc Thành và cộng sự trên tổng số 123 người bệnh hiện đang điều trị

nội trú cho biết, người bệnh chỉ hài lòng với sự giao tiếp của điều dưỡng ở mức độ trung bình [36].

Ngoài ra, tác giả Nguyễn Ngọc Lý đã tiến hành nghiên cứu sự hài lòng trên tổng số 188 người bệnh đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết có một vài kết quả liên quan đến sự hài lòng, như: Hài lòng chung của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng (65%); Hài lòng về chăm sóc tinh thần của điều dưỡng (79,8%); Hài lòng về thực hiện hoạt động chăm sóc của điều dưỡng (64,44%); Mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng (70,7%); Tư vấn giáo dục sức khỏe (66,5%) và hài lòng với thực hiện trợ giúp người bệnh trong các hoạt động như hỗ trợ ăn uống, đi lại, vệ sinh. Hài lòng với yếu tố điều dưỡng hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà người bệnh chỉ đạt 51,6% [37].

Tác giả Nguyễn Bá Anh thực hiện nghiên cứu tại 3 khoa lâm sàng của Bệnh viện Việt Đức năm 2012, gồm có khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, khoa Chấn thương Chỉnh hình I và khoa Điều trị theo yêu cầu trên tổng số 424 người bệnh hiện đang điều trị tại đây đã cho biết: Hài lòng chung đối với chất lượng chăm sóc của điều dưỡng là 93,5%; Hài lòng với tình trạng vệ sinh của khoa/phòng chiếm tỷ lệ cao nhất với 97,1%; Hài lòng với các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng đạt tỷ lệ hài lòng là gần 96%; Hài lòng với tinh thần, thái độ của điều dưỡng là 94%; Hài lòng với giao tiếp của điều dưỡng chiếm tỷ lệ thấp nhất với 91,4% [3].

Tác giả Phạm Nhật Yên thực hiện nghiên cứu trên 206 người bệnh đến khám và điều trị tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người bệnh kém hài lòng nhất với: Thời gian tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, với chỉ 30,1%; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế (53,1%); Kết quả chăm sóc sức khỏe (69,8%); Giao tiếp và tương tác với bác sỹ (81,3%); Giao tiếp và tương tác với nhân viên y tế (83,7%) và hài lòng chung với chất lượng KCB đạt tỷ lệ trên 91% [38].

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hân và cộng sự nghiên cứu trên tổng số 3815 người bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim mạch An Giang, cho biết: Người bệnh

hài lòng về thời gian chờ khám bệnh là chưa cao, đa số đánh giá lâu và rất lâu chiếm 65,2% [39].

Tác giả Nguyễn Công Thịnh nghiên cứu trên 168 người bệnh tại Phòng khám Nội-Nhi của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Thành phố Hà Nội đã chỉ ra kết quả là tỷ lệ hài lòng chung về dịch vụ KCB đạt 61,9% còn hài lòng với thời gian chờ đợi phần lớn đạt trên 60% [40].

Tác giả Phạm Hữu Trung thực hiện nghiên cứu trên toàn bộ người bệnh AFB (+) điều trị nội trú và ra viện trong khoảng thời gian từ 01/02/2011 đến hết ngày 30/04/2011 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết: Người bệnh hài lòng với chất lượng dịch vụ điều trị lao phổi AFB (+) là 76,5%; Thời gian chờ đợi đạt được sự hài lòng cao hơn với trên 82,5%; Giao tiếp với nhân viên y tế; Giao tiếp với bác sỹ đạt tỷ lệ hài lòng gần 90%; Hài lòng với cơ sở vật chất là khoảng 75%. Và nhìn chung, người bệnh hài lòng với kết quả chăm sóc sức khỏe là rất cao, với 94% [41].

Một nghiên cứu của Nguyễn Thế Vinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk trên 165 người bệnh cho biết, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh là khoảng 64%, trong đó, hài lòng chung với tính tin tưởng là 64,39%, còn với các yếu tố như đáp ứng, đảm bảo, cảm thông và công tác KCB đều đạt tỷ lệ hài lòng trên 50% [42].

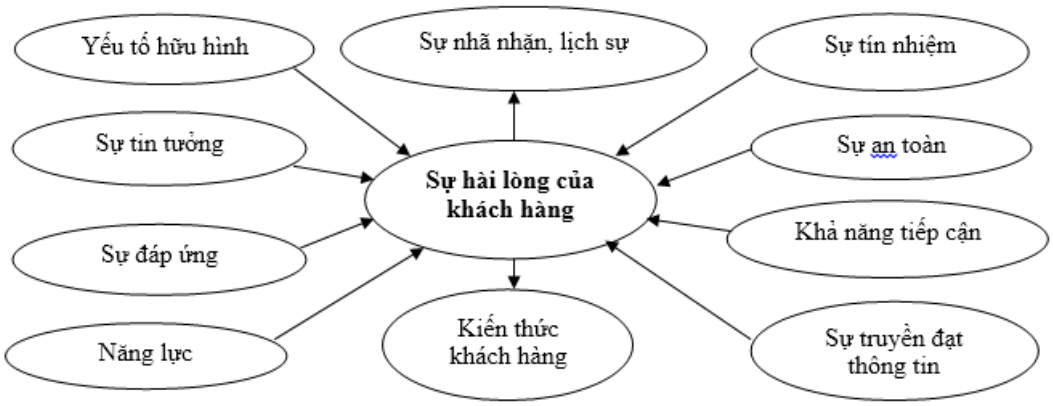
Tác giả Nguyễn Văn Đông thực hiện nghiên cứu trên 105 người bệnh của Khoa Y học cổ truyền-Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ ra những kết quả khá đa dạng. Tác giả cho biết, người bệnh hài lòng với: Thời gian tiếp cận KCB, chăm sóc là 73,2%; Tiếp cận, tương tác với nhân viên khoa đạt tỷ lệ hài lòng cao nhất với 76,6%; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế là 69,1%; Kết quả sau thời gian điều trị nội trú là 75,1% và hài lòng chung về cung cấp dịch vụ KCB nội trú là 75,4% [43].

Nghiên cứu sự hài lòng được thực hiện trên nhiều người bệnh được khám và điều trị tại các khoa phòng khác nhau: Nội tổng hợp, Ngoại tổng quát, Da liễu, Y học cổ truyền, Tim mạch, Phổi… ở rất nhiều địa điểm: Bệnh viện, Phòng khám, Khoa khám bệnh, Trung tâm y tế… Kết quả cho thấy, ở từng địa điểm và từng đối tượng, mức độ hài lòng của người bệnh là khác nhau.

Như vậy, qua nhiều y văn nghiên cứu tại nước ta cũng như trên thế giới với những bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng sự hài lòng của người bệnh là một vấn đề rất quan trọng và nhận được rất nhiều mối quan tâm của cộng đồng.

1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh.

Các nghiên cứu trên thế giới



Hình 1.1. Khung lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng (Nguồn: Jayaraman Munusamy & Vong Oi Fong, UNITAR E-Journal, Vol. 4, No. 2, June 2008).

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng bao gồm thời gian tiếp cận dịch vụ y tế, cơ sở vật chất, tiếp cận với nhân viên y tế, chất lượng cuộc sống, hiệu quả và chi phí điều trị [44], [45], [46], [47].

Nghiên cứu của Syed Saad Andaleed tại Bangladesh về sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ CSSK năm 2001. Nghiên cứu này chỉ ra rằng có những yếu tố về chất lượng dịch vụ CSSK có ảnh hưởng quan trọng tới người bệnh và nó cũng liên quan đến sự hài lòng của người bệnh trong bối cảnh của Bangladesh. Đánh giá trên người bệnh ở các khía cạnh của chất lượng dịch vụ họ nhận được bao gồm: đáp ứng, đảm bảo, kỷ luật, truyền thông. Nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố và hồi quy đa biến, những mối liên quan có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng người bệnh đã tìm thấy cả ở 5 khía cạnh trên [48].

Nghiên cứu của Harkey và Vraciu (1992) trên 82 bệnh viện thuộc 21 bang của Mỹ về mối liên quan giữa quan niệm của người bệnh, nhân viên y tế và nguồn thu của bệnh viện [49]. Kết quả tương tự cũng được Nelson và CS (1992) thu được khi

nghiên cứu trên 15.000 người bệnh điều trị tại 51 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa ngoại ở Mỹ về mối liên quan giữa sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng công tác khám và điều trị, thủ tục thanh toán khi ra viện và nguồn thu của bệnh viện. Khi chất lượng dịch vụ y tế được đảm bảo, sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ tăng và họ sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ mà họ sử dụng. Mặt khác, khi người cung cấp dịch vụ y tế cam kết tăng cường chất lượng dịch vụ y tế, họ sẽ làm giảm các dịch vụ không cần thiết qua đó làm giảm chi phí. Điều này dẫn đến giá dịch vụ y tế có thể giảm, chất lượng các dịch vụ y tế được đảm bảo đồng thời chi phí giảm có nghĩa là hiệu quả chăm sóc sức khỏe tăng [50].

Ngoài ra, nghiên cứu do Tengilimoglu về chăm sóc điều dưỡng (2001) thực hiện trên 420 người bệnh ra viện từ Bệnh viện đa khoa trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho thấy đa số người bệnh hài lòng với thái độ, sự giao tiếp của nhân viên và bác sĩ trong quá trình chăm sóc người bệnh, mặc dù sự hài lòng có khác nhau giữa những người bệnh có trình độ học vấn khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều người bệnh không hài lòng với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ ăn uống…[51]

Theo Ke – Ping (1999) để đánh giá chất lượng chăm sóc về sự hiểu biết của người bệnh là sự đánh giá chủ quan, còn sự hài lòng của người bệnh là sự đánh giá khách quan. Trong đó, hiểu biết của người bệnh có thể xuất phát từ việc nhận các thông tin được cung cấp bởi các nhân viên y tế như: thông tin về quy trình KCB, tình trạng bệnh tật, các chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp. Tuy nhiên, việc tiếp nhận thông tin này lại khác nhau ở mỗi cá nhân người bệnh. Mặt khác, thông tin có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau chứ không chỉ từ nhân viên y tế, do đó nó chỉ được coi như sự đánh giá một cách chủ quan, nếu người bệnh có khả năng tiếp nhận được nhiều thông tin sẽ có hiểu biết tốt hơn và ngược lại. Còn đối với sự hài lòng của người bệnh, bắt nguồn từ những cảm nhận tự nhiên của họ đối với thái độ phục vụ, chất lượng KCB. Có thể những cảm nhận này là khác nhau ở mỗi cá nhân nhưng lại có thể tương tự nhau ở những trình độ khác nhau, đó chính là khía cạnh khách quan trong sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe [52].

Tác giả Penchan S Monaiyapong và cộng sự nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng tại Băng Cốc, Thái Lan năm 2002 chỉ ra, các đặc điểm nhân khẩu của thành viên gia đình không có mối liên quan tới sự hài lòng của người bệnh với chất lượng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, thu nhập của người bệnh lão khoa lại liên quan có ý nghĩa thống kê với yếu tố hữu hình, sự trách nhiệm, sự bảo đảm và sự thấu cảm (lần lượt là r=0,274, p<0,05; r=0,276, p<0,05; r=0,323, p<0,001; r=0,276, p<0,05) [25].

Tác giả Santhat Sermsri và các cộng sự trong nghiên cứu của mình trên khoảng 240 người bệnh đã chỉ ra một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng: người bệnh nữ, có trạng thái tinh thần tốt, sự kỳ vọng cao và chi phí vận chuyển cao có mối liên quan đáng kể với mức độ rất hài lòng (lần lượt p=0,026, p=0,015 và p=0,0001). Phần lớn kiến nghị của người bệnh là phàn nàn về thời gian chờ đợi để được bác sỹ khám và tiếp cận với dược sỹ, thời gian bắt đầu làm việc của bác sỹ muộn và sự quản lý kém của bác sỹ và điều dưỡng [26].

Nghiên cứu của Asma Hasan đã tìm ra rằng, có mối liên quan có ý nghĩa giữa sự hài lòng và các tiện nghi của dịch vụ (p<0,05). Không có mối liên quan đáng kể giữa tuổi của người bệnh, trình độ học vấn, thu nhập, công việc, sự mong đợi với dịch vụ và sự trợ giúp của nhà cung cấp [27].

Các nghiên cứu tại Việt Nam

Tác giả Đặng Hồng Anh (2013) nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ KCB tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bao gồm 38 biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm trong nghiên cứu, đã sử dụng mô hình thang đo SERVQUAL đánh giá nhân tố chất lượng chức năng (bao gồm 5 thành phần là tin cậy, đáp ứng, đảm bảo, cảm thông và hữu hình được đo lường bởi 27 biến quan sát), nhân tố chất lượng kỹ thuật (được đo lường bởi 3 biến quan sát), nhân tố hình ảnh (được đo lường bởi 2 biến quan sát), nhân tố mức độ hài lòng (được đo lường bằng 6 biến quan sát) [22].

So sánh kết quả của các mô hình đo lường trong nghiên cứu cho thấy, sau khi bổ sung và điều chỉnh, các thang đo đều đạt được độ tin cậy và giá trị cho phép. Mức độ hài lòng của người bệnh chịu ảnh hưởng bởi chất lượng chức năng, chất

lượng kỹ thuật, hình ảnh (trong đó nhân tố hình ảnh tác động mạnh nhất đến chất lượng dịch vụ từ đó gây tác động mạnh đến sự hài lòng của người bệnh) [22].

Nghiên cứu của Trương Thị Bích Ngọc (2011) chỉ ra rằng, có mối liên quan giữa sự hài lòng chung đối với dịch vụ KCB: Giới tính, nhân khẩu, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, đối tượng BHYT. Cụ thể, người bệnh BHYT được ghi nhận là hài lòng hơn ($p<0,05$; OR= 11,59). Trình độ học vấn và nghề nghiệp có liên quan đến sự hài lòng ($p<0,05$). Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thời gian chờ đợi và sự hài lòng của người bệnh tại các bàn khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thu viện phí và BHYT ($p<0,05$). [30].

Nghiên cứu của Lý Thị Thúy tìm hiểu về sự hài lòng của người bệnh và người nhà của người bệnh với các dịch vụ y tế tại Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Bạch Mai vào năm 2014, đã chỉ ra rằng, một số yếu tố nhân khẩu học như: Địa chỉ, giới, trình độ học vấn, thu nhập, số lần sử dụng dịch vụ y tế và hình thức sử dụng dịch vụ cũng có mối liên quan ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Khoa Khám bệnh (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với $p<0,05$) [31].

Nghiên cứu của tác giả Trần Thị Hà Giang thực hiện vào năm 2011 tại bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy tỷ lệ hài lòng chung với dịch vụ KCB của người khám theo yêu cầu cao hơn những người khám thông thường 2,84 lần; Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p =0,001$). Chưa tìm thấy mối liên quan giữa sự hài lòng chung của người bệnh đối với các yếu tố về nhóm tuổi, giới, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, khu vực sống và số lần đến khám ($p > 0,5$) [32].

Ngoài ra, tác giả Bùi Thị Cẩm Tú và cộng sự trong nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác KCB của bệnh viện Trung ương Huế vào năm 2012 cũng cho biết: Một số yếu tố liên quan đến sự không hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ KCB như nhóm tuổi, học vấn, giao tiếp tương tác với nhân viên y tế, người bệnh sống ở Huế, người bệnh nằm ở phòng bệnh thường. ($p<0,05$) [34].

Nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh tại khoa KCB theo yêu cầu, bệnh viện Phụ sản Trung ương vào năm 2014, tác giả Trịnh Thị Thúy Hằng chỉ ra rằng chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 5 yếu tố hài lòng của khách hàng về

sự thuận tiện trong khám bệnh, chi phí khám bệnh, thời gian chờ đợi, cơ sở vật chất và thái độ hướng dẫn của nhân viên y tế, chất lượng kỹ thuật khám bệnh với các yếu tố về nhân khẩu học của khách hàng như nhóm tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân, khu vực sinh sống, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số lần đến khám, lý do chọn nơi khám, điều trị và hình thức khám bệnh. Tuy nhiên, tác giả lại chỉ ra: Có mối liên quan mật thiết có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ hài lòng chung của khách hàng với 5 yếu tố về sự thuận tiện trong khám bệnh, chi phí khám bệnh, thời gian chờ đợi khám bệnh, cơ sở vật chất và thái độ, hướng dẫn của nhân viên y tế, Chất lượng kỹ thuật khám bệnh với $p<0,05$. Mặt khác, các yếu tố như thời gian chờ đợi khám bệnh và cơ sở vật chất phục vụ KCB có mối liên quan chặt chẽ nhất với sự hài lòng của người bệnh [33].

Nghiên cứu "Đánh giá và sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của ĐD tại một số khoa lâm sàng Bệnh viện Việt Đức năm 2012" của tác giả Nguyễn Bá Anh đã chỉ ra rằng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng hôn nhân với sự hài lòng chung của người bệnh về chất lượng chăm sóc của ĐD ($p<0,05$) [3].

Tác giả Nguyễn Khánh Chi thực hiện "Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội năm 2011", cho thấy: Người bệnh có tuổi từ 50 trở lên và người KCB 2 lần trở lên không hài lòng với giao tiếp, tương tác với bác sỹ và yếu tố cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều hơn so với người bệnh dưới 50 tuổi và người bệnh KCB lần đầu ($p<0,05$) [53].

Một nghiên cứu khác của Đinh Ngọc Thành và cộng sự về đề tài "Giao tiếp của điều dưỡng và sự hài lòng của người bệnh nội trú tại các khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên"cho thấy có liên quan chặt chẽ giữa sự hài lòng của người bệnh với giao tiếp của điều dưỡng ($p<0,01$) [36].

Ngoài ra, tác giả Bùi Thị Dương Vân đã tiến hành "Đánh giá sự hài lòng của người bệnh với hoạt động KCB tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2011", kết quả chỉ ra: Có mối liên quan giữa tỷ lệ hài lòng chung về hoạt động khám bệnh với 5 yếu tố về sự thuận tiện khám bệnh, chi phí khám bệnh, thời gian chờ khám bệnh, cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh và thái độ hướng dẫn của nhân viên y tế ($p<0,01$) [54].

Tác giả Bùi Thị Thu Hương cũng thực hiện nghiên cứu về "Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ KCB tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2009", tác giả chỉ ra rằng nhóm tuổi càng cao thì có xu hướng có điểm trung bình hài lòng càng lớn và điểm trung bình hài lòng của nhóm "nông dân" có xu hướng cao hơn các nhóm khác với sự khác biệt ở mức vừa phải ($p<0,05$) [55].

Tác giả Trương Thị Bích Ngọc nghiên cứu về "Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ KCB tại một số khoa của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp" năm 2011, cho biết, có mối liên quan về tỷ lệ hài lòng đối với dịch vụ KCB và các đặc điểm xã hội người bệnh như: Nhóm tuổi, khu vực sinh sống, nghề nghiệp, các nhóm thu nhập trung bình/tháng; Người bệnh chưa hài lòng với yếu tố thời gian chờ đợi, khả năng không hài lòng cao gấp 5,1 lần so với nhóm hài lòng với yếu tố chờ đợi (OR=5,1); Người bệnh chưa hài lòng với yếu tố thông tin, khả năng không hài lòng cao gấp 10,4 lần so với nhóm hài lòng với các yếu tố thông tin (OR=10,4); Người bệnh chưa hài lòng với yếu tố chăm sóc và điều trị, khả năng không hài lòng chung cao gấp 19,7 lần so với nhóm hài lòng ở yếu tố này; Người bệnh chưa hài lòng với yếu tố nhu cầu, khả năng không hài lòng cao gấp 38 lần so với nhóm hài lòng ở yếu tố này và người bệnh chưa hài lòng với yếu tố cơ sở vật chất, khả năng không hài lòng cao gấp 38 lần so với nhóm hài lòng ở yếu tố này ($p<0,05$) [30].

Nghiên cứu của Phạm Hữu Trung về "Đánh giá sự hài lòng của người bệnh lao phổi AFB (+) điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2011", chỉ ra: Có mối liên quan mật thiết giữa tỷ lệ hài lòng về chất lượng chăm sóc sức khỏe với các yếu tố thời gian chờ đợi tiếp cận dịch vụ, giao tiếp và chăm sóc của nhân viên y tế, giao tiếp và điều trị của bác sỹ, điều kiện cơ sở vật chất và kết quả chăm sóc sức khỏe ($p<0,001$) [41].

Có thể thấy, hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng sự hài lòng của người bệnh ít bị tác động bởi các yếu tố như giới, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, số nhân khẩu trong gia đình…Còn các yếu tố có ý nghĩa thống kê, ảnh hưởng nhiều đến mức độ hài lòng của người bệnh như: Thời gian chờ đợi khám bệnh, tương tác

và giao tiếp với bác sỹ và điều dưỡng, cơ sở vật chất/trang thiết bị/môi trường, kết quả điều trị/chăm sóc sức khỏe, hiệu quả và chi phí khám chữa bệnh.

1.4. Sơ lược về địa điểm thực hiện nghiên cứu: Khoa Phẫu thuật Cột sống-Viện Chấn thương Chỉnh hình- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

1.4.1. Viện Chấn thương Chỉnh hình (CTCH)

Viện CTCH thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (sau đây được gọi là Bệnh viện Việt Đức) được thành lập theo Quyết định số 3636/QĐ – BYT ngày 30 tháng 09 năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động ngày 24/12/2010 có con dấu, có tài khoản riêng.

Cơ cấu tổ chức của Viện Chấn thương Chỉnh hình

Ban lãnh đạo viện: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng

Bộ máy hành chính: 01 văn phòng Viện và 07 khoa lâm sàng

Các khoa lâm sàng:

- Khoa Phẫu thuật Cột sống
- Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú
- Khoa Phục hồi chức năng
- Khoa Tạo hình Hàm mặt

Khoa Phẫu thuật CTCH 1

Khoa Phẫu thuật CTCH 2

Khoa Phẫu thuật CTCH 3

Quy mô hoạt động

Tổng số cán bộ, nhân viên của Viện: 217 người trong đó có 56 bác sỹ (25.8%), 160 ĐD (73.4%)[1] số còn lại là nhân viên văn phòng và trợ giúp chăm sóc.

Năm 2014, Viện CTCH có 194 giường bệnh nội trú thực kê, luôn trong tình trạng quá tải, tỷ lệ quá tải trong 6 tháng đầu năm 2014 là 115%[2]. Số người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú 6 tháng đầu năm 2014 là 34624 người bệnh[3]

Khoa Phẫu thuật Cột sống – Viện Chấn thương Chỉnh hình

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, gắn liền với sự tiến bộ của kỹ thuật y học hiện đại đã nhanh chóng cải thiện và đem lại chất lượng cuộc sống cho những

[1] Thống kê phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện HN Việt đức

[2] Thống kê phòng Kế hoạch Tổng hợp – Bệnh viện HN Việt đức

[3] Thống kê phòng Công nghệ thông tin – Bệnh viện HN Việt Đức

người bệnh mắc các bệnh lý và chấn thương cột sống bằng phẫu thuật cột sống, mà trước đây tại Việt nam chỉ chủ yếu là điều trị nội khoa. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của nhân dân, năm 2003 Phó Giáo sư.Viện sỹ Tôn Thất Bách, nguyên Giám đốc bệnh viện Việt Đức, đã thành lập Đội Phẫu thuật Cột sống. Đây cũng chính là tiền thân của Khoa Phẫu thuật Cột sống.

Kể từ khi thành lập, Đội Phẫu thuật Cột sống đã phẫu thuật hơn 1000 trường hợp chấn thương cột sống, cùng hàng trăm các trường hợp bệnh lý về cột sống khác. Với những kinh nghiệm ban đầu đó cùng với nhu cầu lớn của nhân dân cần được chăm sóc sức khỏe về vấn đề cột sống, ngày 20-9-2007, Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã ký quyết định thành lập Khoa Phẫu thuật Cột sống.

Khái quát tổ chức

Năm 2014, nhân sự của khoa PTCS có 51 cán bộ nhân viên, trong đó có 16 bác sỹ và 33 ĐD, 1 nhân viên tin học và 1 nhân viên văn phòng. Khoa PTCS có chức năng, nhiệm vụ khám – chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều trị và phẫu thuật cột sống. Khoa có 01 phòng khám chuyên khoa với nhiệm vụ tiếp nhận và khám bệnh cho người bệnh ngoại trú. Từ tháng 2 năm 2015, khoa PTCS chuyển sang khu nhà kỹ thuật cao với 82 giường bệnh có điều hòa, cơ sở vật chất khang trang và trang thiết bị hiện đại. Sáu tháng đầu năm 2015, công suất sử dụng giường bệnh đạt 120%[4].

Các phẫu thuật bệnh lý được thực hiện tại Khoa:

- Bệnh lý đĩa đệm: Thoát vị đĩa đệm, trượt thân đốt sống…
- Bệnh lý về thoái hóa cột sống, hẹp ống sống, xẹp đốt sống..
- Các biến dạng cột sống: Vẹo cột sống, gù thân đốt sống…
- Các bệnh lý liên quan đến u: U thân đốt sống, u thần kinh trong ống sống…

Các kỹ thuật hiện đại được ứng dụng trong phẫu thuật cột sống:

- Nội soi lấy nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.
- Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng sóng cao tần.

[4] Thống kê phòng Kế hoạch tổng hợp, 6 tháng đầu năm 2015

- Phẫu thuật với đường mổ nhỏ có sử dụng hệ thống ống nong, bắt vít qua da.
- Ứng dụng robot định vị chính xác trong phẫu thuật cột sống.
- Thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ.
- Tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học có bóng hoặc không có bóng.
- Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống. Chỉnh vẹo có sử dụng robot định vị.

Hàng năm, Khoa Phẫu thuật Cột sống tiếp nhận khoảng 3500 người bệnh điều trị nội trú, trong đó số người bệnh có chỉ định phẫu thuật chiếm tỷ lệ khoảng 75%. Vì vậy, phẫu thuật cột sống có thể mang lại sự thay đổi một cách tích cực chất lượng cuộc sống cho người bệnh nên sự hài lòng của người bệnh đóng vai trò rất quan trọng.

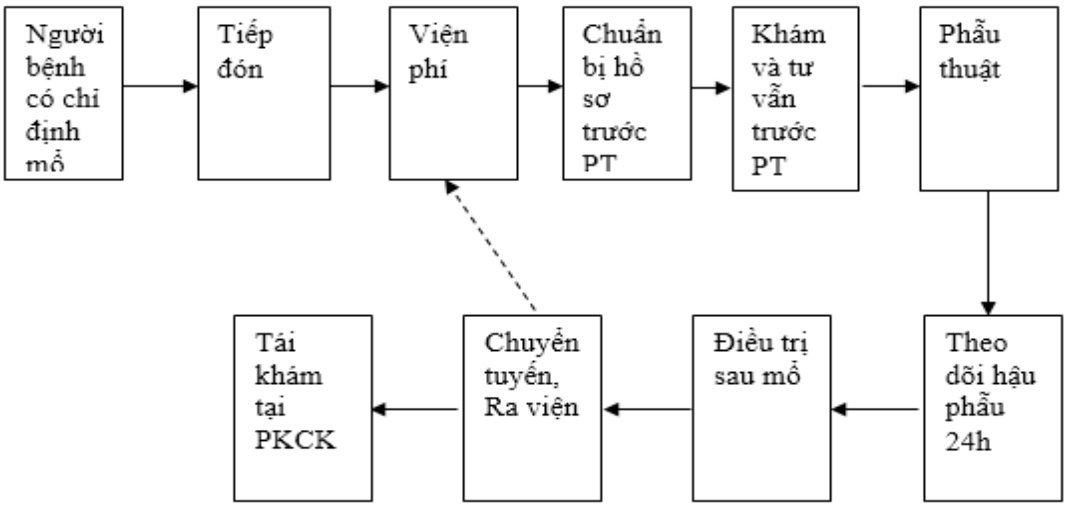
Các hình thức KCB tại Khoa Phẫu thuật Cột sống

KCB cho người bệnh BHYT đúng tuyến: người bệnh tham gia BHYT được tuyến y tế cơ sở chuyển lên theo đúng lộ trình quy định của Cơ quan Bảo hiểm.

KCB cho người bệnh BHYT trái tuyến: người bệnh tham gia BHYT không điều trị tại tuyến y tế cơ sở mà đi thẳng lên Bệnh viện Việt Đức để khám và điều trị.

KCB cho người bệnh tự chi trả bao gồm người bệnh không tham gia BHYT và người bệnh có tham gia BHYT nhưng không sử dụng thẻ BHYT.

Quy trình tiếp nhận và điều trị nội trú tại Khoa Phẫu thuật Cột sống

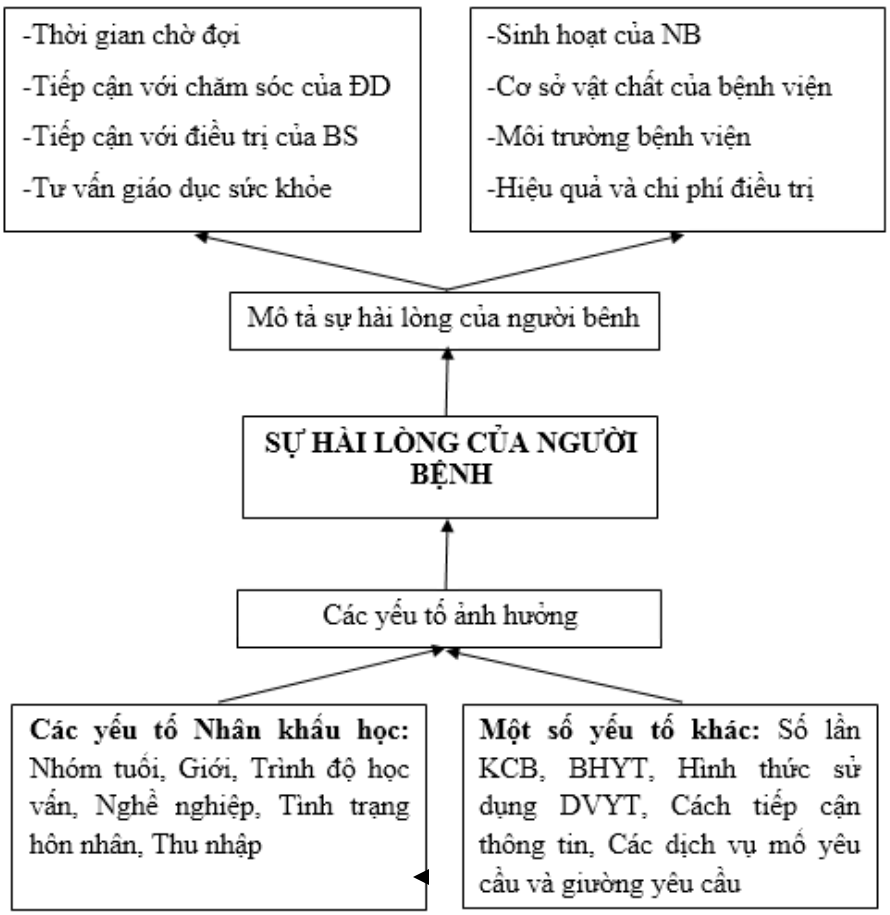


Hình 1.2. Quy trình tiếp nhận, khám và điều trị nội trú tại Khoa Phẫu thuật Cột sống

Người bệnh nội trú là người bệnh có chỉ định nhập viện để điều trị. Thời gian điều trị nội trú được tính từ thời điểm nhập viện đến khi hoàn thành xong thủ tục viện phí, nhận giấy ra viện và xuất viện. Trong nghiên cứu này đối tượng nghiên cứu là người bệnh phẫu thuật các bệnh lý về cột sống.

Chương 2
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Khung lý thuyết



Sơ đồ 2.1: Khung lý thuyết nghiên cứu

Khung lý thuyết cho nghiên cứu này dựa trên các mô hình nghiên cứu trước đó, kết hợp với thực tế tại Khoa Phẫu thuật Cột sống. Sự hài lòng của người bệnh được nghiên cứu theo hai mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của người bệnh và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng. Mô tả sự hài lòng được phân tích theo 8 yếu tố là: Thời gian chờ đợi; Tiếp cận với chăm sóc của điều dưỡng; Tiếp cận với điều trị của bác sỹ; Tư vấn giáo dục sức khỏe; Sinh hoạt của người bệnh; Cơ sở vật chất của bệnh viện; Môi trường bệnh viện; Hiệu quả và chi phí điều trị. Các yếu tố liên quan, có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng, bao gồm có: Các yếu tố nhân khẩu học (Nhóm tuổi, giới tính,…) và một số các yếu tố khác (Số lần KCB, BHYT,…)

2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2.1.1. Người bệnh: Tiến hành nghiên cứu định lượng là chính, có kết hợp định tính, mục đích nghiên cứu người bệnh.

**** Tiêu chuẩn lựa chọn:*** Người bệnh được lựa chọn khi đảm bảo đủ tất cả các tiêu chuẩn sau đây:

- Người bệnh được điều trị phẫu thuật các bệnh lý cột sống tại khoa PTCS.
- Người bệnh hoàn thành đợt điều trị nội trú và xuất viện. Với người bệnh <18 tuổi hoặc người bệnh không nắm rõ được quá trình nhập viện thì lấy ý kiến thân nhân của họ (sau đây gọi chung là người bệnh).
- Người bệnh đồng ý tham gia vào nghiên cứu.
- Người bệnh không có các dấu hiệu tổn thương về tinh thần và nhận thức

**** Tiêu chuẩn loại trừ:*** Người bệnh thuộc đối tượng nghiên cứu không được chọn khi có một trong các tiêu chuẩn loại trừ sau đây:

- Người bệnh hoặc thân nhân không đồng ý tham gia vào nghiên cứu.
- Người bệnh đang hôn mê, không tỉnh táo hoặc đang cấp cứu.
- Người bệnh luân chuyển khoa trong quá trình điều trị.
- Người bệnh có rối loạn tâm thần, nhận thức.
- Người bệnh đang gặp rắc rối về vấn đề pháp lý (bị giám sát, khởi tố, có án...)

2.2.1.2 Cán bộ y tế tại bệnh viện: Tiến hành nghiên cứu định tính là chính bao gồm:

- 1 Lãnh đạo Viện Chấn thương Chỉnh hình.
- 1 Lãnh đạo Khoa Phẫu thuật Cột sống.
- 05 Bác sỹ điều trị
- 05 Điều dưỡng-Kỹ thuật viên của khoa

**** Tiêu chuẩn lựa chọn***

- Các nhân viên y tế đang công tác trong đó có đại diện Lãnh đạo Viện CTCH, Lãnh đạo khoa PTCS và đại diện nhân viên của khoa.
- Các nhân viên có chứng chỉ hành nghề. Thời gian công tác tại khoa từ 5 năm trở lên.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu và có mặt tại khoa trong thời gian nghiên cứu

Tiêu chuẩn loại trừ: khi cán bộ y tế có một trong các tiêu chuẩn loại trừ sau:

- Các nhân viên không đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Các nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề.
- Các nhân viên không có mặt tại khoa trong thời gian tiến hành nghiên cứu

2.2.1.3. Sổ sách thống kê: Tiến hành nghiên cứu định lượng. Mục đích nghiên cứu là sổ sách.

*** Tiêu chuẩn lựa chọn**

- Có liên quan mật thiết tới nội dung nghiên cứu từ tháng 10/2014 đến tháng 09/2015 theo số liệu thống kê của bệnh viện: sổ vào-ra người bệnh hàng ngày của Khoa, thống kê báo cáo hàng ngày và định kỳ của phòng Kế hoạch Tổng hợp
(số liệu lấy theo danh mục thống kê ở bảng trống - xem phần phụ lục)

***Tiêu chuẩn loại trừ**

- Tài liệu, sổ sách, số liệu không rõ ràng, không đầy đủ thông tin, không phù hợp với thời gian nghiên cứu.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian: tháng 10/2014 đến tháng 09/2015
- Địa điểm: Khoa Phẫu thuật Cột sống, Viện CTCH-Bệnh viện Việt Đức.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính.

2.4.2. Cỡ mẫu

- Cỡ mẫu nghiên cứu đối với người bệnh.

Số người bệnh được tính theo công thức:

$$n = Z^2(1-\alpha/2)\times\frac{p.q}{(\varepsilon.p)^2}$$

Trong đó:

p: Tỷ lệ người bệnh và thân nhân chưa hài lòng với các dịch vụ y tế tại khoa PTCS. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào tương tự tại khoa PTCS, cho nên chúng tôi lấy p = 0,5 để cỡ mẫu lớn nhất

q: 1-p = 1- 0,5 = 0,5

ε: sai số ước lượng, trong nghiên cứu này chọn ε= 0,1

α: mức ý nghĩa thống kê (Chọn α = 0,05).

Z (1-α/2) tra theo bảng chuẩn = 1,96.

Thay số vào công thức, ta tính được số mẫu tối thiểu cần thu thập nghiên cứu là 384.

Để dự phòng một tỷ lệ nhất định người bệnh từ chối hoặc không tiếp cận được, cỡ mẫu sẽ được tăng lên 10% và làm tròn 450. Thực tế trong nghiên cứu này đã tiến hành trên 457 người bệnh.

- Cỡ mẫu cho phỏng vấn sâu cán bộ y tế

Các nhân viên y tế gồm: 1 lãnh đạo Viện, 1 lãnh đạo Khoa, 05 bác sỹ điều trị, 5 ĐD – KTV đang làm việc tại Khoa

2.4.3. Chọn mẫu

2.4.3.1. Chọn mẫu cho đối tượng người bệnh: Nghiên cứu định lượng là chủ yếu có kết hợp định tính.

Xác định cỡ mẫu dựa trên tỷ lệ người bệnh tới phẫu thuật bệnh lý tại khoa theo thống kê cùng kỳ năm 2013.

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiênhệ thống.

- Tính khoảng cách mẫu: **k = N/n = 2647/450 = 5,88**

Trong đó: - N = 2647, là tổng số người bệnh đã phẫu thuật bệnh lý cột sống tại Khoa Phẫu thuật Cột sống theo thống kê cùng kỳ năm 2013

- n=450, là cỡ mẫu của nghiên cứu.

- Cách tiến hành chọn mẫu:

Bước 1: Chọn ngẫu nhiên một người bệnh theo số thứ tự trong danh sách NB sau mổ phẫu thuật bệnh lý cột sống xuất viện bắt đầu từ ngày 1/10/2014.

Bước 2: Cứ cách người được chọn đầu tiên 6 người trong danh sách xuất viện hàng ngày thì lấy người bệnh tiếp theo. Trong trường hợp người bệnh được lấy không đủ tiêu chuẩn lựa chọn thì chọn người bệnh đủ điều kiện kế tiếp Tiếp tục lấy cho đến khi đủ cỡ mẫu nghiên cứu thì dừng lại.

2.4.3.2. Chọn mẫu cho cán bộ y tế: Chọn mẫu chủ đích: Những người am hiểu quy trình KCB, có kiến thức tốt về điều trị và chăm sóc, có tinh thần xây dựng, nhiệt tình tham gia phỏng vấn.

2.4.4. Các biến số/chỉ số nghiên cứu:

Số TT	Nhóm biến số	Chỉ số
Thông tin chung về đối tượng tham gia nghiên cứu		
1.	Tuổi	Tỷ lệ % NB theo nhóm tuổi
2.	Giới	Tỷ lệ % NB nam và nữ
3.	Dân tộc	Tỷ lệ % theo nhóm dân tộc
4.	Trình độ học vấn	Tỷ lệ % theo trình độ học vấn
5.	Nghề nghiệp	Tỷ lệ % theo nhóm nghề nghiệp
6.	Thu nhập bình quân/người/ tháng	Tỷ lệ % theo nhóm thu nhập bình quân
7.	Tình trạng hôn nhân	Tỷ lệ % theo tình trạng hôn nhân
8.	Số lần KCB	Tỷ lệ % theo số lần người bệnh KCB tại khoa
9.	Đối tượng khám bệnh	Tỷ lệ % theo nhóm NB có BHYT hoặc không
10	Hình thức sử dụng dịch vụ	Tỷ lệ % theo nhóm NB chuyển tuyến hoặc tự đến
11	Cách tiếp cận thông tin	Tỷ lệ % theo nhóm NB tiếp cận thông tin
12	Sử dụng dịch vụ mổ yêu cầu	Tỷ lệ % theo nhóm NB sử dụng mổ DV hoặc không
13	Sử dụng dịch vụ giường yêu cầu	Tỷ lệ % theo nhóm NB sử dụng giường DV hoặc không
Mục tiêu 1: Mô tả sự hài lòng người bệnh		
14	Thời gian tiếp cận dịch vụ (4 tiểu	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở

	mục)	mỗi tiểu mục về thời gian tiếp cận DV
15	Tiếp cận với chăm sóc của ĐD (8 tiểu mục)	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở mỗi tiểu mục về tiếp cận với chăm sóc của ĐD
16	Tiếp cận với điều trị của bác sỹ (6 tiểu mục)	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở mỗi tiểu mục về tiếp cận với điều trị của bác sỹ
17	Tư vấn GDSK (5 tiểu mục)	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở mỗi tiểu mục về Tư vấn GDSK
18	Sinh hoạt của người bệnh (4 tiểu mục)	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở mỗi tiểu mục về sinh hoạt của người bệnh
19	Cơ sở vật chất (8 tiểu mục)	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở mỗi tiểu mục về cơ sở vật chất
20	Môi trường bệnh viện (4 tiểu mục)	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở mỗi tiểu mục về môi trường BV
21	Hiệu quả và chi phí KCB	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở tiểu mục hiệu quả và chi phí KCB
22	Hài lòng chung	Tỷ lệ % NB hài lòng theo mức độ ở tiểu mục hài lòng chung với DV khoa PTCS
Mục tiêu 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng		
23	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với sự hài lòng chung của NB	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với sự hài lòng chung của NB
24	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với HL của NB về thời gian chờ tiếp	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với

	cận DV	mỗi tiểu mục trong HL của NB với thời gian chờ tiếp cận DV
25	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với HL của NB về tiếp cận với chăm sóc của ĐD	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với mỗi tiểu mục trong HL của NB với tiếp cận với chăm sóc của ĐD
26	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với tiếp cận với điều trị của BS	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với mỗi tiểu mục trong HL của NB với tiếp cận với điều trị của BS
27	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với HL của NB về về tư vấn GDSK	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với mỗi tiểu mục trong HL của NB về tư vấn GDSK
28	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với HL của NB về sinh hoạt của người bệnh	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với mỗi tiểu mục trong HL của NB về sinh hoạt của người bệnh
29	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với HL của NB về cơ sở vật chất	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với mỗi tiểu mục trong HL của NB về cơ sở vật chất
30	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một

	HL của NB về môi trường của BV	số yếu tố khác theo biến (13 biến) với mỗi tiểu mục trong HL của NB về môi trường của BV
31	Liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác với HL của NB về hiệu quả và chi phí KCB	Tỷ suất chênh (OR) về mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học và một số yếu tố khác theo biến (13 biến) với HL của NB về hiệu quả và chi phí KCB

` Định nghĩa, cách tính và phương pháp thu thập: ***xem phần phụ lục 2.***

2.5. Cô cụ nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu sự hài lòng

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu theo quan điểm sự hài lòng của người bệnh là một yếu tố thể hiện chất lượng của dịch vụ và áp dụng mô hình của Ward và cộng sự (2005) để đánh giá chất lượng "chức năng" của dịch vụ thông qua đo lường sự hài lòng của khách hàng với hai lý do:

−Mô hình này đã được xây dựng dựa trên sự tổng hợp và phân tích các mô hình trước, do vậy đã có tính ưu việt hơn.

−Bộ công cụ phỏng vấn người bệnh có sẵn đã được thử nghiệm tính giá trị và độ tin cậy.

Mô hình của Ward và CS (2005) đưa ra 04 khía cạnh về chất lượng dịch vụ. Thứ nhất là "sự tiếp cận": Người bệnh được nhận các dịch vụ chấp nhận được về giá cả và đúng lúc, bao gồm các mặt như đặt lịch hẹn, thời gian chờ đợi, chi phí, thủ tục thanh toán bảo hiểm…khái niệm "sự đáp ứng" xuất phát từ mô hình SERVQUAL cũng nằm trong khía cạnh này; thứ hai là "kết quả": Sức khỏe người bệnh được cải thiện rõ ràng, biểu hiện ở chỗ người bệnh khỏi bệnh sau khi ra viện và ý kiến của họ về bệnh viện; Thứ ba là " giao tiếp và sự tương tác": Người bệnh liên tục được chăm sóc với thái độ tốt, biểu hiện ở chỗ các nhân viên, bác sĩ có thái độ hòa nhã, thân thiện với người bệnh, sẵn sàng giúp đỡ người bệnh, cảm thông.

Các khía cạnh "sự cảm thông" và "sự đảm bảo" của mô hình trước được thể hiện trong mô hình này; Thứ tư là "những yếu tố hữu hình": Người bệnh được điều trị với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, con người theo nhu cầu của họ, biểu hiện ở các mặt sự thuận tiện, sự sạch sẽ của CSVC, trang thiết bị, sự sẵn có của các dụng cụ y tế.

Dựa trên các mô hình trên, chúng tôi đã thiết kế bộ câu hỏi cho phát vấn trực tiếp và phỏng vấn sâu với chi tiết sau:

Bảng 2.1: Công cụ nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu	**Thông tin cần thu thập**	**Phương pháp thu thập**	**Công cụ thu thập thông tin**
Người bệnh/thân nhân	Thông tin chung, Sự hài lòng của người bệnh với các yếu tố thời gian chờ đợi, tiếp cận với nhân viên y tế, môi trường bệnh viện, hiệu quả và chi phí KCB…	Phát vấn.	Bộ câu hỏi định lượng kết hợp định tính
CBYT	Quan điểm của CBYT về sự hài lòng của người bệnh, các yếu tố liên quan đến sự hài lòng đó	Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm.	Hướng dẫn phỏng vấn sâu kèm theo biên bản ghi chép và ghi âm
Sổ sách, báo cáo thống kế	- Nhân lực của BV - CSVC-TTB của BV - Sổ sách, dữ liệu thống kê người bệnh tại khoa và tại phòng Kế hoạch tổng hợp, Thống kê kết quả hoạt động theo 7 nhiệm vụ bệnh viện.	Thu thập số liệu trực tiếp	Bảng trống

2.5.1. Quá trình thiết kế Bộ câu hỏi phát vấn:

- Tham khảo các nghiên cứu khác.
- Xây dựng khung hình thức và nội dung cho bộ câu hỏi: Gồm các bước: Thiết kế nội dung câu hỏi; Sắp xếp nội dung; Lựa chọn thang đo được sử dụng trong bộ câu hỏi; Cuối cùng là tạo hình thức cho Bộ câu hỏi.
- Thử nghiệm Bộ câu hỏi: Bộ câu hỏi được thử nghiệm trên 30 người bệnh thuộc tiêu chuẩn lựa chọn trong nghiên cứu. Mục đích của việc thử nghiệm là:
    - Đánh giá sự phù hợp của phương pháp trong quá trình thu thập số liệu.
    - Kiểm tra tính đúng đắn của bộ câu hỏi, đánh giá xem bộ câu hỏi đã rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng nghiên cứu chưa.
    - Đánh giá sự đồng nhất của các câu hỏi trong phần nội dung liên quan đến hài lòng: Tính được chỉ số Cronbach’s Alpha=0,957, đã cho thấy sự đồng nhất của bộ câu hỏi ở mức rất cao.
- Cuối cùng là hoàn chỉnh Bộ câu hỏi.

2.6. Thu thập thông tin và đánh giá

Điều tra viên tham gia thu thập thông tin là các cử nhân Điều dưỡng, cử nhân Y tế công cộng, có kiến thức và kinh nghiệm về thu thập số liệu do đã thực hiện khóa luận tại bệnh viện và cộng đồng, có tham khảo các nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam và trên thế giới.

Sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc được thiết kế sẵn để phát vấn cho người bệnh theo tiêu chuẩn lựa chọn.

Tổ chức thu thập số liệu:

Điều tra viên được tập huấn kỹ về cách sử dụng bộ câu hỏi và bảng hướng dẫn sử dụng bộ câu hỏi; quy trình thu thập số liệu, phát vấn cũng như giao tiếp hướng dẫn cho người bệnh.

Trước khi tiến hành, các điều tra viên được phát phiếu mẫu và được tập huấn bằng cách đóng vai. Sau buổi tập huấn, các điều tra viên đóng góp ý kiến, sửa và hoàn thiện sau khi thử nghiệm.

Thảo luận với CBYT sẽ được ghi âm và ghi lại những ý chính.

2.7. Sự phân chia mức độ hài lòng

Thang đo mức độ hài lòng của người bệnh đối với chất lượng chăm sóc sức khỏe dựa trên thang Likert bao gồm một câu hỏi đóng với một mệnh đề và 5 lựa chọn phân loại mức độ hài lòng:

-Mức độ 1: Rất không hài lòng:

-Mức độ 2: Không hài lòng:

-Mức độ 3: Bình thường:

-Mức độ 4: Hài lòng:

-Mức độ 5: Rất hài lòng:

Theo phân tích, suy luận logic với thang điểm Likert, để có tính thuyết phục cao thì mức độ hài lòng của người bệnh bắt đầu từ mức 4 (vì mức 3 sự hài lòng của NB chưa thể hiện rõ ràng). Vì thế, trong nghiên cứu này thang điểm Likert được mã hóa thành hai nhóm: nhóm chưa hài lòng (từ mức 1 đến mức 3) và nhóm hài lòng (từ mức 4 đến mức 5) đối với từng tiểu mục lấy cơ sở tính tỷ lệ hài lòng.

2.8. Xử lý số liệu

Số liệu sẽ được làm sạch, sau đó được nhập vào phần mềm Epidata 3.1 và xử lý trên phần mềm STATA 11.0 với các test thống kê y học phù hợp.

Tính tỷ lệ phần trăm người bệnh hài lòng với dịch vụ y tế theo thang Likert. Sử dụng giá trị OR và khoảng tin cậy 95% (95% CI) để xem xét mối liên quan biến hài lòng chung đối với dịch vụ y tế và các thành tố về dịch vụ y tế.

Các thông tin định tính từ người bệnh sẽ được tổng hợp lại, loại bỏ các ý kiến trùng lặp, ghi lại những ý chính.

Thảo luận với CBYT: Gỡ băng, ghi biên bản phỏng vấn sâu. Sau đó, nội dung được lọc lấy những thông tin cần thiết với từng phần của nghiên cứu. Cuối cùng từng câu được đánh mã số, thông tin về giới tính, tuổi của người trả lời ứng với câu đó.

2.9. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được sự đồng ý của Ban Giám đốc bệnh viện Việt Đức, Ban Lãnh đạo Khoa Phẫu thuật Cột sống, Hội đồng thông qua đề cương trường Đại học Y Hà Nội.

Giải thích mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra cho các đối tượng nghiên cứu khi cần thiết để có tinh thần hợp tác cùng làm việc.

Điều tra trên những đối tượng tự nguyện đồng ý cộng tác, không ép buộc và trên tinh thần tôn trọng.

Việc phỏng vấn được tiến hành vào thời điểm thuận tiện cho BN sau khi đã hoàn thành đợt điều trị nội trú, thanh toán viện phí và chuẩn bị xuất viện.

Câu hỏi được trả lời dưới 30 phút, không đòi hỏi sự nhớ lại khó khăn, không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm và các thông tin riêng tư và sử dụng các từ ngữ phổ thông dễ hiểu.

Nghiên cứu không ảnh hưởng đến sức khỏe của đối tượng: không lấy máu, không dùng thuốc điều trị.

Người bệnh có thể được tư vấn về những kiến thức liên quan đến bệnh và việc điều trị bệnh sau khi kết thúc chương trình nghiên cứu nếu có yêu cầu.

Các thông tin cá nhân được đảm bảo giữ bí mật.

Nghiên cứu chỉ nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, ngoài ra không có mục đích nào khác.

Kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo với Bệnh viện Việt Đức, Khoa Phẫu thuật Cột sống, trường Đại học Y Hà nội.

2.10. Sai số và cách khắc phục

Trong nghiên cứu này hay gặp một số sai số sau:

- Sai số do bộ câu hỏi không đảm bảo.

- Kỹ năng điều tra viên không đảm bảo.
- Sai số nhớ lại.
- Sai số do trả lời một số vấn đề nhạy cảm.

Cách khắc phục:

- Tiến hành điều tra thử, chỉnh sửa bộ câu hỏi cho phù hợp.
- Tập huấn kỹ các kỹ năng điều tra cho điều tra viên, sau đó tiến hành điều tra thử
- Hướng dẫn giải thích cho người bệnh mục đích nghiên cứu, tạo tâm lý tốt và thoải mái cho đối tượng tham gia nghiên cứu.
- Kiểm tra giám sát trong quá trình điều tra, kiểm soát chặt chẽ khi nhập và xử lý số liệu.

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Sự hài lòng chung của người bệnh với một số yếu tố

Bảng 3.1: Bảng phân bố sự hài lòng chung theo yếu tố nhân khẩu học:

Yếu tố nhân khẩu học (n_1[1]=457)		**n_2[2]**	**Tỷ lệ %**	***Hài lòng chung***	
				n_3[3]	***%***
Tuổi	*< 50 tuổi*	243	53,2	166	68,3
	≥ 50 tuổi	214	46,8	149	69,6
Giới tính	*Nam*	193	42,2	126	65,8
	Nữ	264	57,8	189	71,6
Dân tộc	*Kinh*	442	96,7	303	68,6
	Khác	15	3,3	12	80,0
Trình độ học vấn	*Trung cấp, PTTH trở xuống*	393	86,0	273	69,5
	CĐ, ĐH, Sau ĐH	64	14,0	42	65,6
Nghề nghiệp	*Nông dân, lao động tự do*	258	56,5	201	67,5
	Công nhân, Công chức, hưu trí, HSSV	199	43,5	114	68,9
Thu nhập bình quân/người/tháng	*< 1.500.000 đồng*	118	25,8	79	67,0
	≥ 1.500.000 đồng	339	74,2	236	69,6
Tình trạng hôn nhân	*Độc thân, ly thân, ly hôn, góa*	62	13,6	39	62,9
	Có gia đình	395	86,4	275	69,8

[1] Số lượng người bệnh được điều tra

[2] Số lượng người bệnh theo từng đặc tính

[3] Số lượng người bệnh hài lòng dịch vụ KCB

Nhận xét: Bảng 3.1 cho thấy, đối tượng nghiên cứu là người bệnh nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh nữ cũng cao hơn nam. Người bệnh thuộc dân tộc Kinh chiếm đa số nhưng tỷ lệ HL chung lại thấp hơn. Số lượng người bệnh ở nhóm tuổi < 50 và ≥ 50 tuổi cũng như tỷ lệ hài lòng chung của hai nhóm này gần tương đương nhau. Người có trình độ CĐ/ĐH/sau ĐH chỉ bằng khoảng 1/6 người có trình độ Trung cấp/PTTH trở xuống, tỷ lệ HL chung của nhóm này cũng thấp hơn so với nhóm còn lại. Người bệnh là nông dân và lao động tự do chiếm tỷ lệ cao hơn trong đó tỷ lệ người bệnh có gia đình cao gấp khoảng 6,4 lần. Người có thu nhập trung bình <1,5 triệu đồng/tháng chiếm khoảng 1/3 tổng số đối tượng tham gia nghiên cứu.

Bảng 3.2: Bảng phân bố sự hài lòng chung với một số yếu tố yếu tố dịch vụ KCB tại Khoa PTCS.

***Yếu tố dịch vụ khác* (n_1=457)**		**n_2**	***Tỷ lệ %***	***Hài lòng chung***	
				n_3	***%***
Số lần KCB tại Khoa/năm	*Lần đầu*	402	87,9	280	69,7
	≥ 2 lần	55	12,1	35	63,6
BHYT	*Không BHYT*	78	17,1	52	66,7
	Có BHYT	379	82,9	262	69,3
Hình thức sử dụng dịch vụ	*Chuyển tuyến*	318	69,6	218	68,6
	Tự đến	139	30,4	97	69,8
Cách tiếp cận thông tin	*Bạn bè, người quen giới thiệu*	196	42,9	141	71,9
	Phương tiện TTĐC, Mạng internet, Khác	261	57,1	168	66,4
Sử dụng dịch vụ mổ theo YC	*Có*	408	89,7	277	67,9
	Không	47	10,3	36	76,6
Sử dụng dịch vụ giường YC	*Có*	218	47,8	166	76,2
	Không	238	52,2	148	62,2

Nhận xét: Bảng 3.2 cho thấy, đa số người bệnh điều trị tại khoa PTCS lần đầu, có sử dụng thẻ BHYT đúng tuyến và được tiếp cận với thông tin về khoa qua nhiều kênh khác nhau như người thân hoặc các phương tiện TTĐC. Tỷ lệ hài lòng chung trong từng nhóm hầu hết đều đạt trên 60%, chỉ có tỷ lệ hài lòng của nhóm có sử dụng dịch vụ giường và mổ theo yêu cầu, nhóm đến do bạn bè, người thân giới thiệu đạt trên 70%.

3.2. Sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế tại khoa Phẫu thuật Cột sống

3.2.1. Thời gian tiếp cận dịch vụ y tế

Bảng 3.3: Sự hài lòng với thời gian chờ đợi tiếp cận dịch vụ y tế

Sự hài lòng của NB với thời gian chờ đợi	n_4[1]	Tỷ lệ %
Hài lòng với thời gian chờ nhân viên tiếp đón (n_1=457)	355	77,6
Hài lòng với thời gian chờ mổ (n_1=457)	355	77,6
Hài lòng với thời gian chờ sự có mặt của ĐD (n_1=410)	369	90,0
Hài lòng với thời gian chờ hỗ trợ vệ sinh (n_1=371)	310	83,6

Nhận xét: Bảng 3.4 cho thấy, phần lớn người bệnh đều hài lòng với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế (đều >77%). Trong đó, tỷ lệ hài lòng cao nhất là với "Thời gian chờ sự có mặt của điều dưỡng", thấp nhất là hài lòng với thời gian chờ nhân viên tiếp đón và thời gian chờ mổ.

Theo kết quả nghiên cứu định tính, nhiều người bệnh cũng không hài lòng với thời gian chờ đợi dịch vụ y tế, điển hình là *"Thời gian nhập viện và nhận giường quá lâu"* (Người bệnh nam, 48 tuổi, mã số 40285) hay *"Thời gian chờ mổ lâu, cần công khai thứ tự lịch mổ"* (Người bệnh nữ, 52 tuổi, mã số 38079).

[1] n_4 là tỷ lệ tần số hài lòng theo từng tiểu mục.

3.2.2. Tiếp cận với chăm sóc của Điều dưỡng (ĐD)

Bảng 3.4: Sự hài lòng với chăm sóc của ĐD

Sự hài lòng của NB với chăm sóc của ĐD (n_1=457)	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng với thái độ phục vụ thân thiện và tôn trọng NB của ĐD	428	93,7
Hài lòng với sự cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện thao tác chăm sóc của ĐD	424	92,8
Hài lòng với việc giải thích và công khai thuốc trước khi sử dụng cho người bệnh của ĐD	430	94,1
Hài lòng với quy trình chuẩn bị trước mổ của ĐD	432	94,5
Hài lòng với giao tiếp của ĐD với người bệnh và thân nhân	411	89,9
Hài lòng với việc giải thích cho người bệnh trước khi làm thủ thuật chăm sóc	424	93,0
Hài lòng với việc hướng dẫn và tập phục hồi chức năng tại giường của KTV.	418	91,5
Hài lòng với sự lắng nghe của ĐD khi nghe NB trình bày.	395	86,4

Nhận xét: Bảng 3.5 cho thấy, hầu hết tỷ lệ người bệnh hài lòng với từng tiểu mục trong yếu tố sự chăm sóc của điều dưỡng đạt >85%. Trong đó, tỷ lệ hài lòng cao nhất là với "quy trình chuẩn bị trước mổ của ĐD", thấp nhất là với "với sự lắng nghe của ĐD khi nghe NB trình bày".

Kết quả nghiên cứu định tính thu thập thêm được nhiều ý kiến của người bệnh. Tổng hợp lại cho thấy, vẫn còn một bộ phận người bệnh không hài lòng với sự chăm sóc của Điều dưỡng. Người bệnh có bức xúc *"...thái độ của điều dưỡng đưa đi chụp CT sau mổ với người bệnh là quá kém"* và người này cũng nhấn mạnh rằng: "*Đây là điều duy nhất để lại hình ảnh xấu tại khoa"* (người bệnh nam, 26 tuổi, mã số 43221). Hay một người bệnh khác khi được hỏi thì có kiến nghị *"Điều dưỡng cần quan tâm người bệnh trong lúc truyền dịch"* (người bệnh nam, 24 tuổi, mã số 41252).

3.2.3. Tiếp cận với điều trị của bác sỹ

Bảng 3.5: Sự hài lòng với điều trị của bác sỹ

Sự hài lòng của NB với điều trị của bác sỹ (n_1=457)	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng với thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ	439	96,1
Hài lòng với việc khám và chẩn đoán bệnh của bác sỹ	446	97,6
Hài lòng với sự lắng nghe của bác sỹ khi nghe NB trình bày về bệnh tật	403	88,2
Hài lòng với việc thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của BS	443	96,9
Hài lòng với kết quả điều trị giảm đau sau mổ của bác sỹ	416	91,0
Hài lòng với việc thăm khám bệnh hàng ngày của bác sỹ	423	92,5

Nhận xét: Theo bảng 3.6, tỷ lệ người bệnh được phỏng vấn hài lòng với các tiểu mục trong yếu tố công tác điều trị của bác sỹ đều đạt trên 88%. Trong đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là "Hài lòng với việc khám và chẩn đoán bệnh của bác sỹ". Ngược lại, người bệnh ít hài lòng nhất với "sự lắng nghe của bác sỹ khi nghe người bệnh trình bày về bệnh tật".

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu định tính cũng cho thấy phản ánh điển hình của người bệnh liên quan công tác điều trị của bác sỹ, như nhận xét *"Bác sỹ ít dành thời gian nói chuyện với người bệnh"* (Người bệnh nam, 51tuổi, mã số 39760), hay *"Mong muốn bác sỹ thăm khám từng người bệnh kỹ càng, tỷ mỷ hơn"* (Người bệnh nam, 72 tuổi, mã số 40133).

3.2.4. Tư vấn giáo dục sức khỏe

Bảng 3.6: Sự hài lòng với tư vấn giáo dục sức khỏe

Sự hài lòng của NB với tư vấn giáo dục sức khỏe	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng với sự tư vấn của bác sỹ về bệnh tật (n_1=457)	362	79,2
Hài lòng với sự hướng dẫn của ĐD về chế độ dinh dưỡng, tập luyện sau khi ra viện (n_1=457)	345	75,5
Hướng dẫn tập PHCN (n_1=457)	370	80,9
Hướng dẫn khi ra viện (n_1=457)	390	85,3
Hài lòng với việc nghe và nhận tài liệu phổ biến nội quy trong quá trình nằm viện (**n_1**=454)	387	85,2

Nhận xét: Bảng 3.7 cho thấy, sự hài lòng của người bệnh ở từng tiểu mục trong tư vấn giáo dục sức khỏe đều đạt >80%. Trong đó, chỉ có khoảng 3/4 người bệnh được hỏi hài lòng với sự hướng dẫn của ĐD về chế độ dinh dưỡng, tập luyện sau khi ra viện (chiếm tỷ lệ hài lòng thấp nhất).

Kết quả nghiên cứu định tính cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp về yếu tố này của người bệnh, như *"Mong muốn được khoa cung cấp hình ảnh, giấy tờ hướng dẫn tập PHCN"* (Người bệnh nam, 29 tuổi, mã số 18772) hay "*Kỹ thuật viên PHCN cần tư vấn tỷ mỷ cẩn thận rõ ràng hơn cho người bệnh*" (Người bệnh nữ, 54 tuổi, mã số 40003).

3.2.5. Sinh hoạt của người bệnh

Bảng 3.7: Sự hài lòng với sinh hoạt người bệnh

Sự hài lòng của NB về sinh hoạt của bản thân	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng với giấc ngủ tại bệnh viện (n_1=457)	323	70,6
Hài lòng với sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân trong khi nằm viện (n_1=457)	442	96,7
Hài lòng với năng lực làm việc hiện tại (n_1=457)	342	74,7
Hài lòng với khả năng tình dục của mình (n_1=444)	241	54,3

Nhận xét: Bảng 3.8 cho thấy, tỷ lệ người bệnh hài lòng với từng tiểu mục trong yếu tố "Sự hài lòng với sinh hoạt người bệnh" có sự chênh lệch đáng kể. Trong khi, người bệnh hài lòng nhiều nhất sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân trong khi nằm viện, với tỷ lệ hài lòng trên 96%. Tuy nhiên, lại chỉ có >1/2 người bệnh hài lòng với "khả năng tình dục của mình" đạt được sau phẫu thuật và còn 1/3 số người bệnh chưa hài lòng với giấc ngủ tại bệnh viện.

Kết quả nghiên cứu định tính cũng ghi nhận một số ý kiến người bệnh như "*Ánh sáng cần hạn chế vào ban đêm*" (Người bệnh nam, 51tuổi, mã 39760) hay "*nhân viên trực buổi tối nói chuyện to. Đề nghị các NV trực giảm nói chuyện để BN nghỉ ngơi"* (Người bệnh nam, 53 tuổi, mã 41728)

3.2.6. Cơ sở vật chất

Bảng 3.8: Sự hài lòng với cơ sở vật chất

Sự hài lòng của NB về cơ sở vật chất (n_1=457)	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng với cảnh quan của khoa PT Cột sống	418	91,5
Hài lòng với sự TTB y tế của khoa phòng	437	95,6
Hài lòng với độ sáng của khoa phòng	373	81,6
Hài lòng với sự sạch sẽ của buồng bệnh	384	84,0
Hài lòng với chất lượng đồ vải	418	91,5
Hài lòng với tiện nghi phục vụ sinh hoạt	412	90,2
Hài lòng với diện tích buồng bệnh	381	83,4
Hài lòng với khu nhà vệ sinh buồng bệnh	352	77,0

Nhận xét: Bảng 3.9 cho thấy, các tiểu mục trong yếu tố cơ sở vật chất tại khoa PTCS đều đáp ứng được trên 77% sự hài lòng của người bệnh. Hài lòng với khu nhà vệ sinh buồng bệnh chiếm tỷ lệ thấp nhất. Trong khi, người bệnh hài lòng nhiều nhất với tiểu mục trang thiết bị y tế của khoa phòng.

Kết quả nghiên cứu định tính rất nhiều ý kiến với cơ sở vật chất của người bệnh. Như có ý kiến của người bệnh góp ý "*nhà vệ sinh nên có quạt thông gió và thoát nước tốt" (*Người bệnh nữ, 37 tuổi, mã số 19769), "*phòng vệ sinh nên chuyển ra ngoài tránh mùi hôi và nên có thanh bám để người bệnh dễ đứng dậy*" (Người bệnh nữ, 29 tuổi, mã số 17790).

3.2.7. Môi trường bệnh viện

Bảng 3.9: Sự hài lòng với môi trường bệnh viện

Sự hài lòng của NB với môi trường bệnh viện (n_1=457)	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng với an ninh trong bệnh viện	423	92,6
Hài lòng với sự sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện	435	95,2
Hài lòng với cây xanh trong bệnh viện	424	92,8
Hài lòng với sự yên tĩnh trong bệnh viện	388	84,9

Nhận xét: Bảng 3.10 cho biết, trên 84% người bệnh hài lòng với các tiểu mục trong môi trường của bệnh viện. Trong đó, tỷ lệ hài lòng cao nhất là với "Sự sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện". Ngược lại, người bệnh ít hài lòng nhất với sự yên tĩnh trong bệnh viện.

Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy nhiều người bệnh cũng có ý kiến về môi trường của bệnh viện, điển hình là: "*Trong khuôn viên bệnh viện còn ít cây xanh, không gian bệnh viện cần mở rộng hơn"* (Người bệnh nam, 54 tuổi, mã số 39839) hay "*Có nhiều NB có cùng bệnh muốn điều trị tại khoa nhưng diện tích của khoa còn chật nên chưa đáp ứng đc nhu cầu, mong muốn khoa được mở rộng để tiếp nhận lượng NB đến chữa bệnh"* (Người bệnh nữ, 35 tuổi, mã số 39992).

3.2.8. Hiệu quả và chi phí KCB

Bảng 3.10: Sự hài lòng với hiệu quả và chi phí KCB

Sự hài lòng với hiệu quả và chi phí KCB (n_1=457)	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng với tổng chi phí của đợt điều trị này so với kết quả ông/bà đạt được sau PT	356	77,9

Nhận xét: Theo bảng 3.11, đa số người bệnh hài lòng về hiệu quả và chi phí KCB, chiếm tỷ lệ gần 78%.

Một số người bệnh nêu ý kiến còn chưa thực sự hài lòng với chi phí khám bệnh, như *"Các chi phí phụ kiện còn cao so với thu nhập của đông đảo người bệnh*" (Người bệnh nam, 66 tuổi, mã số 39889).

3.2.9. Sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế tại khoa Phẫu thuật Cột sống.

Bảng 3.11: Sự hài lòng chung với dịch vụ tại khoa Phẫu thuật Cột sống

Hài lòng chung (n_1=457)	**n_4**	**Tỷ lệ %**
Hài lòng chung với dịch vụ tại khoa PTCS	434	95,1

Nhận xét: Theo bảng 3.12, số người bệnh hài lòng về đợt điều trị tại khoa PTCS rất cao, chiếm tỷ lệ 95,1%.

Kết quả nghiên cứu định tính cũng ghi nhận nhiều ý kiến người bệnh đánh giá cao về chất lượng dịch vụ của khoa, điển hình như:*"Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại Khoa"* (Người bệnh nữ, 52 tuổi, mã 38524) hay*"Luôn được chăm sóc hỏi han rất tận tình"* (Người bệnh nam, 56 tuổi, mã 38558)

3.3. Liên quan giữa các yếu tố với sự hài lòng của người bệnh

3.3.1. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng chung của người bệnh

Bảng 3.12: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng chung của người bệnh

Các yếu tố liên quan		Hài lòng chung		OR	95% CI
		HL	Chưa HL		
Nhóm tuổi	*< 50 tuổi*	231	12	1,1	0,5-2,5
	≥ 50 tuổi	204	10		
Giới	*Nam*	182	11	1,4	0,6-3,3
	Nữ	253	11		
Trình độ học vấn	*Trung cấp, PTTH trở xuống*	376	17	1,87	0,7-5,3
	CĐ, ĐH, Sau ĐH	59	5		
Nghề nghiệp	*Nông dân, lao động tự do*	288	10	2,4	1,02-5,6*
	Công nhân, Công chức, hưu trí, HSSV	147	12		
Tình trạng hôn nhân	*Có gia đình*	379	16	2,5	0,9- 6,8
	Độc thân, ly thân, ly hôn, góa	56	6		
Thu nhập trung bình/ tháng	*≥ 1,500,000*	328	11	3,06	1,3-7,3*
	<1,500,000	107	11		
Số lần KCB tại Khoa/năm	*Lần đầu*	384	18	1,67	0,5-5,2
	≥ 2 lần	51	4		
BHYT	*Không BHYT*	77	1	4,5	0,6-34,5
	Có BHYT	358	21		
Hình thức sử dụng dịch vụ	*Chuyển tuyến*	303	15	1,07	0,4-2,7
	Tự đến	132	7		
Cách tiếp cận thông tin	*Bạn bè, người quen giới thiệu*	191	5	4,05	1,3-7,64*
	Phương tiện TTĐC, Mạng internet	236	25		
Sử dụng dịch vụ mổ theo yêu cầu	*Có*	388	20	0,86	0,26-5,13
	Không	45	2		
Sử dụng dịch vụ giường theo yêu cầu	*Có*	210	8	1,64	0,7-4,0
	Không	224	14		

Nhận xét: Bảng 3.12 cho thấy sự hài lòng chung có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với 3 yếu tố, đó là: nghề nghiệp, thu nhập trung bình/tháng và cách tiếp cận thông tin. Cụ thể, người bệnh là nông dân/lao động tự do có tỷ lệ hài lòng cao gấp hơn 2 lần người bệnh là các đối tượng khác. Người bệnh có thu nhập dưới 1,5 triệu thì có tỷ lệ hài lòng cao hơn người có thu nhập trên 1,5 triệu là khoảng 3 lần. Về cách thức tiếp cận, người bệnh được bạn bè, người quen giới thiệu hài lòng cao hơn người đến khám do biết qua phương tiện TTĐC hơn 4 lần.

Kết quả nghiên cứu định tính cho rằng "*có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh như trình độ dân trí, trình độ học vấn và thu nhập"* (PVS Bác sỹ nam, lãnh đạo khoa PTCS, mã số 02)

3.3.2. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế

Bảng 3.13: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế

Các yếu tố liên quan		**Hài lòng với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế**		**OR**	**95% CI**
		HL	Chưa HL		
Nhóm tuổi	*< 50 tuổi*	234	9	1,27	0,51-3,2
	≥ 50 tuổi	204	10		
Giới	*Nam*	183	10	0,64	0,25-1,62
	Nữ	255	9		
Trình độ học vấn	*Trung cấp, PTTH trở xuống*	375	18	0,33	0,04-2,53
	CĐ, ĐH, Sau ĐH	63	1		
Nghề nghiệp	*Nông dân, lao động tự do*	287	11	1,38	0,54-3,51
	Công nhân, Công chức, hưu trí, HSSV	151	8		
Tình trạng hôn nhân	*Có gia đình*	383	12	4,06	1,51-10,85*
	Độc thân, ly thân, ly hôn, góa	55	7		

Thu nhập trung bình/ tháng	*≥ 1,500,000*	325	14	1,02	0,36-2,92
	<1,500,000	113	5		
Số lần KCB tại Khoa/năm	*Lần đầu*	384	18	0,39	0,05-3,03
	≥ 2 lần	54	1		
BHYT	*Không BHYT*	75	3	1,1	0,31-3,89
	Có BHYT	363	16		
Hình thức sử dụng dịch vụ	*Chuyển tuyến*	306	12	1,35	0,52-3,52
	Tự đến	132	7		
Cách tiếp cận thông tin	*Bạn bè, người quen giới thiệu*	187	13	0,83	0,34-2,15
	Phương tiện TTĐC, Mạng internet	243	14		
Sử dụng mổ dịch vụ	*Có*	390	18	-	
	Không	47	0		
Sử dụng giường dịch vụ	*Có*	208	10	0,81	0,33-2,05
	Không	229	9		

Nhận xét: Theo bảng 3.13, sự hài lòng về thời gian tiếp cận dịch vụ ở người bệnh đã có gia đình cao gấp 4 lần so với nhóm người bệnh độc thân/ly thân/ly hôn. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95%.

Kết quả nghiên cứu định tính ghi nhận ý kiến "*ấn tượng về khâu tiếp đón ban đầu của nhân viên y tế rất quan trọng*" (PVS bác sỹ nam, lãnh đạo khoa, mã số 02).

3.3.3. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với chăm sóc của ĐD

Bảng 3.14: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với chăm sóc của ĐD

Các yếu tố liên quan		**Hài lòng với chăm sóc của ĐD**		**OR**	**95% CI**
		HL	Chưa HL		
Nhóm tuổi	*< 50 tuổi*	240	3		
	≥ 50 tuổi	212	2	0,75	0,12-4,57
Giới	*Nam*	190	3		
	Nữ	262	2	0,48	0,07-2,93
Trình độ học vấn	*Trung cấp, PTTH trở xuống*	389	4		
	CĐ, ĐH, Sau ĐH	63	1	1,54	0,17-14,07
Nghề nghiệp	*Nông dân, lao động tự do*	294	4		
	Công nhân, Công chức, hưu trí, HSSV	158	1	0,47	0,05-4,21
Tình trạng hôn nhân	*Có gia đình*	393	2		
	Độc thân, ly thân, ly hôn, góa	59	3	9,99	1,6-62,2*
Thu nhập trung bình/ tháng	*≥ 1,500,000*	338	1		
	<1,500,000	114	4	11,9	1,3-109,5*
Số lần KCB tại Khoa/năm	*Lần đầu*	398	4		
	≥ 2 lần	54	1	1,84	0,2-16,8
BHYT	*Không BHYT*	78	0		-
	Có BHYT	374	5	-	
Hình thức sử dụng dịch vụ	*Chuyển tuyến*	314	4		
	Tự đến	138	1	0,57	0,06-5,15
Cách tiếp cận thông tin	*Bạn bè, người quen giới thiệu*	195	5		
	Phương tiện TTĐC, Mạng internet	249	8	1,25	0,35-28,4
Sử dụng mổ dịch vụ	*Có*	404	4		
	Không	46	1	2,20	0,05-4,18
Sử dụng giường dịch vụ	*Có*	214	4		
	Không	237	1	0,23	0,03-2,05

Nhận xét: Bảng 3.14 cho thấy, liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng của người bệnh về chăm sóc của ĐD với tình trạng hôn nhân và thu nhập trung bình/ tháng. Trong đó, người có gia đình hài lòng gấp gần 10 lần những người bệnh độc thân/ly hôn/khác. Và người bệnh có thu nhập ≥ 1,5 triệu/tháng hài lòng cao hơn nhóm có thu nhập <1,5 triệu/tháng gần 12 lần.

Kết quả nghiên cứu định tính cũng đánh giá vai trò điều dưỡng rất quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh, như ý kiến "*điều dưỡng chuẩn bị mổ tốt, phẫu thuật và điều trị hiệu quả thì người bệnh sẽ hài lòng*" (PVS bác sỹ nam, lãnh đạo khoa, mã số 02)

3.3.4. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với tư vấn giáo dục sức khỏe

Bảng 3.15: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với tư vấn giáo dục sức khỏe

Các yếu tố liên quan		**Hài lòng với tư vấn giáo dục sức khỏe**		**OR**	**95% CI**
		HL	Chưa HL		
Nhóm tuổi	*< 50 tuổi*	229	14	0,64	0,26-1,55
	≥ 50 tuổi	206	8		
Giới	*Nam*	180	13	0,489	0,2-1,17
	Nữ	255	9		
Trình độ học vấn	*Trung cấp, PTTH trở xuống*	376	17	1,87	0,66-5,29
	CĐ, ĐH, Sau ĐH	59	5		
Nghề nghiệp	*Nông dân, lao động tự do*	282	16	0,69	0,26-1,81
	Công nhân, Công chức, hưu trí, HSSV	153	6		
Tình trạng hôn nhân	*Có gia đình*	380	15	3,22	1,25-8,3*
	Độc thân, ly thân, ly hôn, góa	55	7		

Thu nhập trung bình/ tháng	*≥ 1,500,000*	323	16	1,08	0,41-2,83
	<1,500,000	112	6		
Số lần KCB tại Khoa/năm	*Lần đầu*	385	17	2,3	0,8-6,4
	≥ 2 lần	50	5		
BHYT	*Có BHYT*	366	13	3,66	1,49-8,99*
	Không BHYT	69	9		
Hình thức sử dụng dịch vụ	*Chuyển tuyến*	307	11	2,4	1,01-5,7*
	Tự đến	128	11		
Cách tiếp cận thông tin	*Bạn bè, người quen giới thiệu*	188	12	1,18	0,57-3,35
	Phương tiện TTĐC, Mạng internet	239	18		
Sử dụng mổ dịch vụ	*Có*	319	17	2,74	0,13-1,05
	Không	42	5		
Sử dụng giường dịch vụ	*Có*	211	7	2,03	0,81-5,09
	Không	223	15		

Nhận xét: Bảng 3.15 cho thấy, mối liên quan giữa sự hài lòng của người bệnh về tư vấn giáo dục sức khỏe của bệnh viện với 3 yếu tố: Tình trạng hôn nhân, đối tượng khám bệnh và hình thức sử dụng dịch vụ có ý nghĩa thống kê. Sự hài lòng của người bệnh đã có gia đình hoặc có BHYT lần lượt đều gấp khoảng hơn 3 lần so với nhóm người bệnh còn độc thân hoặc chưa có BHYT. Ngoài ra, người bệnh được chuyển tuyến có tỷ lệ hài lòng về sự tư vấn giáo dục sức khỏe cao hơn nhóm người bệnh tự đến khoảng hơn 2 lần.

Kết quả nghiên cứu định tính ghi nhận ý kiến "*Đặc tính vùng miền, độ tuổi và giới tính cũng ảnh hưởng đến cảm nhận sự hài lòng khi nghe bác sỹ tư vấn"* (PVS bác sỹ nam, lãnh đạo viện CTCH, mã số 01)

3.3.5. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với sinh hoạt của người bệnh

Bảng 3.16: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với sinh hoạt của người bệnh.

Các yếu tố liên quan		**Hài lòng với sinh hoạt của người bệnh**		**OR**	**95% CI**
		HL	Chưa HL		
Nhóm tuổi	*< 50 tuổi*	237	6		
	≥ 50 tuổi	208	6	1,13	0,36-3,59
Giới	*Nam*	187	6		
	Nữ	258	6	0,72	0,23-2,29
Trình độ học vấn	*Trung cấp, PTTH trở xuống*	381	12	-	-
	CĐ, ĐH, Sau ĐH	64	0		
Nghề nghiệp	*Nông dân, lao động tự do*	287	11	0,17	0,02-1,3
	Công nhân, Công chức, hưu trí, HSSV	158	1		
Tình trạng hôn nhân	*Có gia đình*	386	9		
	Độc thân, ly thân, ly hôn, góa	59	3	2,18	0,57-8,3
Thu nhập trung bình/ tháng	*≥ 1,500,000*	330	9		
	<1,500,000	115	3	0,96	0,25-3,59
Số lần KCB tại Khoa/năm	*Lần đầu*	394	8		
	≥ 2 lần	51	4	3,86	1,11-13,4*
BHYT	*Không BHYT*	76	2		
	Có BHYT	369	10	1,03	0,22-4,81
Hình thức sử dụng dịch vụ	*Chuyển tuyến*	311	7		
	Tự đến	134	5	1,66	0,51-5,32
Cách tiếp cận thông tin	*Bạn bè, người quen giới thiệu*	194	6		
	Phương tiện TTĐC, Mạng internet	243	14	1,86	0,86-18,6
Sử dụng mổ dịch vụ	*Có*	397	11		
	Không	46	1	0,78	0,16-10,1
Sử dụng giường dịch vụ	*Có*	213	5		
	Không	231	7	1,29	0,4-4,1

Nhận xét: Bảng 3.16 cho thấy, người bệnh đến KCB lần đầu có sự hài lòng về sinh hoạt tại bệnh viện, cao gấp 3,86 lần người bệnh đến KCB lần lần 1. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về khoảng tin cậy 95%.

Kết quả nghiên cứu định tính ghi nhận ý kiến người bệnh cho thấy rằng cơ sở vật chất bệnh viện cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh, như *"ánh sáng cần hạn chế vào ban đêm"* (Người bệnh nam, 51 tuổi, mã số 39760) hay *"cần có rèm che cho người bệnh đỡ nắng"* (Người bệnh nam, 28 tuổi, mã số 19961)

3.3.6. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh về chi phí chữa bệnh

Bảng 3.17: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh về chi phí chữa bệnh.

Các yếu tố liên quan		**Hài lòng với chi phí KCB**		**OR**	**95% CI**
		HL	Chưa HL		
Nhóm tuổi	*< 50 tuổi*	195	48	1,34	0,86-2,08
	≥ 50 tuổi	161	53		
Giới	*Nam*	145	48	0,76	0,48-1,18
	Nữ	211	53		
Trình độ học vấn	*Trung cấp, PTTH trở xuống*	307	86	1,09	0,58-2,04
	CĐ, ĐH, Sau ĐH	49	15		
Nghề nghiệp	*Nông dân, lao động tự do*	224	132	0,02	0,38-1,01
	Công nhân, Công chức, hưu trí, HSSV	74	27		
Tình trạng hôn nhân	*Có gia đình*	311	84	1,28	0,69-2,38
	Độc thân, ly thân, ly hôn, góa	46	16		
Thu nhập trung bình/ tháng	*≥ 1,500,000*	261	95	0,81	0,48-1,37
	<1,500,000	95	23		
Số lần KCB tại Khoa/năm	*Lần đầu*	321	81	2,26	1,23-4,15*
	≥ 2 lần	35	20		
BHYT	*Có BHYT*	306	73	2,34	1,37-3,99*
	Không BHYT	50	28		
Hình thức sử dụng dịch vụ	*Chuyển tuyến*	259	97	1,9	1,2-3,02*
	Tự đến	59	42		
Cách tiếp cận thông tin	*Bạn bè, người quen giới thiệu*	149	51	0,83	0,53-1,31
	Phương tiện TTĐC, Mạng internet	200	57		
Sử dụng mổ dịch vụ	*Có*	318	90	1,08	0,45-1,89
	Không	36	11		
Sử dụng giường dịch vụ	*Có*	163	55	0,71	0,45-1,11
	Không	192	46		

Nhận xét: Bảng 3.17 cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng của người bệnh về chi phí khám bệnh với các yếu tố: Số lần KCB tại Khoa/năm, Đối tượng và hình thức sử dụng dịch vụ. Người bệnh đến KCB lần đầu tại Khoa tỷ lệ hài lòng về chi phí KCB cao gấp hơn 2 lần người đến khám ≥ 2 lần. Người bệnh có BHYT hài lòng với chi phí KCB cao gấp 2,3 lần người bệnh không có BHYT và người bệnh được chuyển tuyến hài lòng gấp gần 2 lần so với người tự đến khám.

Kết quả nghiên cứu định tính ghi nhận ý kiến thu nhập của người dân, yếu tố thu nhập thấp ảnh hưởng đến sự hài lòng, như *"Các chi phí phụ kiện còn cao so với đông đảo người dân"* (Người bệnh nam, 69 tuổi, mã số 39889)

Chương 4
BÀN LUẬN

4.1. Một số đặc điểm và sự hài lòng chung của người bệnh đến khám tại Khoa Phẫu thuật Cột sống - Viện Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Việt Đức.

Nghiên cứu về "Sự hài lòng của người bệnh phẫu thuật bệnh lý cột sống tại Khoa Phẫu thuật Cột sống - Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức" được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2015 trên tổng số 457 người bệnh. Trong đó, bảng 3.1 cho thấy, người bệnh có độ tuổi <50 chiếm tỷ lệ cao hơn nhóm ≥ 50 tuổi (53,2% so với 46,8%), tỷ lệ hài lòng chung của hai nhóm là gần tương đương nhau. Tỷ lệ người bệnh là nữ chiếm khoảng gần 58%, tức cao hơn so với nam, đồng thời, người bệnh nữ hài lòng chung với chất lượng các dịch vụ tại Khoa là 71,6%, cao hơn nam gần 6%. Ngoài ra, về khía cạnh dân tộc, hầu hết người bệnh thuộc dân tộc Kinh, chiếm tới gần 97%, ngược lại chỉ có 3,3% thuộc các dân tộc khác, tuy nhiên trong đó, tỷ lệ dân tộc khác lại hài lòng chung cao hơn khá nhiều so với dân tộc Kinh. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì Bệnh viện Việt Đức là một trong những bệnh viện lớn nằm tại trung tâm thủ đô Hà Nội, cho nên người bệnh dân tộc Kinh tiếp cận thuận lợi được nhất, thêm vào đó, người dân tộc khác, thường họ được chuyển đến từ những tỉnh khó khăn hơn cả về điều kiện sinh hoạt và y tế so với Hà nội, nên họ sẽ dàng hài lòng với điều trị tại Khoa hơn. Về trình độ học vấn, người bệnh có có trình độ CĐ/ĐH/sau ĐH chiếm tỷ lệ khoảng 14%, chỉ bằng khoảng 1/6 người có trình độ Trung cấp/PTTH trở xuống, và tỷ lệ hài lòng chung của nhóm Trung cấp/PTTH trở xuống lại cao hơn (69,5% so với 65,6%). Những kết quả này tương đồng với kết quả mà Lý Thị Thúy thu được tại bệnh viện Bạch Mai năm 2014, khi tác giả cho biết người đến khám tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện này cũng chủ yếu là dân tộc Kinh (chiếm 98,5%), tỷ lệ nữ cao hơn nam và người bệnh có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ khiêm tốn hơn rất nhiều so với tổng các đối tượng khác [31].

Mặt khác, về nghề nghiệp, người bệnh phần lớn là nông dân/lao động tự do (chiếm 56,5%), tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh theo nhóm nghề nghiệp là gần tương đương nhau (khoảng 68%). Từ đó, ta có thể thấy có sự tương ứng giữa nghề nghiệp với trình độ học vấn đã nêu trên, tức là người bệnh có trình độ đại học và sau đại học chiếm tỷ lệ khá thấp tương ứng với nghề nghiệp là công chức, hưu trí, học sinh sinh viên cũng chiếm tỷ lệ thấp hơn so với các nghề như nông dân hoặc lao động tự do. Về tình trạng hôn nhân, tỷ lệ người bệnh đã có gia đình chiếm tới 86,4%, gấp khoảng 6,4 lần các đối tượng còn lại, song song với đó, tỷ lệ hài lòng chung của nhóm đã có gia đình (69,8%), nhiều hơn nhóm còn lại tới gần 7%-kết quả được lý giải bởi những người đã có gia đình thì tâm lý họ sẽ tốt hơn đồng thời có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người thân hơn nên sẽ hài lòng cao hơn. Thêm vào đó, điều này cũng phù hợp với độ tuổi của người bệnh đến điều trị, vì tuổi trung bình của họ là 46,65±14,61 tuổi, ở độ tuổi này thì phần lớn người dân đã lập gia đình và đây cũng là độ tuổi dễ gặp các thương tổn bệnh lý về cột sống. Ngoài ra, thu nhập bình quân/tháng của một người bệnh cho thấy, người có thu nhập trung bình <1,5 triệu đồng/tháng chỉ chiếm xấp xỉ 1/4 tổng số đối tượng tham gia nghiên cứu, còn lại phần lớn người bệnh đều có thu nhập trung bình/tháng lớn hơn hoặc bằng 1,5 triệu đồng, đồng thời, tỷ lệ hài lòng của nhóm có thu nhập cao hơn cũng cao hơn nhóm có thu nhập ít hơn (69,6% so với 67%), đây cũng là một điều dễ hiểu bởi vì người có thu nhập cao hơn thì họ có điều kiện để sử dụng những dịch vụ tốt hơn cũng như không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tài chi phí khám chữa bệnh nên sự hài lòng có thể nhiều hơn. Ngoài ra, kết quả vừa nêu đã phản ánh thực tế rằng còn có một bộ phận lớn người bệnh có thu nhập khá thấp, do đối tượng người bệnh là nông dân là lao động tự do chiếm số đông. Vì vậy, điều này có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho việc trang trải chi phí KCB cũng như những khoản phụ phí khác bởi vì các bệnh lý liên quan đến phẫu thuật cột sống có thể cần phương pháp điều trị kỹ thuật cao do đó đòi hỏi phải tiêu tốn một chi phí khá lớn cho điều trị. Điều này đặt ra thực tế rằng lãnh đạo bệnh viện cũng cần quan tâm hơn tới những người bệnh này để tăng thêm sự hài lòng cho họ, đồng thời cũng là nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện nói chung.

Bảng 3.2 cho thấy, người bệnh lần đầu đến điều trị tại Khoa PTCS chiếm tỷ lệ tới 87,9%, gấp hơn 6 lần người đến từ 2 lần trở lên, không những thế, tỷ lệ hài lòng chung của người mới đến khám lần đầu đạt tới gần 70%, nhiều hơn nhóm còn lại hơn 6%. Điều này có thể được lý giải là do người bệnh mới đến khám lần đầu không có sự so sánh với lần trước như những người đã từng đến điều trị Khoa, do đó mà họ dễ dàng cảm thấy hài lòng hơn. Về sử dụng BHYT, người đến KCB bằng thẻ BHYT chiếm tỷ lệ cao hơn, đồng thời sự hài lòng cũng nhiều so với nhóm không có thẻ BHYT. Ngày nay, do chương trình BHYT toàn dân ngày càng rộng nên người bệnh khám và điều trị bằng thẻ BHYT nhiều hơn, đồng thời, KCB bằng thẻ BHYT người bệnh được cơ quan Bảo hiểm hỗ trợ các khoản chi phí điều trị, vì vậy đây cũng có thể là một trong các lý do giải thích vì sao tỷ lệ hài lòng của này cao hơn. Ngày nay do các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng internet phát triển nên việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, điều này lý giải cho việc người bệnh đến KCB tại Khoa qua tìm hiểu các kênh thông tin đại chúng chiếm tỷ lệ cao 57,1% Tuy nhiên sự hài lòng chung của nhóm người bệnh do bạn bè, người quen giới thiệu mặc dù ít hơn về số lượng nhưng tỷ lệ hài lòng lại cao hơn tới khoảng 5,5%. Nhóm người bệnh có sử dụng dịch vụ mổ theo yêu cầu tuy chiếm phần lớn, cao hơn khoảng 8 lần, nhưng lại đạt tỷ lệ hài lòng thấp hơn nhóm không mổ theo yêu cầu. Ngoài ra, nhóm người bệnh có sử dụng dịch vụ giường yêu cầu hài lòng nhiều hơn so với không sử dụng. Lý giải kết quả này, có thể do người bệnh dùng giường theo yêu cầu nghĩa là họ có điều kiện nằm viện tốt hơn, tiện nghi và điều kiện CSVC tốt hơn nên họ sẽ hài lòng hơn.

Như vậy, nhìn chung, dựa vào kết quả có thể thấy rằng người bệnh phẫu thuật bệnh lý cột sống tại Khoa PTCS, Bệnh viện Việt Đức có sự phân bố rất đa dạng về tuổi, giới, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp cũng như thu nhập bình quân/người/tháng. Điều này đã bước đầu đặt ra thách thức đối với lãnh đạo của bệnh viện, đó là cần xây dựng những kế hoạch, giải quyết linh hoạt để có sự hợp lý tốt nhất với từng đối tượng người bệnh, và thực hiện thêm các nghiên cứu về sự hài lòng của họ, từ đó cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đem đến sự hài lòng cao cho người bệnh khi sử dụng các dịch vụ y tế của bệnh viện.

4.2. Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Phẫu thuật Cột sống -Viện Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Việt Đức..

Bảng 3.4 ghi nhận kết quả phần lớn người bệnh hài lòng với *thời gian chờ tiếp cận dịch vụ y tế* tại Khoa PTCS, khi tất cả 4 tiểu mục nhỏ trong yếu tố này đều có sự hài lòng đạt trên 77%. Trong đó, tỷ lệ người bệnh hài lòng cao nhất là với "Thời gian chờ sự có mặt của điều dưỡng" (đạt tới 95%), thấp nhất là hài lòng với "Thời gian chờ nhân viên tiếp đón" và "Thời gian chờ mổ", lần lượt chỉ đạt 77,3% và 77,6% người bệnh hài lòng. Số liệu thu được trong bảng 3.4 của chúng tôi có kết quả khá tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Đức Thành "Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện tỉnh Hòa Bình vào năm 2006" cũng cho thấy một số lượng đáng kể người bệnh chưa hài lòng về thời gian chờ đợi khi tiếp cận dịch vụ [29].

Qua kết quả này và thực tế công việc tại khoa thấy rằng, thường người bệnh kém hài lòng khi phải chờ đợi lâu để được nhận giường, từ đây có thể biết được thực trạng hiện đang tồn tại tại khoa PTCS là lượng người bệnh nội trú tại khoa đông và không có giường trống để người bệnh có thể nhận được giường ngay khi nhập viện, trong khi đó quy trình chuẩn bị trước mổ yêu cầu chính xác và hiệu quả cao nên người bệnh phải nhập viện sớm buổi sáng để hoàn thành đầy đủ hồ sơ. Có những người bệnh khi nhập viện mới làm xét nghiệm hay chiếu chụp X-quang vì họ còn chờ chuyển BHYT, nếu vào viện buổi chiều sẽ không kịp thời gian để chuẩn bị hồ sơ. Vì thế ảnh hưởng trực tiếp đến ca mổ của họ do hồ sơ chưa đủ thủ tục và điều này cũng gây ảnh hưởng đến người bệnh khác. Mặt khác, các khâu nộp viện phí cũng đòi hỏi thời gian khá lâu nên cũng tác động tới thời gian chờ đợi. Kết quả nghiên cứu định tính cũng ghi nhận rất nhiều ý kiến của người bệnh không hài lòng với thời gian tiếp cận với dịch vụ y tế. Như người bệnh có ý kiến rằng *"Thời gian nhập viện và nhận giường quá lâu"* (người bệnh nam, 48 tuổi, mã số 40285) hay *"Thời gian chờ mổ lâu, cần công khai thứ tự lịch mổ"* (người bệnh nữ, 52 tuổi, mã số 38079). Điều này cũng đã phần nào lý giải nguyên nhân làm cho người bệnh ít hài lòng về thời gian chờ mổ: Thứ nhất, có thể do thời người bệnh phải chờ đợi lâu

mới đến lượt mổ. Thứ hai là thứ tự lịch mổ chưa dán công khai cho người bệnh nên phải chờ đợi mà không biết lúc nào đến lượt của mình. Còn về phía các nhân viên, họ cho biết thời gian chờ mổ lâu thì "*các bác sỹ không thể quyết định được bởi vì người bệnh được mổ còn phụ thuộc vào bàn mổ và dụng cụ phẫu thuật*" (TLN bác sỹ điều trị - mã số 03). Ngoài ra, ý kiến lãnh đạo khoa cho rằng khoa đã hết sức cố gắng để liên hệ, các phòng mổ khác buổi sáng là phòng mổ bệnh viện, buổi chiều là phòng mổ cột sống. Ở nước ngoài ngày chỉ mổ 1 – 2 ca còn đây ngày mổ 14 -15 ca rải thành 5 – 6 bàn thì khó mà tránh khỏi chờ đợi, nên cố gắng đảm bảo hoàn thành về chất lượng cuộc mổ. *"Người bệnh có chỉ định mổ đôi khi chưa muốn mổ ngay để đi chữa đông y đến khi nặng rồi mới đi mổ ai cũng muốn mổ ngay nên bác sỹ cũng có áp lực"* (PVS bác sỹ lãnh đạo Viện - mã số 01). Đi tìm một số giải pháp can thiệp vấn đề ở đây là sự phối hợp giữa bác sỹ và điều dưỡng của khoa cần giải thích kịp thời cho người bệnh hiểu lý do và có biện pháp giải quyết trong thời gian chờ đợi, ví dụ: truyền dịch hoặc người bệnh có lịch mổ buổi chiều thì buổi sáng cho uống sữa… Tâm lý người bệnh chờ mổ thì lo lắng, nhịn đói lâu, mỏi mệt nên việc bác sỹ giải thích rất quan trọng. Không chỉ vậy, ngoài việc giải thích kỹ cho người bệnh, việc sắp xếp lịch mổ cũng rất quan trọng như: dự kiến thời gian mổ để điều chỉnh số lượng người bệnh phù hợp. Trang bị cho khu vực chờ mổ các phương tiện truyền thông, tài liệu tư vấn GDSK để người bệnh trong lúc chờ đợi tranh thủ cập nhật thông tin tạo tâm lý thoải mái và nâng cao sự hiểu biết cho người bệnh. Tại tiểu mục 3, có 90% người bệnh *"Hài lòng với thời gian chờ sự có mặt của điều dưỡng"*, kết quả này cao hơn nghiên cứu của tác giả Trịnh Hồng Sơn và cộng sự năm 2014 khi khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Việt đức tháng 9 năm 2014 chỉ có 70,1% người bệnh hài lòng. Khoa PTCS có hệ thống chuông báo gọi NVYT, có hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại từng buồng bệnh, các đơn nguyên có đông người bệnh có điều dưỡng chăm sóc từng buồng để hỗ trợ khi người bệnh cần. Tuy nhiên, trong các giờ trực, việc đi tua các buồng bệnh là công việc thường quy vẫn cần được duy trì. Và khi người bệnh nhận được sự quan tâm của NVYT thì chắc chắn tỷ lệ hài lòng sẽ tăng cao.

Như vậy *Thời gian tiếp cận được dịch vụ y tế* của người bệnh là yếu tố đầu tiên và đóng vai trò khá quan trọng, ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh. Chính vì vậy, vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ Y tế nước ta đã ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện để rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh [56].

Điều dưỡng là một trong những bộ phận cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ và có thời gian tiếp xúc nhiều nhất nên liên quan mật thiết đến sự hài lòng của người bệnh. Vì vậy, hài lòng với sự chăm sóc của điều dưỡng là một mảnh ghép quan trọng trong việc hình thành nên hệ thống hài lòng chung của người bệnh với các dịch vụ y tế tại bệnh viện.

Bảng 3.5 đánh giá và đo lường *Sự hài lòng với chăm sóc của Điều dưỡng* được thông qua 8 tiểu mục nhỏ. Kết quả thu được cho thấy, hầu hết tỷ lệ người bệnh hài lòng với từng tiểu mục trong yếu tố sự chăm sóc của điều dưỡng đều đạt >90%, tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh thực hiện đánh giá và sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện Việt Đức vào năm 2012, khi nghiên cứu xác định tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh với chất lượng chăm sóc của điều dưỡng là 93,5% [3]. Trong đó, tỷ lệ hài lòng cao nhất là với "Quy trình chuẩn bị trước mổ của ĐD", chiếm tới gần 95%, thấp nhất là hài lòng với "Sự lắng nghe của Điều dưỡng khi nghe người bệnh trình bày". Ngoài ra, về "Thái độ phục vụ thân thiện và tôn trọng người bệnh của Điều dưỡng", có tới khoảng gần 94% người bệnh đồng ý với điều này. Kết quả này gần tương đồng với nghiên cứu của Trương Quan Trung và cộng sự vào năm 2011 về nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bởi vì tác giả cho biết: Hơn 90% người trả lời đều đồng ý về việc họ nhận được sự ân cần và tôn trọng của các nhân viên y tế khác, trong đó có điều dưỡng khi đến thăm khám tại bệnh viện. Tỷ lệ người bệnh hài lòng với điều dưỡng khá cao (91,6%) và cuối cùng là nhóm nhân viên y tế khác (90,9%) [57]. Về tiểu mục "Hài lòng với việc giải thích cho người bệnh trước khi làm thủ thuật chăm sóc", tỷ lệ

người bệnh hài lòng là khá cao, đạt tới 93,0%. Kết quả này thu được thấp hơn một chút so với nghiên cứu của tác giả Ngô Thị Ngoãn và công sự thực hiện vào năm 2002 tại năm bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh, khi tác giả cho biết có tới 94,3% người được hỏi trả lời hài lòng với sự nhiệt tình của điều dưỡng, 96% hài lòng với việc điều dưỡng giải thích thắc mắc cho người bệnh và 96,5% công nhận rằng điều dưỡng rất tôn trọng người bệnh [58]. Tỷ lệ người bệnh hài lòng với giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh và thân nhân của họ đạt 89,9%, tỉ lệ này thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Phạm Nhật Yên khi tác giả cho thấy tỷ lệ người bệnh hài lòng với sự giao tiếp và tương tác của nhân viên y tế đạt từ 90,2% đến 94,5% [38]. Tuy nhiên, kết quả này của chúng tôi lại cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Đức Thành được thực hiện vào năm 2006 về sự hài lòng của người bệnh nội trú tại các bệnh viện tỉnh Hòa Bình bởi tác giả này cho thấy tỉ lệ người bệnh hài lòng với sự chăm sóc của nhân viên y tế chỉ đạt từ 57,8% đến 85,3% [29]. Giao tiếp với người bệnh luôn là tiêu chí hàng đầu được đặt ra trong công việc của điều dưỡng khi tiếp xúc với người bệnh. Tuy nhiên các yếu tố về giao tiếp như "giao tiếp của ĐD với người bệnh và thân nhân" và "sự lắng nghe của ĐD khi nghe người bệnh trình bày" vẫn còn 10,1% và 13,6% người bệnh chưa hài lòng. Tỷ lệ cho thấy còn có điều dưỡng ít giao tiếp và hạn chế chia sẻ thông tin với người bệnh. Điều này đặt ra cho ban lãnh đạo bệnh viện và khoa PTCS cần thường xuyên tập huấn kỹ năng giao tiếp cũng như tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở đồng thời biểu dương những tấm gương được người bệnh và người thân ghi nhận trong sổ góp ý của khoa.

Về phía kỹ thuật viên của khoa, các nhân viên cho biết lý do tại sao vẫn còn 8,6% người bệnh chưa hài lòng với "Hướng dẫn và tập phục hồi chức năng tại giường: *"Người bệnh đông, nhân viên lại chỉ có 1 nên áp lực công việc cao" hay "Bài tập tài liệu về phục hồi chức năng sau mổ cột sống ngoại khoa không nhiều nên kỹ thuật viên chỉ hướng dẫn người bệnh theo kinh nghiệm hoặc được truyền lại"* (TLN Kỹ thuật viên, nam, mã số 04). Về ý kiến còn có người bệnh không hài lòng với "Sự lắng nghe của điều dưỡng khi người bệnh trình bày", nhân viên y tế cho biết *"Phần lớn người bệnh và người nhà người bệnh thắc mắc ngoài giờ hành*

chính, nhân viên điều dưỡng ít trong khi người bệnh đông, nên khó có thể giải quyết thắc mắc hết ngay được"(TLN Điều dưỡng nữ, mã số 05), nhiều khi người bệnh hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến bệnh tật nên điều dưỡng không thể trả lời ngay mà phải báo lại để bác sỹ trực buồng hoặc trực viện giải quyết.

Thực tế hiện nay, do cường độ làm việc bệnh viện ngoại khoa mọi công việc đều đảm bảo tính chính xác và hiệu quả cao điều dưỡng tại đây chịu áp lực rất lớn. Đặc biệt là với tình trạng quá tải của bệnh viện như hiện nay cũng như do nhu cầu của người bệnh ngày càng cao họ sẽ đòi hỏi khắt khe hơn trong việc đánh giá thái độ của các nhân viên y tế.

Sự hài lòng với điều trị của bác sỹ dựa trên 6 tiểu mục nhỏ theo kết quả bảng 3.6, tỷ lệ người bệnh được phỏng vấn hài lòng với các tiểu mục trong yếu tố công tác điều trị của bác sỹ đều đạt trên 88%. Trong đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là "Hài lòng với việc khám và chẩn đoán bệnh của bác sỹ" với 97,6%. Kết quả này cho thấy các bác sỹ khoa PTCS có trình độ chuyên môn cao, được người bệnh rất tin tưởng. Hầu hết các bác sỹ khoa PTCS đều là bác sỹ nội trú tốt nghiệp trường Đại học Y Hà nội đã có thời gian học tập và làm việc tại bệnh viện ít nhất từ 8 năm trở lên, được sự dìu dắt và giảng dạy của các giáo sư đầu ngành về ngoại khoa. Những năm tháng gắn bó với bệnh viện thể hiện lòng tâm huyết, trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm với người bệnh.

Tiểu mục "Sự lắng nghe của bác sỹ khi nghe người bệnh trình bày về bệnh tật" người bệnh ít hài lòng nhất với 88,2%. Các tiểu mục khác gồm: Hài lòng với việc thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của bác sỹ, hài lòng với thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ, hài lòng với việc thăm khám bệnh hàng ngày của bác sỹ, hài lòng với kết quả điều trị giảm đau sau mổ của bác sỹ đều đạt trên 91%. Những kết quả này có sự tương đồng với nghiên cứu của Trương Quan Trung và cộng sự, khi tác giả cho biết hơn 90% người bệnh được hỏi hài lòng với thái độ ân cần và tôn trọng của bác sỹ đối với mình [57]. Nghiên cứu của Phạm Nhật Yên cũng cho thấy người bệnh rất hài lòng với yếu tố giao tiếp và tương tác với bác sĩ. Điểm trung bình hài lòng với các tiểu mục thuộc về bác sĩ đạt cao từ

4,25 - 4,41 và tỷ lệ người bệnh hài lòng với các tiểu mục thuộc về bác sĩ đạt từ 86,9% đến 93,7%. Đây được xem là điểm mạnh của khoa KCBTYC. Tuy vậy, tác giả cũng đưa ra vấn đề cần chú ý đến 2 tiểu mục có tỷ lệ người bệnh hài lòng thấp nhất trong yếu tố giao tiếp và tương tác với bác sĩ là hài lòng về sự giải thích kết quả xét nghiệm – CDHA (87%) và hài lòng về giải thích tình trạng bệnh tật [38].

Tiến hành thu thập và tổng hợp thông tin bằng nghiên cứu định tính cũng cho thấy một vài phản ánh của người bệnh liên quan công tác điều trị của bác sỹ. Không phải mọi người bệnh đều có những đánh giá không tốt về bác sỹ. Có người bệnh cho biết rằng *"Được bác sỹ chăm sóc hỏi han rất tận tình"* (người bệnh nam, 56 tuổi, mã số 38558), người bệnh khác *"Rất cảm ơn bác sỹ và nhân viên y tế của khoa đã phục vụ người bệnh tận tình"* (người bệnh nam, 73 tuổi, mã số 39158). Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại nhiều nhận xét chưa hài lòng của người bệnh, như *"Bác sỹ ít dành thời gian nói chuyện với người bệnh"* (người bệnh nam, 51 tuổi, mã số 39760), *hay "Mong muốn bác sỹ thăm khám từng người bệnh kỹ càng, tỷ mỷ hơn"* (người bệnh nam, 72 tuổi, mã số 40133). Điều này cho thấy đây là một vấn đề khó tránh khỏi trong tình hình nhu cầu KCB của người dân hiện nay ngày càng tăng dẫn đến hiện tượng quá tải bệnh viện. Chính bởi vậy nên bác sỹ không có thời gian để dành nhiều cho một người bệnh, vì sau khi khám xong cho người bệnh này thì họ đã phải tiếp đón ngay người bệnh khác. Ngoài ra, theo kết quả thu được từ nghiên cứu định tính, những lý do làm người bệnh không hải lòng với sự chăm sóc của bác sỹ tại khoa PTCS chủ yếu là về việc bác sỹ dành ít thời gian cho người bệnh, còn lý do dẫn tới điều này trong nghiên cứu của Bùi Dương Vân và Nguyễn Thị Hồng Thái chủ yếu là bác sỹ, nhân viên có thái độ gay gắt hoặc trả lời sơ sài khi người bệnh hỏi, hoặc không muốn giải đáp thắc mắc.

Nhìn chung, những kết quả trên đây đã cho thấy, sự quan tâm của bác sỹ tại khoa PTCS đã được người bệnh đánh giá khá cao về khía cạnh chuyên môn, khả năng khám phát hiện bệnh cũng như chữa trị, giải thích các thông tin mà người bệnh còn thắc mắc trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sỹ cần dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người bệnh đối với bệnh tật của họ, bởi vì

người bệnh thường không chỉ có nhu cầu về điều trị các vấn đề sức khỏe thể xác mà họ còn mong muốn được làm an tâm hơn về mặt tinh thần khi được những người có chuyên môn như các bác sỹ tư vấn. Do đó, yêu cầu với bác sỹ tại khoa PTCS nói chung đó là, bác sỹ cũng cần thêm kỹ năng biết lắng nghe, cảm thông để người bệnh cảm nhận được rằng họ đang được quan tâm, được sẻ chia, qua đó có thể tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh hơn.

Người bệnh đến bệnh viện không chỉ được điều trị về mặt chuyên môn mà họ còn cần được cung cấp những kiến thức về bệnh tật và tập luyện, dinh dưỡng... Bảng 3.7 đánh giá *sự hài lòng của người bệnh về tư vấn giáo dục sức khỏe* bao gồm 5 yếu tố. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người bệnh hài lòng về tư vấn giáo dục sức khỏe tại khoa ở mức thấp hơn so với điều trị của bác sỹ hay chăm sóc của điều dưỡng. Nhìn chung, sự hài lòng của người bệnh ở từng tiểu mục trong yếu tố này đạt từ 75,9% đến 85,2%. Trong đó, người bệnh hài lòng ít nhất với sự hướng dẫn của điều dưỡng về chế độ dinh dưỡng, tập luyện sau khi ra viện - chỉ khoảng 3/4 số người được hỏi hài lòng với tiểu mục này. Ngược lại, tỷ lệ hài lòng với hướng dẫn khi ra viện và với việc nghe, nhận tài liệu phổ biến nội quy trong quá trình nằm viện đạt tỷ lệ cao nhất với cùng 85,2%. Có khoảng 80% người bệnh hài lòng với sự tư vấn của bác sỹ về bệnh tật/hướng dẫn tập phục hồi chức năng. Câu hỏi đặt ra là tại sao người bệnh lại chưa hài lòng với tiểu mục 1 và 2 nhất? Sau khi tìm hiểu, một số lý do như sau: thứ nhất do lượng người bệnh quá tải dẫn đến khối lượng công việc của bác sỹ và điều dưỡng nhiều, khiến cho họ không có nhiều thời gian để tư vấn kỹ càng cho người bệnh. Thứ hai, tài liệu hướng dẫn về dinh dưỡng và tập luyện cho người bệnh sau phẫu thuật còn sơ sài. Việc truyền đạt bằng miệng thiếu hiệu quả do người bệnh không thể nhớ hết được nội dung tư vấn, đồng thời chưa có nhiều kinh phí cho in ấn tài liệu phát tay, do đó, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Vì vậy, ban lãnh đạo khoa PTCS cần quan tâm đến cung cấp tài liệu GDSK đến người bệnh bằng nhiều kênh thông tin khác nhau như: các trang mạng, truyền thông, tờ rơi…

Nghiên cứu định tính cũng thu nhận một số ý kiến đóng góp về yếu tố này của người bệnh. Có người bệnh đề xuất *"Mong muốn được khoa cung cấp hình ảnh,*

giấy tờ hướng dẫn tập PHCN" (người bệnh nam, 29 tuổi, mã số 18772) hay "*Kỹ thuật viên phục hồi chức năng cần tư vấn tỷ mỷ cẩn thận rõ ràng hơn cho người bệnh*" (người bệnh nữ, 54 tuổi, mã số 40003).

Đi tìm hiểu lý do tại sao vẫn còn tới 21% người bệnh chưa hài lòng về tư vấn của bác sỹ khi ra viện, các cán bộ y tế tại khoa đã nêu lên thực trạng: "*Số lượng bác sỹ không đông, cường độ làm việc cao - như chỉ có 1 bác sỹ trực buồng phụ trách ra viện"* (TLN bác sỹ điều trị, mã số 03). Tại khoa PTCS việc bác sỹ phụ mổ giải thích trước mổ cho người bệnh đã thành nền nếp và tâm lý người bệnh và người nhà ai cũng muốn được nghe bác sỹ tư vấn, tuy nhiên *"bác sỹ không đủ thời gian để giải thích được hết cho khoảng 10 người bệnh và 30 người nhà. Còn việc tư vấn giáo dục sức khỏe thực sự là rất thiếu, cần thành lập kênh thông tin riêng kiểu như trực điện thoại hay đường dây nóng để hỗ trợ cho người bệnh"* (TLN bác sỹ điều trị – mã số 04)

Vậy nên, để cải thiện sự hài lòng về tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh cần tìm hiểu nguyên nhân từ hai phía để có được một cách nhìn khách quan nhất, qua đó giúp tăng sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị.

Bảng 3.8 ghi lại kết quả về*"Sự hài lòng về sinh hoạt của người bệnh*", tỷ lệ người bệnh hài lòng với từng tiểu mục trong yếu tố "Sự hài lòng với sinh hoạt người bệnh" có sự chênh lệch đáng kể, từ 54,3% đến 96,7%. Trong khi, sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân trong khi nằm viện, đạt tỷ lệ hài lòng cao trên 96%. Đây cũng là một điều dễ hiểu, bởi người thân đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chữa trị của người bệnh, bởi họ là những người trực tiếp quan tâm, động viên và hỗ trợ người bệnh không những về mặt tinh thần mà còn cả về thể chất. Tuy nhiên, lại chỉ có >1/2 số người bệnh hài lòng với "khả năng tình dục của mình" đạt được sau phẫu thuật, nghĩa là tỷ lệ hài lòng của tiểu mục này là thấp nhất. Có thể bởi vì người bệnh ảnh hưởng tâm lý thời gian dài trước trong và sau phẫu thuật, họ sẽ thiếu tự tin với khả năng tình dục của bản thân và khó hài lòng với vấn đề nhạy cảm này. Với tỷ lệ gần 50% người bệnh chưa tự tin vào "khả năng tình dục của mình" được các bác sỹ cho rằng: ở đây có hai vấn đề, một là bệnh cột sống có thương tổn chèn ép thần kinh, người bệnh nên đi khám sớm và điều trị sớm, hai là

có đến 70 – 80% người bệnh sau mổ rối loạn cường dương do yếu tố tâm lý, thiếu tính tự tin nên việc giải thích của bác sỹ rất quan trọng để ổn định tâm lý, đặc biệt quan tâm đến người bệnh là nam giới.

Tỷ lệ người bệnh hài lòng với giấc ngủ tại bệnh viện cũng chỉ đạt được khoảng 70,6%. Kết quả này cho thấy vẫn còn gần khoảng 1/3 người bệnh được hỏi ngủ không ngon và không hài lòng với giấc ngủ trong bệnh viện. Điều này có thể lý giải là do môi trường tại bệnh viện khác hoàn toàn so với tại nhà đồng thời bản thân đang trong giai đoạn chữa bệnh cho nên có thể ảnh hưởng nhiều đến nghỉ ngơi và giấc ngủ của người bệnh.

Cũng theo ý kiến của một số nhân viên cho rằng thường các người bệnh ở các buồng riêng ngủ tốt hơn vì họ có thể tắt đèn ngủ chủ động, còn ở các buồng chung thì khó ngủ hơn do đông, các máy y tế kêu hoặc do giảm đau sau mổ còn chưa tốt.

Đề xuất giải pháp cải thiện cho yếu tố: "Sự hài lòng với sinh hoạt người bệnh" ban lãnh đạo khoa PTCS cần quan tâm hơn nữa đến nhu cầu người bệnh không chỉ được điều trị bệnh lý cột sống mà còn nhận được điều trị về mặt tâm sinh lý giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống, qua đó làm tăng sự hài lòng của người bệnh. Vì vậy, khoa PTCS cần phối hợp với Trung tâm Nam học điều trị cho người bệnh, có thể điều trị tâm lý hoặc bằng thuốc. Đây là vấn đề rất nhạy cảm nhưng lại rất thực tế, nên chú trọng nhiều hơn cho người bệnh nam.

Tóm lại, đánh giá sự cảm nhận của người bệnh là yếu tố quan trọng để giúp nhà quản lý tìm ra các phương pháp hỗ trợ giúp cho người bệnh hài lòng về chất lượng cuộc sống ngay cả khi đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Bảng 3.9 đo lường mức độ *"Hài lòng với cơ sở vật chất"* cho thấy, người bệnh khá hài lòng với điều kiện cơ sở vật chất của khoa PTCS. Các tiểu mục trong yếu tố cơ sở vật chất tại Khoa đều đáp ứng được trên 76% sự hài lòng của người bệnh, tỷ lệ hài lòng dao động từ 76,9% đến 95,6%, cao hơn so với nghiên cứu của Lý Thị Thúy được thực hiện tại Khoa Khám bệnh - bệnh viện Bạch Mai năm 2014, bới tác giả chỉ ra: Sự hài lòng của người bệnh và người nhà của họ khi đến khám tại đây chiếm từ 61,9% đến 86,1%. Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy những

kết quả hài lòng tích cực hơn so với một vài nghiên cứu khác. Khảo sát của Nguyễn Đức Thành chỉ ra rằng người bệnh chưa thực sự hài lòng với yếu tố cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tại bệnh viện tỉnh Hòa Bình. Các tiểu mục thuộc yếu tố này có điểm trung bình đạt rất thấp, chỉ từ 2,67 đến 3,61 (thang điểm Likert 5 mức độ) và tỷ lệ hài lòng của người bệnh là chưa cao [29].

Cụ thể với từng tiểu mục, người bệnh hài lòng nhiều nhất với "Trang thiết bị y tế của khoa phòng", chiếm 95,6%. Trong khi đó, tỷ lệ người bệnh hài lòng thấp nhất là với "Khu nhà vệ sinh buồng bệnh" (76,9%). Kết quả hài lòng với tiểu mục này của chúng tôi tuy cao hơn đáng kể - tới 47,4% so với nghiên cứu của Trần Thị Hà Giang tại bệnh viện Da liễu Trung ương vào năm 2011, tác giả cũng cho biết: trong yếu tố hài lòng của người bệnh với cơ sở vật chất/môi trường của bệnh viện cho thấy điểm trung bình hài lòng đối với yếu tố này khá cao từ 3,25 – 4,04 và tỷ lệ hài lòng khá cao từ 82,7% – 90,7% ngoại trừ tiểu mục hài lòng đối với sự sạch sẽ của nhà vệ sinh đạt rất thấp, chỉ có 32,5% người bệnh hài lòng [32].

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu định tính ghi nhận rất nhiều ý kiến với cơ sở vật chất của người bệnh. Như có ý kiến của người bệnh chưa hài lòng về *"Nhà vệ sinh ít, có lúc còn chưa sạch, Buồng cấp cứu ồn, diện tích chật, đông người, quần áo còn nhàu, cũ"* (người bệnh nam, 49 tuổi, mã số 39492) và "*nhà vệ sinh nên có quạt thông gió và thoát nước tốt" (*người bệnh nữ, 37 tuổi, mã số 19769), "*cần có rèm che cho người bệnh đỡ nóng*" (người bệnh nam 28 tuổi – mã số 19961). Những ý kiến này của người bệnh có sự tương đồng với kết quả thu được tại bệnh viện Da liễu Trung ương của Trần Thị Hà Giang người bệnh chưa hài lòng vì nhà vệ sinh bẩn, chật, có mùi hôi khiến người bệnh không muốn vào [32]. Cũng giống nghiên cứu của Nguyễn Thị Ly và Hà Thị Soạn thì người bệnh chưa thực sự hài lòng với điều kiện nhà vệ sinh và cơ sở vật chất của bệnh viện: nhà vệ sinh không đủ nước, còn bẩn, không đủ ánh sáng và cơ sở vật chất còn chật chội, thiếu thốn [59]. Quan sát thực tế tại khoa, khoa khá khang trang, sạch đẹp. Các buồng bệnh đều có nhà vệ sinh khép kín, các tiện nghi được trang bị đầy đủ (bình nóng lạnh, vòi hoa sen,…). Tuy nhiên, do lưu lượng sử dụng lớn nên nền nhà vệ sinh, đặc biệt và các giờ người

nhà vào thăm thì nền nhà vệ sinh thường không khô. Chính bởi vậy, có thể gây nên khó chịu hoặc cảm giác không an toàn cho người bệnh (trơn, trượt). Giải pháp cho vấn đề này là khoa cần tăng cường thời lượng dọn dẹp vào các thời điểm đông người để giữ nhà vệ sinh luôn khô thoáng, sạch sẽ vừa làm tăng hài lòng của người bệnh đồng thời cũng góp phần vào hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện.

Khi người bệnh và người nhà phải chờ đợi được thực hiện các dịch vụ y tế lâu thì khu vực ngồi chờ cũng là một khía cạnh cần được lãnh đạo bệnh viện lưu tâm hơn. Người bệnh có ý kiến *"Chỗ ngồi chờ của người nhà còn thiếu"* (người bệnh nam, 50 tuổi, mã số 39849). Đây cũng là một thực trạng không chỉ đang tồn tại ở khoa PTCS mà còn là bức tranh chung của rất nhiều bệnh viện khác. Vậy nên, thông qua những góp ý trên của người bệnh, các nhà quản lý và lãnh đạo bệnh viện cần xây dựng kế hoạch cải thiện khu vực ngồi chờ cho người bệnh. Không những cần đảm bảo đủ số lượng ghế ngồi chờ mà còn phải quan tâm đến các điều kiện khác như có điều hòa nhiệt độ, quạt, có các phương tiện truyền thông như tivi hay các tài liệu tư vấn GDSK cung cấp thông tin tiếp cận cho người bệnh và người nhà giúp họ ngồi chờ được thoải mái hơn, từ đó họ có xu hướng ít biểu lộ sự không hài lòng hơn cho dù thời gian chờ đợi có thể lâu thêm một chút.

Khoa PTCS vừa được chuyển sang khu nhà mới nên người bệnh khá hài lòng với cảnh quan, trang thiết bị và tiện nghi phục vụ của bệnh viện (đều đạt tỷ lệ hài lòng >90%). Tuy nhiên, một số vấn đề mà Khoa cần quan tâm đó là điều chỉnh hợp lý độ sáng của khoa phòng, kịp thời thay thế và sửa chữa các bóng đèn hỏng, điều chỉnh các nguồn sáng phù hợp hơn theo các thời điểm trong ngày. Ngoài ra, cũng cần chú ý tới diện tích buồng bệnh, sắp xếp các đồ dùng trong phòng hợp lý để người bệnh cảm thấy rộng rãi hơn. Đặc biệt, nhà vệ sinh là yếu tố mà người bệnh chưa thật sự hài lòng, do đó cần phải lưu ý khu vệ sinh đảm bảo điện nước, ánh sáng đầy đủ, kiểm tra giám sát nhân viên dọn vệ sinh thường xuyên quét dọn đồng thời việc sử dụng nhà vệ sinh cũng cần phải có ý thức của người bệnh mới đảm bảo được sự sạch sẽ chung.

Thực tế cho thấy, không chỉ riêng với khoa PTCS, trong điều kiện hiện nay các cơ sở y tế của Việt Nam, kể cả tuyến trung ương cũng chưa đáp ứng được đầy đủ mong đợi của người bệnh. Việc đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng là một công việc lâu dài và khó khăn bởi cần một khoản kinh phí rất lớn, cần có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, trong điều kiện có hạn của mình thì việc đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp, vệ sinh sạch sẽ cũng cần được quan tâm hơn nữa để người bệnh cảm thấy thoải mái khi đến KCB, nhằm đảm bảo sự hài lòng cho họ.

*Sự hài lòng với môi trường của bệnh viện***,** theo kết quả trong bảng 3.10, trên 84% người bệnh hài lòng với các tiểu mục trong yếu tố này. Trong đó, tỷ lệ hài lòng cao nhất là với "Sự sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện" lên tới 95,2%. Ngược lại, người bệnh ít hài lòng nhất với sự yên tĩnh trong bệnh viện, chỉ đạt 84,9%. Còn người bệnh hài lòng với an ninh và cây xanh trong bệnh viện đạt tỷ lệ khá cao với khoảng 92,5%.

Vấn đề an ninh tại bệnh viện hiện nay đang khá nóng bởi vì bệnh viện tập trung rất nhiều người lạ, ra vào, khó quản lý nên kẻ xấu lợi dụng để làm mất trật tự trị an và gây ra hoang mang cho người bệnh và người nhà của họ. Chính bởi vậy, qua tỷ lệ người bệnh hài lòng với an ninh trong bệnh viện khá cao đã cho thấy rằng hệ thống an ninh tại Bệnh viện Việt Đức đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy vậy, bệnh viện cũng không nên chủ quan, sao nhãng mà cần phải duy trì và làm tốt hơn hơn công tác bảo vệ, từ đó tiến tới mọi người bệnh đều cảm thấy an tâm, hài lòng. Công tác tập huấn về giao tiếp của nhân viên bảo vệ ở khoa cũng cần phải đề cập vì theo ý kiến người bệnh nam 35t – mã số 2899 "*bảo vệ có thái độ chưa lịch sự với người nhà người bệnh" hay "Nhiều khi bảo vệ còn nóng tính"*(người bệnh nam 73t – mã số 39158) Ngoài ra, dù có một tỷ lệ khá cao người bệnh thấy hài lòng với cây xanh trong bệnh viện nhưng trong nghiên cứu định tính vẫn cho thấy một số ý kiến rằng ""*Trong khuôn viên bệnh viện còn ít cây xanh, không gian bệnh viện cần mở rộng hơn"* (Người bệnh nam, 54 tuổi, mã số 39839). Thực tế, khoa PTCS mới được chuyển sang tòa nhà mới, cây xanh còn chưa có nhiều, nên người bênh ít cảm nhận về hình ảnh của cây xanh mà chủ yếu là thấy các

tòa nhà chức năng chuyên môn. Bởi vậy, nhằm giúp người bệnh thấy không khí mát mẻ và trong lành hơn thì bệnh viện cần đầu tư trồng thêm cây xanh, hạn chế chặt hạ cây lâu năm, chăm sóc lại khuôn viên cho hài hòa. Đặc biệt, vấn đề cần hết sức lưu tâm đến đó là bệnh viện cần làm gì để nâng cao tỷ lệ hài lòng hơn với sự yên tĩnh trong bệnh viện. Bởi vì, trong các tiểu mục của yếu tố môi trường bệnh viện, người bệnh kém hài lòng nhất là với vấn đề này. Thực chất, môi trường bệnh viện như một nơi công cộng, có rất nhiều người tương ứng với rất nhiều hoạt động diễn ra nên việc đảm bảo yên tĩnh là khá khó khăn. Tuy nhiên, có người bệnh nhận xét rằng *"Nhân viên trực buổi tối nói chuyện to"* (người bệnh nam, 53 tuổi, mã số 41728). Điều này có thể được can thiệp, khắc phục bằng cách nhắc nhở các nhân viên trực có ý thức hơn, đồng thời, bệnh viện cũng như khoa PTCS cần dán các quy định đi nhẹ, nói khẽ trong bệnh viện để không chỉ nhân viên y tế mà tất cả những người đến bệnh viện tuân thủ theo. Nếu tất cả đều làm theo quy định này thì có thể giúp nâng cao thêm sự hài lòng của người bệnh. Ngoài ra, cũng cần cân nhắc đến việc sắp xếp người bệnh hợp lý: bố trí người bệnh đã ổn định nằm riêng, không nằm chung với người bệnh cấp cứu, giúp cho họ có không gian yên tĩnh, để nghỉ ngơi và dễ dàng có giấc ngủ tốt hơn.

Hài lòng với hiệu quả và chi phí KCB là sự hài lòng với tổng chi phí của đợt điều trị so với kết quả mà người bệnh đạt được sau phẫu thuật. Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến sự hài lòng của người bệnh.

Kết quả thu được tại bảng 3.11 cho thấy, đa số người bệnh hài lòng với kết quả điều trị và chi phí khám chữa, bệnh, chiếm tỷ lệ gần 78%. Kết quả này của chúng tôi thu được cao hơn so với nghiên cứu của Trần Thị Cẩm Tú và cộng sự, thực hiện tại bệnh viện Trung ương Huế vào năm 2012, tác giả cho biết tại bệnh viện này có 65,7% người bệnh hài lòng với chi phí KCB; 67,8% người bệnh hài lòng với các khoản viện phí khác phải nộp và tỷ lệ người bệnh hài lòng chung về chi phí KCB, xét nghiệm là 67,4% [34]. Ngoài ra, tỷ lệ hài lòng với hiệu quả và chi phí KCB này cũng cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Phạm Nhật Yên, khi tác giả cho biết điểm trung bình về chi phí là 3,55 và tỷ lệ người bệnh hài lòng là 51,1% [38], nhưng lại

thấp hơn một chút so với nghiên cứu của Trương Quan Trung và cộng sự được thực hiện vào năm 2011 tại Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về tìm hiểu mục dịch vụ KCB nhận được có tương xứng với số tiền chi trả, với 78,2% người bệnh đồng ý [57].

Tuy nhiên, qua đây cũng thấy rằng vẫn còn một tỷ lệ lớn, tới gần 1/4 số người được hỏi trả lời họ không hài lòng với yếu tố sự tương xứng giữa hiệu quả với chi phí KCB của người bệnh. Người bệnh có ý kiến *"Các chi phí phụ kiện còn cao so với thu nhập của đông đảo người bệnh"* (Người bệnh nam, 66 tuổi, mã số 39889). Kết quả này đặt ra câu hỏi, tại sao và làm thế nào để làm tăng sự hài lòng của người bệnh hài lòng về chi phí điều trị phẫu thuật cột sống. Phẫu thuật cột sống là để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhiều người chấp nhận liệt, teo chân chứ họ không đi mổ, nhưng người ta phải cam chịu cho dù lẽ ra họ không đáng phải bị như thế vì phẫu thuật là phương án tối ưu dành cho họ khi điều trị nội khoa không hiệu quả. Vấn đề này được bác sỹ lãnh đạo Viện – mã số 01 đưa ra ý kiến *"Bởi vậy hệ thống trang thiết bị PTCS ngày càng đòi hỏi cập nhật liên tục và thiên về phẫu thuật can thiệp tối thiểu ít xâm lấn mang lại chất lượng cho người bệnh"* và "*do hệ thống TTB càng tiên tiến, chất lượng bao nhiêu thì người bệnh cũng phải cùng chịu một phần kinh phí giá thành cho những nghiên cứu cơ bản ban đầu"*. Có TTB của một số hãng dù giá rẻ do nhái giả công nghệ không phải đầu tư cho nghiên cứu cơ bản thì cũng không thể sử dụng được do không đảm bảo chất lượng. Giá cả vừa phải đảm bảo tính cạnh tranh nhưng đảm bảo tính chất lượng của cuộc mổ. Và chất lượng điều trị luôn là cốt lõi, thực tế khoa PTCS luôn quá tải đã nói lên điều đó. Bên cạnh đó, các bác sỹ cho biết, có nhiều phương án điều trị cho người bệnh, không phải người bệnh nào cũng phải mổ nẹp vít hay robot và người bệnh có quyền quyết định lựa chọn phương án hợp lý nhất phù hợp với hoàn cảnh của mình. Hiện nay nhiều người bệnh có điều kiện về kinh tế, mong muốn được phẫu thuật có sử dụng kỹ thuật cao và sẵn sàng chi trả nếu không họ sẽ chọn phương án sang nước ngoài điều trị nên cần đáp ứng tất cả các nhu cầu của người bệnh. Bởi vậy, các bác sỹ cần giải thích rõ ràng, thuyết phục cho người bệnh về các phương án điều trị tương ứng với

điều kiện kinh tế của họ và sự lựa chọn phù hợp nhất của họ sẽ góp phần làm tăng sự hài lòng người bệnh với yếu tố này.

Người bệnh không có BHYT trong bảng 3.17 chỉ chiếm 10,9% tổng số đối tượng nghiên cứu nhưng tỷ lệ chưa hài lòng chiếm tới 56%. Như vậy, BHYT đóng vai trò rất quan trọng trong đánh giá sự hài lòng của người bệnh phẫu thuật cột sống nói riêng và hệ thống chăm sóc sức khỏe nói chung. Một bộ phận không nhỏ người dân có quan niệm rằng chỉ khi có bệnh mới đi mua BHYT và các chi phí kỹ thuật cao được cơ quan BHYT chi trả sau 6 tháng tham gia bảo hiểm, nếu chờ đợi thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của người bệnh và nếu muốn điều trị sớm thì họ sẽ phải tự chi trả. Trên thực tế có không ít người bệnh đóng BHYT tự nguyện sẽ chờ đợi cho đủ thời gian mới đi điều trị, kể cả biết là muộn nhưng họ vẫn lựa chọn. Chính điều này cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Bởi vậy, để giải quyết vần đề này đối với các bác sỹ khoa PTCS không chỉ cần giải thích kỹ cho người bệnh về các chỉ định phẫu thuật và chi phí kèm theo mà còn đưa ra các phương án điều trị khác nhau, những diễn biến bệnh tật để người bệnh chọn lựa, qua đó tỷ lệ người bệnh hài lòng với yếu tố này sẽ cải thiện hơn.

Bảng 3.12 ghi nhận người bệnh đánh giá *sự hài lòng chung với dịch vụ tại khoa PTCS* với tỷ lệ 95,1%. Kết quả này chúng tôi thu được cao hơn so nghiên cứu của Lý Thị Thúy được thực hiện tại Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bạch mai, tỷ lệ người bệnh và người thân hài lòng với dịch vụ KCB tại đây là 79,3% [31]. Cũng tại Bệnh viện Bạch mai, ở Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, tác giả Phạm Nhật Yên nghiên cứu trên 206 người bệnh, sự hài lòng chung về chất lượng KCB đạt tỷ lệ trên 91% [38]. Tổng quan lại trong các nghiên cứu trên và thực tế kết quả sự hài lòng chung tại khoa PTCS đều có điểm chung là mặc dù người bệnh vẫn còn chưa hài lòng với một số yếu tố: Thời gian chờ đợi, giấc ngủ, chi phí KCB…. Nhưng với tổng thể các dịch vụ họ nhận được tại khoa PTCS người bệnh vẫn có tỷ lệ hài lòng cao trên 95,1%. Điều này chứng tỏ dịch vụ y tế tại khoa PTCS đã đáp ứng nhu cầu với số đông người bệnh, nhưng bên cạnh đó vẫn còn gần 5% người bệnh chưa hài lòng. Vì vậy, trong thời gian tới, đòi hỏi khoa PTCS tiếp tục cải tiến chất lượng điều

trị và chăm sóc, chú trọng đến những yếu tố người bệnh còn chưa hài lòng, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

4.3. Mối liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh

Bảng 3.12 hiển thị kết quả về *liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng chung của người bệnh,* ta thấy đánh giá mối liên quan sự hài lòng chung qua 12 tiểu mục hiển thị kết quả người bệnh ở nhóm tuổi <50 hài lòng hơn nhóm ≥50, hay người bệnh thuộc nhóm lao động đơn giản hài lòng gấp đôi so với nhóm viên chức, HSSV. Tỷ lệ nhóm người bệnh có thẻ BHYT hài lòng hơn nhóm còn lại tới 4,5 lần, điều này một lần nữa chứng tỏ chi phí KCB đóng vai trò rất quan trọng trong sự đánh giá hài lòng. Người bệnh được tiếp cận thông tin trực tiếp về khoa PTCS từ bạn bè người quen giới thiệu có tỷ lệ hài lòng cao gấp gần 3 lần so với nhóm tiếp cận thông tin gián tiếp qua các kênh thông tin đại chúng…Và đây cũng chính là mối liên quan có ý nghĩa thống kê (95% CI=1,3-7,64). Như vậy, việc cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa rất quan trọng. Người bệnh điều trị tại đây cảm nhận được sự quan tâm chu đáo từ các bác sỹ và điều dưỡng, kết quả phẫu thuật khả quan, khoa phòng khang trang sạch sẽ thì chính họ sẽ trở thành những "bạn bè, người quen" để khi về nhà họ sẽ giới thiệu hình ảnh tới những người khác thông qua những cảm nhận trực tiếp, được mắt thấy tai nghe mọi hoạt động của Khoa. Qua đó cho thấy cần thiết phải tăng cường hình thức quảng bá hiệu quả này, muốn vậy Khoa PTCS phải đẩy mạnh chất lượng phục vụ một cách toàn diện để "tiếng lành đồn xa" thông qua kênh truyền thông trên đây.

Thu nhập trung bình cũng là mối liên quan có ý nghĩa thống kê khi người bệnh có thu nhập ≥ 1.500.000 đ/tháng hài lòng cao hơn nhóm <1.500.000 tới 3,6 lần và 95% CI=1,3-7,3, điều này chứng tỏ thu nhập luôn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự hài lòng. Kết quả này tương đương với kết quả trong nghiên cứu của tác giả Trương Thị Bích Ngọc đánh giá về dịch vụ KCB tại một số khoa Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cũng chỉ ra rằng có mối liên quan về tỷ lệ hài lòng với yếu tố nghề nghiệp và thu nhập trung bình/tháng [30]. Tác giả nghiên cứu nhận thấy rằng người có sự chuẩn bị về tài chính tốt khi nằm viện tâm lý cũng thoải mái hơn, được chọn lựa những dịch vụ theo

nhu cầu của bản thân, do đó họ cũng dễ dàng hài lòng hơn. Như vậy, để tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh, khoa PTCS ngoài việc tiếp tục cải thiện nâng cao các dịch vụ cho người có thu nhập cao, bên cạnh đó, khoa cũng cần quan tâm hơn nữa đến những người thu nhập thấp, người nghèo thông qua chính sách BHYT, sử dụng thuốc và vật tư phù hợp, động viên chia sè ….để họ giảm chi phí tài chính cũng như hỗ trợ về tinh thần để họ yên tâm hơn khi nằm viện.

Về *Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế*, bảng 3.12 cho thấy kết quả, duy nhất chỉ có tình trạng hôn nhân là có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng của người bệnh về thời gian tiếp cận với các dịch vụ y tế của khoa PTCS. Kết quả này có sự khác biệt so với nghiên cứu của Lý Thị Thúy trong khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện Bạch Mai (2014), tác giả cho biết về yếu tố thời gian chờ đợi, có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê ở điểm trung bình hài lòng của những đối tượng nghiên cứu có địa chỉ khác nhau (p=0,003) và số lượng sử dụng dịch vụ khác nhau (p=0,005) [31]. Cụ thể, theo bảng 3.12, tỷ lệ hài lòng về thời gian tiếp cận dịch vụ ở người bệnh đã có gia đình cao gấp 4 lần so với nhóm người bệnh độc thân/ly thân/ly hôn (95% CI = 1,51-10,85). Ngoài ra, người bệnh nam hài lòng ít hơn, chỉ bằng 0,64 lần so với với nữ giới. Có thể do nam giới thường nóng tính và sự nhẫn nại kém hơn nữ nên họ dễ cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi khi được sử dụng các dịch vụ y tế. Sự hài lòng của người mới KCB lần đầu tại bệnh viện cũng thấp hơn đáng kể so với những người đã từng khám ở đây. Tuy nhiên, lại không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê về sự hài lòng về thời gian chờ đợi, tiếp cận dịch vụ y tế nêu trên với một số yếu tố nhân khẩu học như: Nhóm tuổi, giới, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hay đối tượng khám bệnh (Khám bệnh bằng thẻ BHYT hoặc không có thẻ BHYT) và một vài yếu tố khác nữa.

Qua những kết quả trên, lãnh đạo của khoa PTCS cần quan tâm hơn tới việc làm giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh ở các khâu: chờ mổ hay chờ nhân viên y tế, đặc biệt chú trọng hơn tới những người còn độc thân, hoặc đã ly dị, ly thân do đặc điểm văn hóa Việt những lúc ốm đau rất cần người thân bên cạnh nhưng do

hoàn cảnh nên họ ít nhận được sự chăm sóc của người thân nên việc được quan tâm, động viên chia sẻ với họ cũng giúp họ yên tâm hơn khi nhập viện, qua đó cũng làm tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh.

Với *sự hài lòng về chăm sóc của điều dưỡng và các mối liên quan*, bảng 3.13 cho thấy không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng về chăm sóc của điều dưỡng với nhóm tuổi, giới, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số lần KCB tại khoa/năm,… nhưng có thể thấy một số kết quả như sau: giống như với thời gian tiếp cận, người bệnh là nam giới hoặc mới lần đầu đến khám tại khoa cũng có sự hài lòng thấp hơn nữ hoặc những người đến khám từ 2 lần trở lên. Ngoài ra, người bệnh sử dụng dịch vụ mổ theo yêu cầu và giường yêu cầu hài lòng ít hơn những người không sử dụng. Khác với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế, sự hài lòng về sự chăm sóc của điều dưỡng không những có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng hôn nhân mà còn có thêm mối liên quan với thu nhập trung bình/tháng của người bệnh. Những người đã lập gia đình có tỷ lệ hài lòng cao hơn gấp gần 10 lần (95% CI=1,6-62,2) so với những đối tượng còn độc thân, ly thân, ly dị hoặc góa. Mặt khác, những người bệnh có thu nhập trên 1,5 triệu đồng tháng cũng có tỷ lệ hài lòng cao gấp gần 12 lần so với người có thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/tháng (95% CI=1,3-109,5). Lại một lần nữa chúng ta thấy được, thu nhập có ảnh hưởng rất nhiều đến sự hài lòng của các đối tượng. Sở dĩ những người có thu nhập cao hơn lại hài lòng hơn có thể là do họ có điều kiện để trang trải cho những dịch vụ tốt hơn nên họ cũng hài lòng hơn. Những người bệnh nằm giường yêu cầu do có điều kiện để chi trả dịch vụ nên họ đòi hỏi sự phục vụ, cơ sở vật chất tốt hơn. Điều này đặt ra với Ban lãnh đạo khoa cần chú trọng hơn đến công tác điều trị và chăm sóc ở những buồng này không chỉ làm đúng, làm đủ mà còn cần hiểu những tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu của người bệnh để đem đến cho họ dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó điều dưỡng khoa PTCS cũng dành sự quan tâm đến những người bệnh hoàn cảnh đơn chiếc, góa bụa ít nhận được sự chia sẻ của người thân, chỉ một câu hỏi han, an ủi của người cán bộ y tế cũng sưởi ấm tâm hồn họ.

Đối với *hài lòng của người bệnh về tư vấn giáo dục sức khỏe*, bảng 3.14 cho thấy, mối liên quan giữa sự hài lòng của người bệnh về tư vấn giáo dục sức khỏe của bệnh viện với 3 yếu tố là tình trạng hôn nhân, đối tượng khám bệnh và hình thức sử dụng dịch vụ có ý nghĩa thống kê. Cũng giống như với yếu tố thời gian tiếp cận với dịch vụ y tế và chăm sóc của điều dưỡng, sự hài lòng về giáo dục sức khỏe của người đã lập gia đình cao hơn so với đối tượng còn lại, tỷ lệ hài lòng gấp khoảng 3,2 lần. Ngoài ra, về đối tượng khám bệnh, có thể chia ra làm hai nhóm là có KCB bằng thẻ BHYT và nhóm không có thẻ. Và nhóm có BHYT có xu hướng dễ dàng hài lòng về tư vấn giáo dục sức khỏe của nhân viên y tế tại bệnh viện hơn, gấp 3,66 lần người không có BHYT. Điều này có thể là do những người có thẻ BHYT thường là những người chi phí ít tốn kém hơn do có BHYT chi trả, nên họ dễ dàng hài lòng với sự tư vấn của bác sỹ, hướng dẫn của điều dưỡng và một số tiểu mục khác trong yếu tố tư vấn giáo dục sức khỏe. Ngoài ra, người bệnh được chuyển tuyến có tỷ lệ hài lòng về yếu tố này cao hơn nhóm người bệnh tự đến khoảng hơn 2 lần vì người bệnh chuyển đúng tuyến được hưởng quyền lợi BHYT nhiều hơn. Thêm một lý do khác là tỷ lệ người bệnh không có thẻ BHYT thường là những người lao động tự do, nông dân nên cách tư vấn GDSK không chỉ gián tiếp bằng tờ rơi hay hướng dẫn truyền miệng mà có khi KTV phải trực tiếp dùng các hình thức làm mẫu hay tập tại chỗ nhiều lần cho người bệnh cảm nhận. Thảo luận nhóm với các điều dưỡng và bác sỹ đang công tác tại Khoa Phẫu thuật Cột sống để tìm lời giải về lý do tại sao khoảng 1/5 số người bệnh chưa hài lòng với tư vấn của bác sỹ về bệnh tật, họ cho biết *"Đặc tính vùng miền, độ tuổi và giới tính cũng ảnh hưởng tới cảm nhận về sự hài lòng trong cách được nghe bác sỹ tư vấn"* (TLN Bác sỹ điều trị, mã số 04) hay ý kiến khác *"Bản thân ở các người bệnh cũng có sự nhận thức khác nhau: Người bệnh có bệnh đặc biệt, hoàn cảnh gia đình của người bệnh, tri thức của người bệnh (nghe, hiểu), chi phí mổ, phương pháp mổ, phẫu thuật viên, phòng bệnh nằm điều trị, thời gian nằm viện"* (TLN bác sỹ điều trị- mã số 04). Kết hợp những kết quả nghiên cứu ta có thể thấy rằng: Sự hài lòng về tư vấn giáo dục sức khỏe của người bệnh dễ bị tác động và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nhân khẩu học khác nhau,

do đó Lãnh đạo Khoa cần tập huấn nâng cao khả năng tư vấn, hướng dẫn của cả bác sỹ và điều dưỡng cho người bệnh để họ thấy hài lòng hơn với yếu tố này.

Về *sự hài lòng của người bệnh về sinh hoạt của họ*, kết quả tại bảng 3.15 cho thấy, chỉ có sự hài lòng với số lần KCB tại Khoa/năm là có mối liên quan có ý nghĩa thống kê. Người bệnh đến KCB lần đầu có tỷ lệ hài lòng về sinh hoạt tại bệnh viện, cao gấp 3,86 lần người bệnh đến KCB hai lần trở lên. Nhưng ở tiểu mục đánh giá hài lòng về giấc ngủ tại bệnh viện, những người đã khám và điều trị lần thứ 2 trở lên do làm quen nhanh hơn với các điều kiện và khung cảnh bệnh viện, nên họ hài lòng cao hơn so với những người lần đầu tiên vào Khoa PTCS điều trị. Nghiên cứu của Lý Thị Thúy cho biết số lần đến khám điều trị cũng là một yếu tố nhân khẩu học làm ảnh hưởng đến sự hài lòng [31], nhưng lại khác so với nghiên cứu của chúng tôi ở điểm là tác giả này cho biết số lần đến KCB có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng về thời gian chờ đợi. Ngoài ra, kết quả thảo luận nhóm về câu hỏi: Tại sao có tới gần 30% số người bệnh chưa hài lòng về giấc ngủ tại bệnh viện đã cho thấy một số ý kiến khác. Một bác sỹ cho rằng, người bệnh bị rối loạn giấc ngủ có thể liên quan đến mức độ bệnh hay loại bệnh, hoặc có thể liên quan đến chỉ định điều trị của bác sỹ (không cho thuốc ngủ) hay yếu tố khác như ánh sáng, tiếng ồn. Nhìn chung, việc đảm bảo sinh hoạt bình thường cho người bệnh cần được lãnh đạo bệnh viện, các bác sỹ và nhân viên y tế quan tâm thêm đặc biệt là với người bệnh lần đầu đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Bảng 3.16 cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa *sự hài lòng của người bệnh về hiệu quả và chi phí khám bệnh* với các yếu tố: Số lần KCB tại khoa/năm, đối tượng khám bệnh và hình thức sử dụng dịch vụ. Người bệnh đến KCB lần đầu tại khoa có tỷ lệ hài lòng về hiệu quả và chi phí KCB cao gấp hơn 2 lần người đến khám ≥ 2 lần. Nguyên nhân ở đây là có thể do tâm lý con người khi có bệnh chỉ muốn chữa một lần cho khỏi, vậy nên nếu phải tiếp tục nhập viện, mặc dù là vào viện đề phẫu thuật tại vị trí khác hay để điều trị biến chứng của lần nhập viện trước, cũng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cảm nhận và suy nghĩ của người bệnh. Thêm vào đó người bệnh nhập viện lần hai chịu thêm gánh nặng về tài chính nên họ kỹ tính hơn trong việc đánh giá hài lòng. Về đối tượng khám bệnh, người

bệnh có BHYT hài lòng với yếu tố này cao gấp 2,3 lần người bệnh không có BHYT. Có thể do người bệnh có thẻ BHYT khi chữa bệnh sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi mà luật bảo hiểm quy định. Đồng thời, tại khoa PTCS, quy định về hướng dẫn người bệnh trình thẻ BHYT được thực hiện thường quy nên điều đó sẽ giúp cho người bệnh đến khám và điều trị có sử dụng thẻ BHYT tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Ngoài ra, với hình thức sử dụng dịch vụ, người bệnh được chuyển tuyến hài lòng gấp gần 2 lần so với người tự đến khám về chất lượng điều trị và chi phí khám bệnh tại bệnh viện, vì khi người bệnh có thẻ BHYT chuyển đúng tuyến sẽ nhận được hỗ trợ chi trả từ phía Cơ quan Bảo hiểm cao hơn. Nghiên cứu của Lý Thị Thúy tại Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Bạch Mai lại có sự khác biệt với kết quả mà chúng tôi thu được, tác giả này cho biết: Mức độ hài lòng về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Khoa Khám bệnh cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo nhóm địa chỉ giữa Hà Nội, các thành phố khác và khu vực nông thôn miền núi (p=0,025) [31] hay tác giả Phạm Nhật Yên cũng chỉ ra: người bệnh cư trú ở các tỉnh có tỷ lệ hài lòng với chất lượng, hiệu quả và chi phí phục vụ cao gấp 3,7 lần so với những người bệnh tại Hà Nội (p=0,01) [38]. Như vậy, chi phí khám chữa bệnh của người bệnh là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến sự hài lòng và BHYT đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua kết quả nghiên cứu trên đây là cần giảm tỷ lệ người bệnh không BHYT và tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, điều này cũng phù hợp với chính sách BHYT toàn dân của Chính phủ đang phê duyệt[1].

Các yếu tố khác trong nghiên cứu này chúng tôi thấy giá trị OR không có ý nghĩa thống kê, có thể những yếu tố này đòi hỏi nghiên cứu có cỡ mẫu lớn hơn để tìm hiểu khai thác các đặc tính. Để tiếp tục đi sâu nghiên cứu các yếu tố này các nhà nghiên cứu cần triển khai các đề tài tiếp theo.

Như vậy, nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động KCB cũng như làm hài lòng người bệnh đã lựa chọn và tin tưởng đến bệnh viện để phẫu thuật và điều trị, lãnh đạo khoa PTCS, cũng như lãnh đạo bệnh viện cần quan tâm đến tìm hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người bệnh, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm và những vấn đề còn tồn tại ở khoa làm người bệnh chưa hài lòng

[1] Dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế, Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội

để hoàn thiện thêm chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

4.4. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu

4.4.1. Ưu điểm của nghiên cứu

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh với bệnh viện là một vấn đề khá nhạy cảm. Bởi vây, nghiên cứu sử dụng phương pháp phát vấn mà không phải là phỏng vấn trực tiếp, do đó có thể giúp đánh giá chính xác và khách quan nhất về nhận xét, đánh giá cũng như cảm nhận của người bệnh đối với chất lượng KCB tại cơ sở nghiên cứu.

Đề tài xác định khá đầy đủ các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Kết quả của đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao trong việc cải thiện công tác điều trị và chăm sóc cho người bệnh tại Khoa Phẫu thuật Cột sống.

Cỡ mẫu nghiên cứu đủ lớn và đủ đại diện cho quần thể.

Số liệu trong nghiên cứu đảm bảo tính trung thực, khách quan.

Nghiên cứu cũng góp phần cho việc thực hiện cam kết của Bệnh viện với Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

4.4.2. Một số hạn chế của nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện tại Khoa Phẫu thuật Cột sống nên không có tính đại diện cho cả Bệnh viện Việt Đức mà chỉ có thể khái quát bức tranh về sự hài lòng của riêng khoa PTCS. Do đó yêu cầu là cần có nghiên cứu đánh giá sự hài lòng quy mô hơn trên toàn Bệnh viện Việt Đức.

Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi được xây dựng sẵn, thu thập bằng hình thức phát vấn để người bệnh tự trả lời, tự điền thông tin nên khó khăn trong kiểm soát câu hỏi và có thể gặp sai số do kỹ năng phát vấn của điều tra viên cũng như thái độ hợp tác của đối tượng nghiên cứu.

Do thời gian nghiên cứu ngắn nên mới chỉ tiến hành được tổng quan các yếu tố về sự hài lòng của người bệnh và việc đi vào chiều sâu của từng yếu tố cần có những nghiên cứu khác tiếp theo.

KẾT LUẬN

1. Sự hài lòng của người bệnh tại Khoa Phẫu thuật Cột sống-Viện Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Việt Đức.

- Sự hài lòng chung của người bệnh với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Khoa PTCS, Viện chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức ở mức khá cao 95,1%. Người bệnh có tỷ lệ hài lòng cao với một số yếu tố như: Hài lòng với điều trị của bác sỹ, sự chăm sóc của điều dưỡng, môi trường bệnh viện. Các nhóm người bệnh có tỷ lệ hài lòng cao như: Người bệnh nữ, người bệnh có gia đình, có sử dụng thẻ BHYT và chuyển khám điều trị đúng tuyến, người bệnh biết thông tin về khoa PTCS thông qua bạn bè hay người quen giới thiệu, người bệnh nhập viện lần đầu.

- Một số tiểu mục nhận được tỷ lệ hài lòng cao của người bệnh, từ 90% trở lên như: Sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân trong khi nằm viện (96,7%), thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ (96,1%), khám và chẩn đoán bệnh của bác sỹ (97,6%), việc thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của BS (96,9%), trang thiết bị y tế của khoa phòng (95,6%), sự sạch sẽ của khuôn viên trong bệnh viện (95,2%), giải thích và công khai thuốc trước khi sử dụng của điều dưỡng (94,1%) hay quy trình chuẩn bị mổ của ĐD (94,5%)…

- Tuy nhiên, còn mốt số tiểu mục chỉ có tỷ lệ hài lòng của người bệnh dưới 80% như: Thời gian chờ mổ (77,6%), thời gian chờ nhập viện (77,6%), sự tư vấn của bác sỹ về bệnh tật (79,2%), hài lòng với khu nhà vệ sinh buồng bệnh (77%), tổng chi phí của đợt điều trị này so với kết quả đạt được sau phẫu thuật (77,9%), hài lòng với sự hướng dẫn của ĐD về chế độ dinh dưỡng, tập luyện sau khi ra viện (75,5%), hài lòng với năng lực làm việc hiện tại (74,7%), chỉ 70,6% hài lòng với giấc ngủ hiện tại. Người bệnh ít hài lòng nhất với khả năng tình dục của mình, chỉ hơn 1/2 số người bệnh hài lòng (54,3%).

2. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh.

Sự hài lòng chung có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với 3 yếu tố, đó là: nghề nghiệp, thu nhập trung bình/tháng và cách tiếp cận thông tin.

Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng về thời gian tiếp cận dịch vụ ở người bệnh với tình trạng hôn nhân. Người bệnh đã có gia đình hài lòng cao gấp 4 lần so với nhóm người bệnh độc thân/ly thân/ly hôn (OR=4,05).

Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng của người bệnh về chăm sóc của ĐD với tình trạng hôn nhân và thu nhập trung bình/ tháng. Trong đó, người có gia đình hài lòng gấp gần 10 lần những người bệnh độc thân/ly hôn/khác. Và người bệnh có thu nhập ≥ 1,5 triệu/tháng hài lòng cao hơn nhóm có thu nhập <1,5 triệu/tháng gần 12 lần.

Về yếu tố tư vấn GDSK, sự hài lòng của người bệnh đã có gia đình hoặc có BHYT lần lượt đều gấp khoảng hơn 3 lần so với nhóm người bệnh còn độc thân hoặc chưa có BHYT. Ngoài ra, người bệnh được chuyển tuyến có tỷ lệ hài lòng về sự tư vấn giáo dục sức khỏe cao hơn nhóm người bệnh tự đến khoảng hơn 2 lần.

Người bệnh đến KCB lần đầu có sự hài lòng về sinh hoạt tại bệnh viện, cao gấp 3,86 lần người bệnh đến KCB lần lần 1 (OR=3,86 và 95% CI= 1,11-13,4).

Sự hài lòng về chi phí khám bệnh có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với số lần KCB tại Khoa/năm (OR=2,26 và 95% CI=1,23-4,15), BHYT (OR=2,34 và 95% CI=1,37-3,99) và hình thức sử dụng dịch vụ (OR=1,9 và 95% CI=1,2-3,02)

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Khoa Phẫu thuật Cột sống, Viện chân thương chỉnh hình-Bệnh viện Việt Đức.

- Thực hiện chặt chẽ quy định giải thích cho người bệnh: bác sỹ tư vấn cho người bệnh và trước khi phẫu thuật, về các phương pháp phẫu thuật và chi phí để phù hợp với từng người bệnh. Điều dưỡng giải thích, công khai cho người bệnh trước khi làm thủ thuật, sử dụng thuốc và vật tư tiêu hao…

- Xem xét và cải cách các thủ tục hành chính để làm giảm thời gian chờ đợi nhập viện. Giải thích, quan tâm đến những người bệnh mổ sau theo thứ tự lịch mổ.

–Quan tâm đến phác đồ điều trị về cải thiện chất lượng cuộc sống: xây dựng quy trình kiểm soát đau, giấc ngủ của người bệnh tại viện, kết hợp với Khoa Nam học để tư vấn và điều trị cho những người bệnh kém hài lòng với khả năng tình dục sau phẫu thuật.

–Thành lập và phát triển hệ thống tư vấn thông tin cho người bệnh: lập ban tư vấn trực tiếp tại viện cùng các kênh truyền thông gián tiếp như là: internet, tài liệu phát tay...

–Dán thông báo lưu ý mọi người vào khoa cùng có ý thức đảm bảo trật tự, qua đó tránh làm phiền tới sự nghỉ ngơi của người bệnh.

Đối với Bệnh viện Việt Đức

–Kiến nghị với cơ quan bảo hiểm đảm bảo hơn quyền lợi cho người bệnh có BHYT khi sử dụng vật tư kỹ thuật cao.

Đối với các nhà nghiên cứu

–Tiếp tục tiến hành nghiên cứu sâu tìm nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến sự không hài lòng của người bệnh, như: hài lòng về giấc ngủ, cải thiện chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật bệnh lý cột sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Pascoe GC. (1983), Patient satisfaction in primary health care: A literature review and analysis, *Eval Program Plann* 6, 185-210.
2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái (2013), Báo cáo tổng kết công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014, chủ biên.
3. Nguyễn Bá Anh (2012), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại 1 số khoa lâm sàng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012*, Luận văn quản lý bệnh viện, Trường Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
4. Bộ Y tế (2015), *Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh*, số 2151/QĐ-BYT ngày 04-06-2015.
5. Bộ Y tế (2009), *Tổ chức và quản lý y tế ở Việt Nam*, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội, Hà Nội.
6. Fellani Danasra Dewi, Grita Sudjana và Yevis Marty Oesman (2011), Patient satisfaction analysis on service quality of dental health care based on empathy and responsiveness, *Den Res Journal*, 8(4), 172-177.
7. Hall J.A và Dornan M.C (1988), What patients like about their medical care and how often they are asked: a meta-analysis of the satisfaction literature., 935.
8. Bùi Nguyên Hùng và Võ Khánh Toàn (2005), *Chất lượng dịch vụ lắp đặt đồng hồ nước tại TP. HCM và một số giải pháp*, Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Công Khanh (2004), *Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội - Quy trình, kỹ thuật thiết kế, thích nghi, chuyển hóa công cụ đo*, NXB Chính trị Quốc gia.
10. Lings I.N and Brooks R.F (1998), Implementing and measuring the effectiveness of internal marketing, *Jounal of Marketing Management*, 14, 325-51.
11. Wiley A.L (2006), *Customer satisfaction measurement*, Intercom, May, 41-42.
12. Lê Thị Kim Ngân và Lê Thị Thu Trang (2014), Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện đa khoa Cần thơ, *Tạp chí khoa học*, 31, 8-16.
13. Donabedian A. (1980), The definition of quality and approaches to its assessment, *Social Science Medicine*, 45(12), 1829-1843.
14. Trần Thu Thủy (2001), *Công tác quản lý chuyên môn bệnh viện*, Quản lý bệnh viện, Nhà xuất bản y học, Hà Nội, 101-114.
15. Brown S.W. and Bond E.U. (1995), The internal/external framework and service quality: Toward theory in Service marketing, *Journal of Marketing Management, February*, 25-39.
16. Colin Grant (1973), *Hospital Management*, Churchill Livingstone, London.
17. Curry A (1999), Innovation in public service management, *Managing Service Quality*, 9(3), 180-190.
18. Dotchin J.A. và Oakland J.S. (1994), Total quality management in service: Part 2 Service quality, *International Journal of Quality & Reliability Management*, 11(3), 27-42.

19. Ware J.E., Davies-Avery J.A. và Stewart A.L. (2002), The Measurement and Meaning of Patient Satisfaction: A review of the literature, The Rand Corporation – Santa Monica, California, 27-42.
20. Parasuraman A, Zeithml V.A. và L.L. Berry (1985), A conceptual model of service quality and its implication, *Journal of Marketing* 49(Fall), 41-50.
21. Parasuraman A., Zeithml V.A và L.L Berry (1986), SERVQUAL: a multi-item scale for measuring customer perceptions of service quality, *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
22. Đặng Hồng Anh (2013), *Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ thành phố Đà Nẵng*, Đại Học Đà Nẵng.
23. Linda Powell (2001), Patient Satisfaction Surveys for Critical Access Hospitals, *Mountain States Group, Inc*.
24. Al-Doghaither AH (2004), *Inpatient satisfaction with physician services at King Khalid University Hospital, Riyadh, Saudi Arabia.*, truy cập ngày 01-10-2015, tại trang web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16212213.
25. Penchan S Monaiyapong (2002), *Need of care and customer satisfaction from erldercare workers in metropolitan BangKok*, The degree of Master of Nursing science, Mahidol University, ThaiLand.
26. Santhat Sermsri và Jiraporn Chompikul (2007), *Patient satisfaction towards health services at the out-patient department clinic of Wangnumyen community hosptal, Sakaeo province, ThaiLand*, The degree of master of primary health care management, Mahidol University, ThaiLand.

27. Asma Hasan (2007), *Patient satisfaction with maternal and child health services among mothers attending the maternal and child health training institute in Dhaka, Bangladesh*, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, ThaiLand.
28. Phan Văn Tường (2002), *Xây dựng mô hình công tư phối hợp trong hệ thống bệnh viện*.
29. Nguyễn Đức Thành và cộng sự (2006), *Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện tỉnh Hòa bình*, Trường Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
30. Trương Thị Bích Ngọc (2011), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại một số khoa của bệnh viện đa khoa Đồng tháp năm 2011*, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
31. Lý Thị Thúy (2014), *Sự hài lòng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với các dịch vụ y tế tại khoa khám bệnh-Bệnh viện Bạch Mai năm 2014 và một số yếu tố ảnh hưởng*, Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
32. Trần Thị Hà Giang (2011), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2011*, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
33. Trịnh Thị Thúy Hằng (2014), *Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám bệnh tại khoa khám bệnh theo yêu cầu bệnh viện Phụ Sản trung ương năm 2014*, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
34. Trần Thị Cẩm Tú, Bùi Đức Phú, Trần Thị Xuân Hương và các cộng sự. (2012), Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Trung ương Huế năm 2012, *Y học thực hành*, 903.

35. Nguyễn Văn Phi và cộng sự (2015), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại phòng khám Đa khoa Cầu Diễn thuộc trung tâm y tế quận Từ Liêm thành phố Hà Nội, *Tạp chí y học dự phòng*, 4(164).
36. Đinh Ngọc Thành và cộng sự (2014), Giao tiếp của điều dưỡng và sự hài lòng của người bệnh nội trú tại các khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, *Tạp chí khoa học & công nghệ*, 115(1), 143-148.
37. Nguyễn Ngọc Lý (2013), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về công tác chăm sóc điều dưỡng tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2013*, Luận văn y tế công cộng, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
38. Phạm Nhật Yên (2008), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện Bạch mai năm 2008*, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
39. Nguyễn Thị Hoàng Vân, Nguyễn Thị Ngọc Hân và Bùi Hữu Minh Trí (2012), Thời gian chờ đợi khám bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân tại khoa khám bệnh BVTM An Giang 4-5/2012.
40. Nguyễn Công Thịnh (2010), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám Nội-Nhi của khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2010*, Luận văn y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
41. Phạm Hữu Trung (2011), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh lao phổi AFB(+) điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2011*, Luận văn y tế công cộng, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
42. Nguyễn Thế Vinh (2012), *Thực trạng công tác khám chữa bệnh ngoại trú và sự hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2012*, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.

43. Nguyễn Văn Đông (2012), *Đánh giá thực trạng cung cấp, sử dụng và sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ khám chữa bệnh nội trú bằng y học cổ truyền tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa năm 2012*, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
44. Phạm Trí Dũng (2011), *Marketing Bệnh viện*, Nhà xuất bản y học.
45. WHO - Western Pacific Region (2011), Country health information profiles: Revision 2011, chủ biên, WHO Library Cartaloguing in Publication Data.
46. Parasuraman A. và L.L. Zeithml V.A. and Berry (1993), Research note: more on improving service quality measurement, *Journal of Retailing*, 69(1), 140 - 147.
47. Ranajit Chakraborty et Anirban Majumdar (2011), Measuring Consumer Satisfaction in Health Care – Sector: The applicability of servqual, *International Refereed Research Journal*, Vol. II (Issue – 4).
48. Syed Saad Andaleeb (2001), Service quality perception and patient satisfaction: a study of hospital in a developing country, *Social Science Medicine*, (52), 1359-1370.
49. Harkey J và Vraciu R. (1992), *Quality of health care and financial performance: is there a link?*, Health Care Manage Review
50. Nelson KM, Helfrich C, Sun H và các cộng sự. (2014 Aug), *Implementation of the patient-centered medical home in the Veterans Health Administration: associations with patient satisfaction, quality of care, staff burnout, and hospital and emergency department use.*, truy cập ngày 10-10, tại trang web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25055197.

51. Tengilimoglu, D Kisa và A. and Dziegielewski (2001)), Measurement of patient satisfaction in a public Hospital in Ankara, *Health Service Management Research,*, 14, 27 – 35.
52. Ke-Ping A. Yang, PhD, RN và các cộng sự. (1999), Factors Influencing Nursing-Sensitive Outcomes in Taiwanese Nursing Homes, *Online Journal of Issues in Nursing*, 4(2).
53. Nguyễn Khánh Chi (2011), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Thành phố Hà Nội năm 2011*, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
54. Bùi Thị Dương Vân (2011), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh với hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung Ương năm 2011*, Luận văn quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
55. Bùi Thị Thu Hương (2009), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Duy Tiên, tỉnh Bắc Ninh, năm 2009*, Luân văn y tế công cộng, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
56. Bộ Y tế (2013), Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện, chủ biên, Hà Nội.
57. Trương Quan Trung (2011), *Nghiên cứu sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế đối với chất lượng phục vụ tại Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Đại học Y Hà Nội*, Trường Đại học Y Hà Nội.
58. Ngô Thị Ngoãn (2002), Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh tại các Khoa Khám bệnh của 5 Bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh, *Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Toàn quốc lần thứ Nhất*, 20-22.
59. Hà Thị Soạn (2007), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh & người nhà người bệnh đối với công tác khám chữa bệnh tại một số bệnh viện tỉnh Phú Thọ năm năm 2006 - 2007, *Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ III*.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1:

PHIẾU ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH SAU MỔ BỆNH LÝ CỘT SỐNG

(Đánh giá kể từ khi nhập viện và phỏng vấn sau khi người bệnh thanh toán ra viện)

Phần 1.GIỚI THIỆU

Với tiêu chí nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc, chúng tôi trân trọng kính mời ông, bà tham gia phỏng vấn nghiên cứu ***"Sự hài lòng của người bệnh phẫu thuật bệnh lý cột sống tại Khoa Phẫu thuật Cột sống - Bệnh viện Việt Đức".*** *Sự hợp tác của ông/ bà là hoàn toàn tự nguyện và không bị chi phối bởi bất kỳ áp lực nào, ông/ bà có thể dừng cuộc phỏng vấn khi không thoải mái.Mọi thông tin mà ông/ bà cung cấp đều được giữ bí mật tuyệt đối và chỉ được sử dụng cho nghiên cứu (Đối với người bệnh dưới 18 tuổi hoặc người bệnh trong tình trạng hôn mê, mất khả năng trả lời thì người thân đi cùng sẽ trả lời thay thế).*

Phần 2. THÔNG TIN CÁ NHÂN (khoanh tròn vào phần ông/bà lựa chọn trả lời)

1. **Tuổi (tính theo tuổi dương lịch):**……. Tuổi
2. **Giới tính:**

1. Nam 2. Nữ

3. **Dân tộc**

1. Kinh 2. Khác

4. **Trình độ học vấn:**

1. Không biết chữ
2. Tiểu học - cấp I
3. Trung học cơ sở - cấp II
4. Trung học phổ thông – cấp III
5. Trung cấp
6. Cao đẳng và đại học
7. Sau đại học

5. Nghề nghiệp chính trong 12 tháng qua:

1. Cán bộ hưu trí
2. Công chức nhà nước
3. Nông dân
4. Công nhân
5. Lao động tự do
6. Học sinh, sinh viên
7. Khác

6. Tình trạng hôn nhân:

1. Độc thân
2. Có gia đình
3. Ly thân
4. Ly hôn
5. Góa

7. Trong vòng 12 tháng qua, gia đình ông/ bà có bao nhiêu người?

.....người

8. Thu nhập bình quân/người/tháng của gia đình ông/ bà trong 12 tháng qua là bao nhiêu?

1. Không biết, không nhớ
2. Có biết: …….đồng

9. Ông/bà có sử dụng thẻ BHYT khi điều trị đợt này không?

1. Có
2. Không

10. Trong 12 tháng qua, đây là lần thứ mấy ông bà đến điều trị tại khoa PTCS?

1. Không nhớ/không trả lời
2. Có nhớ: ……..lần

11. Ông/bà đến điều trị tại khoa PTCS lần này theo hình thức:

1. Tự đến
2. Chuyển tuyến

12. Ông/bà biết đến khoa PT Cột sống qua:

1. Phương tiện thông tin đại chúng, Mạng internet
2. Bạn bè người quen giới thiệu

13. Ông/bà sử dụng dịch vụ nào khi điều trị tại khoa PTCS

1. Mổ theo yêu cầu
2. Giường theo yêu cầu

Phần 3. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Để đo sự hài lòng đối với chất lượng phục vụ của khoa PT Cột sống – BV Việt Đức, chúng tôi sử dụng thang đo Likert với các mức độ từ:

Rất không hài lòng: Mức 1

Không hài lòng : Mức 2

Bình thường : Mức 3

Hài lòng : Mức 4

Rất hài lòng : Mức 5

Xin Ông/Bà chọn mức độ hài lòng đúng nhất với cảm nhận với các yếu tố dưới đây và khoanh tròn vào mức độ mà ông/bà lựa chọn:

Mã câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Trả lời				
A	**<u>THỜI GIAN CHỜ TIẾP CẬN DỊCH VỤ</u>**					
A1	**Thời gian Ông/Bà chờ đợi làm thủ tục nhập viện tại văn phòng khoa:** Thời gian Ông/Bà chờ đợi là bao lâu? Xin ghi rõ .....giờ.....phút					
A1.1	Ông/Bà hài lòng ở mức nào cho thời gian trên?	1	2	3	4	5
A2	**Thời gian Ông/Bà chờ đợi để được đưa lên phòng mổ (tính từ 7h00 sáng ngày mổ)** Thời gian Ông/Bà chờ đợi là bao lâu? Xin ghi rõ: .....giờ.....phút					
A2.1	Ông/ bà hài lòng ở mức nào cho thời gian trên?	1	2	3	4	5
A3	**Thời gian Ông/Bà chờ đợi sự có mặt của ĐD khi người bệnh cần:** Thời gian Ông/Bà chờ đợi là bao lâu? Xin ghi rõ: .....giờ.....phút					
A3.1	Ông/ bà hài lòng ở mức nào cho thời gian trên?	1	2	3	4	5

A4	**Thời gian Ông/Bà chờ đợi NVYT hỗ trợ vệ sinh cá nhân trong giờ làm chuyên môn:** Thời gian Ông/Bà chờ đợi là bao lâu? Xin ghi rõ: .....giờ.....phút					
A4.1	Ông/ bà hài lòng ở mức nào cho thời gian trên?	1	2	3	4	5
B	**<u>TIẾP CẬN VỚI CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG</u>**					
B.1	Ông/bà hài lòng ở mức độ nào về thái độ phục vụ thân thiện và tôn trọng người bệnh của điều dưỡng?	1	2	3	4	5
B.2	Ông/bà hài lòng ở mức nào với sự cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện thao tác chăm sóc tiêm, thăy băng, lấy máu xét nghiệm hay làm các thủ thuật khác của ĐD?	1	2	3	4	5
B.3	Ông/bà hài lòng ở mức nào với việc công khai thuốc trước khi sử dụng cho người bệnh của ĐD?	1	2	3	4	5
B.4	Ông/bà hài lòng ở mức nào về việc chuẩn bị trước mổ của ĐD (vệ sinh, thụt tháo, dặn dò NB)?	1	2	3	4	5
B.5	Ông/bà hài lòng ở mức nào về giao tiếp của ĐD với người bệnh và thân nhân?	1	2	3	4	5
B.6	Ông/bà hài lòng ở mức nào với việc giải thích cho người bệnh trước khi làm thủ thuật chăm sóc của ĐD?	1	2	3	4	5
B.7	Ông/bà hài lòng ở mức nào với việc hướng dẫn và tập phục hồi chức năng tại giường của kỹ thuật viên?	1	2	3	4	5
B.8	Ông/bà hài lòng ở mức nào với sự lắng nghe của ĐD khi nghe người bệnh trình bày?	1	2	3	4	5

C	**<u>TIẾP CẬN VỚI ĐIỀU TRỊ CỦA BÁC SỸ</u>**					
C.1	Ông/bà hài lòng ở mức nào với thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ?	1	2	3	4	5
C.2	Ông/bà hài lòng ở mức nào sau khi được bác sỹ khám và chẩn đoán bệnh?	1	2	3	4	5
C3	Ông/bà hài lòng ở mức nào với sự lắng nghe của bác sỹ khi nghe người bệnh trình bày về bệnh tật	1	2	3	4	5
C.4	Ông/bà hài lòng ở mức nào với những thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của BS?	1	2	3	4	5
C.5	Ông/bà hài lòng ở mức nào với hiệu quả giảm đau sau mổ với thuốc giảm đau mà BS kê đơn?	1	2	3	4	5
C.6	Ông/bà hài lòng ở mức nào với việc thăm khám bệnh hàng ngày của BS?	1	2	3	4	5
D	**<u>TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE</u>**					
D.1	Ông/bà hài lòng ở mức nào với việc BS tư vấn về bệnh tật và cách phòng bệnh?	1	2	3	4	5
D.2	Ông/bà hài lòng ở mức nào với việc ĐD hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, tập PHCN, tư vấn giáo dục sức khỏe?	1	2	3	4	5
D.4	Ông/bà hài lòng ở mức nào với tài liệu phổ biến nội quy của khoa mà ông bà đã được nhận?	1	2	3	4	5
E	**<u>SINH HOẠT CỦA NGƯỜI BỆNH</u>**					
E.1	Ông/bà hài lòng ở mức nào với giấc ngủ tại bệnh viện?	1	2	3	4	5
E.2	Ông/bà hài lòng ở mức nào với sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân trong quá trình nằm viện?	1	2	3	4	5

E.3	Ông/bà hài lòng ở mức nào về sự tự tin khả năng làm việc của mình sẽ đạt được sau phẫu thuật?	1	2	3	4	5
E.4	Ông/bà hài lòng ở mức nào về sự tự tin khả năng tình dục của mình sẽ đạt được sau phẫu thuật?	1	2	3	4	5
G	**CƠ SỞ VẬT CHẤT**					
G.1	Ông/bà hài lòng ở mức nào với cảnh quan của khoa PT Cột sống?	1	2	3	4	5
G.2	Ông/bà hài lòng ở mức nào với phương tiện trang thiết bị y tế của khoa phòng	1	2	3	4	5
G.3	Ông/bà hài lòng ở mức nào với ánh sáng của khoa phòng?	1	2	3	4	5
G.4	Ông/bà hài lòng ở mức nào với vệ sinh buồng bệnh nơi ông/bà nằm điều trị?	1	2	3	4	5
G.5	Ông/bà hài lòng ở mức nào với chất lượng đồ vải tại bệnh viện (bao gồm quần áo, ga, gối)	1	2	3	4	5
G.6	Ông/bà hài lòng ở mức nào với tiện nghi sinh hoạt (đèn, quạt, máy điều hòa, giường, đệm …)?	1	2	3	4	5
G.7	Ông/bà hài lòng ở mức nào với diện tích của buông bệnh.	1	2	3	4	5
G.8	Ông/bà hài lòng ở mức nào về sự sạch sẽ trong khu vệ sinh của người bệnh?	1	2	3	4	5
H	**MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN**					
H.1	Ông/bà hài lòng ở mức nào về an ninh trong bệnh viện	1	2	3	4	5
H.2	Ông/bà hài lòng ở mức nào về sự sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện?	1	2	3	4	5
H.3	Ông/bà hài lòng ở mức nào về cây xanh trong bệnh viện?	1	2	3	4	5

H.4	Ông/bà hài lòng ở mức nào về sự yên tĩnh trong bệnh viện.	1	2	3	4	5
I	**HIỆU QUẢ VÀ CHI PHÍ KCB**					
I.1	Ông bà chi phí hết bao nhiêu cho đợt điều trị này	Ông/bà cho biết số tiền:.				
I.2	Ông/bà hài lòng ở mức nào về tổng chi phí của đợt điều trị này so với kết quả ông/bà đạt được sau PT?	1	2	3	4	5

Theo ông/ bà hiện nay tại khoa PTCS còn vấn đề nào nổi cộm nhất cần giải quyết sớm trong thời gian tới:

1….....

2.....

3.....

Xin ông (bà) đề xuất ý kiến để

……

……...……..

Nhìn chung qua đợt điều trị này tại khoa PT Cột sống, ông/bà hài lòng ở mức nào?

Mức hài lòng (HL)	Rất không HL	Không HL	Bình thường	Hài lòng	Rất hài lòng
	1	2	3	4	5

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIÁM SÁT VIÊN **ĐIỀU TRA VIÊN**

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM VỀ DỊCH VỤ Y TẾ TẠI KHOA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG – BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

I. PHẦN GIỚI THIỆU

Với mục đích nhằm tăng cường sự hài lòng của người bệnh tại Khoa Phẫu thuật Cột sống – Bệnh viện Việt đức chúng tôi xin ý kiến của ông (bà) về các vấn đề có liên quan đến dịch vụ y tế tại khoa. Những ý kiến của ông (bà) sẽ được tôn trọng quyền riêng tư và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và qua đó sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng điều trị của Khoa Phẫu thuật Cột sống – Bệnh viện Việt đức.

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

1. Mục đích:

Tìm hiểu về tổ chức, nhân lực của Khoa Phẫu thuật Cột sống; Vấn đề giá cả dịch vụ, hiệu quả hoạt động của khoa trong 2 năm gần đầy; những khó khăn, tồn tại, chia sẻ những phương hướng hoạt động của khoa trong thời gian tới.

Thảo luận về những vấn đề mà người bệnh chưa thật sự hài lòng về dịch vụ y tế và các giải pháp nhằm cải thiện những nội dung trên.

2. Đối tượng:

- 05 Bác sỹ điều trị
- 05 Điều dưỡng - KTV khoa PTCS có kinh nghiệm > 5 năm

3. Phương tiện:

- Máy ghi âm.
- Biên bản ghi chép.

4. Nội dung:

4.1 Cơ sở vật chất, nhân lực của khoa.

4.2 Những vấn đề người bệnh chưa hài lòng liên quan đến những bất cập tại khoa.

4.3 Những yếu tố làm ảnh hưởng đến sự hài lòng người bệnh.

4.4 Những kiến nghị và đề xuất

Xin chân thành cảm ơn ông(bà) đã tham gia phỏng vấn

HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU VỀ DỊCH VỤ Y TẾ TẠI KHOA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG – BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

I. PHẦN GIỚI THIỆU

Với mục đích nhằm tăng cường sự hài lòng của người bệnh tại Khoa Phẫu thuật Cột sống – Bệnh viện Việt đức chúng tôi xin ý kiến của ông (bà) về các vấn đề có liên quan đến dịch vụ y tế tại khoa. Những ý kiến của ông (bà) sẽ được tôn trọng quyền riêng tư và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và qua đó sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng điều trị của Khoa Phẫu thuật Cột sống – Bệnh viện Việt đức.

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

1. Mục đích:

Tìm hiểu về tổ chức, nhân lực của Khoa Phẫu thuật Cột sống; Vấn đề giá cả dịch vụ, hiệu quả hoạt động của khoa trong 2 năm gần đầy; những khó khăn, tồn tại, chia sẻ những phương hướng hoạt động của khoa trong thời gian tới.

Thảo luận về những vấn đề mà người bệnh chưa thật sự hài lòng về dịch vụ y tế và các giải pháp nhằm cải thiện những nội dung trên.

2. Đối tượng:

- 01 Bác sỹ lãnh đạo Viện CTCH
- 01 Bác sỹ lãnh đạo Khoa Phẫu thuật Cột sống

3. Phương tiện:

- Máy ghi âm.
- Biên bản ghi chép.

4. Nội dung:

4.1 Tổ chức nhân lực

4.2 Cơ sở vật chất

4.3 Hiệu quả hoạt động

4.4 Những vấn đề người bệnh chưa hài lòng liên quan đến những bất cập tại khoa, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng.

4.5 Những giải pháp phát triển Khoa.

Xin chân thành cảm ơn ông (bà) đã tham gia phỏng vấn

Bảng trống thu thập số liệu từ sổ sách, báo cáo sẵn có

Thông tin thu thập	Tháng 10/2014	Tháng 09/2015
Bác Sỹ		
Điều dưỡng, KTV, NV khác		
Trợ giúp chăm sóc		
Trang thiết bị y tế		
Trang thiết bị sinh hoạt		
Số buồng bệnh		
GB kế hoạch/thực kê		
Số giường theo yêu cầu		
Số cáng		
Số nhà vệ sinh		
Số NB khám chuyên khoa		
Số ca phẫu thuật/NB		
Số ca bệnh lý CS		

PHỤ LỤC 2:

Biến số, chỉ số nghiên cứu

Bảng 2.3: Các biến số và chỉ số chung:

TT	Biến số/ chỉ số	Định nghĩa/Cách tính	Phương pháp thu thập
1	Tuổi	Số năm kể từ khi sinh ra tính đến thời điểm nghiên cứu	Phát vấn
2	Giới	Giới tính khi sinh	Phát vấn
3	Dân tộc	Dân tộc của người bệnh	Phát vấn
4	Trình độ học vấn	Bậc học cao nhất của người bệnh	Phát vấn
5	Nghề nghiệp	Nghề đem lại thu nhập chính	Phát vấn
6	Tình trạng hôn nhân	Tình trạng kết hôn/ chưa kết hôn của người bệnh	Phát vấn
7	Thu nhập bình quân	Thu nhập bình quân người/tháng tính theo VNĐ	Phát vấn
8	Đối tượng khám bệnh	Người bệnh sử dụng 1 trong bất kỳ loại bảo hiểm nào	Phát vấn
9	Hình thức sử dụng dịch vụ	Người bệnh đến điều trị theo chuyển tuyến/tự đến/hẹn	Phát vấn
10	Lý do chọn khoa PTCS	Những lý do được liệt kê khiến đối tượng đến khám và điều trị tại khoa	Phát vấn
11	Số lần đến khám	Số lần người bệnh đến khám tại khoa PTCS trong 12 tháng qua	Phát vấn
12	Hình thức tiếp cận thông tin về Khoa PTCS	Người bệnh biết đến khoa PTCS qua phương tiện nào	Phát vấn
13	Sử dụng DV	Người bệnh đăng ký sử dụng DV theo yêu cầu	Phát vấn

Bảng 2.4: Biến số và chỉ số cho mục tiêu 1

TT	Tên chỉ số	Định nghĩa	Cách tính	Phương pháp thu thập
Thời gian chờ tiếp cận dịch vụ				
1	Hài lòng với thời gian chờ đợi thủ tục nhập viện tại văn phòng khoa.	Là tỷ lệ NB hài lòng với thời gian chờ đợi thủ tục nhập viện	$M_1 = \frac{A_1}{A_1 + B} \times 100\ (\%)$ M_1: TLNB hài lòng với thời gian chờ thủ tục nhập viện tại văn phòng khoa. A_2: Số NB hài lòng với thời gian chờ nhân viên tiếp đón B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
2	Hài lòng với thời gian chờ đợi đi mổ.	Là tỷ lệ NB hài lòng với thời gian chờ đi mổ.	$M_2 = \frac{A_2}{A_2 + B} \times 100\ (\%)$ M_2: TLNB hài lòng với thời gian chờ đi mổ. A_2: Số NB hài lòng với thời gian chờ đi mổ. B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
3	Hài lòng với thời gian chờ sự có mặt của ĐD khi NB cần	Là tỷ lệ NB hài lòng với thời gian chờ sự có mặt của ĐD khi NB cần	$M_5 = \frac{A_5}{A_5 + B} \times 100\ (\%)$ M_5: TLNB hài lòng với thời gian chờ sự có mặt của ĐD A_5: Số NB hài lòng với thời gian chờ sự có mặt của ĐD B: Số NB không hài lòng	Phát vấn

4	Hài lòng với thời gian chờ đợi trợ giúp vệ sinh cá nhân.	Là tỷ lệ NB hài lòng với thời gian chờ đợi trợ giúp vệ sinh cá nhân.	$M_6 = \frac{A_6}{A_6 + B} \times 100\ (\%)$ M_6: TLNB hài lòng với thời gian chờ trợ giúp VS cá nhân. A_6: Số NB hài lòng với thời gian chờ trợ giúp VS cá nhân B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
Tiếp cận với chăm sóc ĐD				
5	Hài lòng với thái độ phục vụ thân thiện và tôn trọng NB của ĐD	Là tỷ lệ NB hài lòng với thái độ thân thiện và tôn trọng NB của ĐD	$M_7 = \frac{A_7}{A_7 + B} \times 100\ (\%)$. M_7: TLNB hài lòng thái độ phục vụ thân thiện và tôn trọng NB của ĐD A_7: Số NB hài lòng với thái độ phục vụ thân thiện và tôn trọng NB của ĐD B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
6	Hài lòng với sự cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện thao tác chăm sóc	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện thao tác chăm sóc của ĐD	$M_8 = \frac{A_8}{A_8 + B} \times 100\ (\%)$ M_8: TLNB hài lòng với thời gian chờ sự cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện thao tác chăm sóc A_8: Số NB hài lòng với sự cẩn thận, nhẹ nhàng khi thực hiện thao tác chăm sóc B: Số NB không hài lòng	Phát vấn

7	Hài lòng với việc công khai thuốc trước khi sử dụng cho người bệnh	Là tỷ lệ NB hài lòng với việc công khai thuốc trước khi sử dụng cho người bệnh của ĐD.	$M_9 = \frac{A_9}{A_9 + B} \times 100\ (\%)$ M_9: TLNB hài lòng việc công khai thuốc trước khi sử dụng cho người bệnh A_9: Số NB hài lòng với việc công khai thuốc trước khi sử dụng cho người B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
08	Hài lòng với quy trình chuẩn bị trước mổ của ĐD	Là tỷ lệ NB hài lòng với quy trình chuẩn bị trước mổ của ĐD	$M_{10} = \frac{A_{10}}{A_{10} + B} \times 100\ (\%)$ M_{10}: TLNB hài lòng quy trình chuẩn bị trước mổ của ĐD A_{10}: Số NB hài lòng với quy trình chuẩn bị trước mổ của ĐD B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
09	Hài lòng với giao tiếp của ĐD với người bệnh và thân nhân.	Là tỷ lệ NB hài lòng với giao tiếp của ĐD với người bệnh và thân nhân.	$M_{11} = \frac{A_{11}}{11 + B} \times 100\ (\%)$ M_{11}: TLNB hài lòng giao tiếp của ĐD với người bệnh và thân nhân. A_{11}: Số NB hài lòng với giao tiếp của ĐD với người bệnh và thân nhân. B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
10	Hài lòng với việc giải thích cho người bệnh trước	Là giải thích cho người bệnh trước khi làm thủ thuật	$M_{12} = \frac{A_{12}}{A_{12} + B} \times 100\ (\%)$ M_{12}: TLNB hài lòng với	Phát vấn

	khi làm thủ thuật chăm sóc	chăm sóc của ĐD	việc giải thích cho người bệnh trước khi làm thủ thuật chăm sóc A_{12}: Số NB hài lòng với t việc giải thích cho người bệnh trước khi làm thủ thuật chăm sóc B: Số NB không hài lòng	
11	Hài lòng với việc hướng dẫn và tập phục hồi chức năng tại giường	Là tỷ lệ NB hài lòng với việc hướng dẫn và tập phục hồi chức năng tại giường của KTV.	$M_{13} = \frac{A_{13}}{A_{13} + B} \times 100\ (\%)$ M_{13}: TLNB hài lòng với việc hướng dẫn và tập phục hồi chức năng tại giường A_{13}: Số NB hài lòng với việc hướng dẫn và tập phục hồi chức năng tại giường B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
12	Hài lòng với sự lắng nghe của ĐD khi nghe người bệnh trình bày	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự lắng nghe của ĐD khi người bệnh trình bày.	$M_{14} = \frac{A_{14}}{A_{14} + B} \times 100\ (\%).$ M_{14}: TLNB hài lòng sự lắng nghe của ĐD khi nghe người bệnh trình bày A_{14}: Số NB hài lòng với sự lắng nghe của ĐD khi nghe người bệnh trình bày B: Số NB không hài lòng	Phát vấn

Tiếp cận với điều trị của bác sỹ				
13	Hài lòng với thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ	Là tỷ lệ NB hài lòng với thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ	$M_{15} = \frac{A_{15}}{A_{15} + B} \times 100\ (\%)$ M_{15}: TLNB hài lòng thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ A_{15}: Số NB hài lòng thái độ thân thiện và tôn trọng người bệnh của bác sỹ B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
14	Hài lòng sau khi BS khám và chẩn đoán bệnh?	Là tỷ lệ NB hài lòng với BS sau khi khám và chẩn đoán bệnh?	$M_{16} = \frac{A_{16}}{16 + B} \times 100\ (\%)$ M_{16}: TLNB hài sau khi BS khám và chẩn đoán bệnh A_{16}: Số NB hài lòng sau khi BS khám và chẩn đoán bệnh B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
15	Hài lòng với những thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của BS.	Là tỷ lệ NB hài lòng với những thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của BS.	$M_{17} = \frac{A_{17}}{A_{17} + B} \times 100\ (\%)$ M_{17}: TLNB hài lòng với thời gian chờ những thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của BS. A_{17}: Số NB hài lòng với những thông tin giải thích cho người bệnh trước khi phẫu thuật của BS. B: Số NB không hài lòng	Phát vấn

16	Hài lòng với việc thăm khám bệnh hàng ngày của bác sỹ	Là tỷ lệ NB hài lòng với việc thăm khám bệnh hàng ngày của bác sỹ	$M_{18} = \frac{A_{18}}{A_{18} + B} \times 100\ (\%)$ M_{18}: TLNB hài lòng với việc thăm khám bệnh hàng ngày của bác sỹ A_{18}: Số NB hài lòng việc thăm khám bệnh hàng ngày của bác sỹ B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
17	Hài lòng với kết quả điều trị giảm đau sau mổ của bác sỹ	Là tỷ lệ NB hài lòng với kết quả điều trị giảm đau sau mổ của bác sỹ	$M_{19} = \frac{A_{19}}{A_{19} + B} \times 100\ (\%)$ M_{19}: TLNB hài lòng kết quả điều trị giảm đau sau mổ của bác sỹ A_{19}: Số NB hài lòng với kết quả điều trị giảm đau sau mổ của bác sỹ B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
18	Hài lòng về sự lắng nghe của BS khi nghe NB trình bày về bệnh tật	Là tỷ lệ NB hài lòng với lắng nghe của BS khi nghe NB trình bày bệnh tật.	$M_{21} = \frac{A_{21}}{A_{21} + B} \times 100\ (\%).$ M_{21}: TLNB hài lòng về sự lắng nghe của BS khi nghe NB trình bày về bệnh tật A_{21}: Số NB hài lòng về sự lắng nghe của BS khi nghe NB trình bày về bệnh tật B: Số NB không hài lòng	Phát vấn

Tư vấn giáo dục sức khỏe				
19	Hài lòng với sự tư vấn của bác sỹ về bệnh tật	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự tư vấn của bác sỹ về bệnh tật	$M_{22} = \frac{A_{22}}{A_{22} + B} \times 100\ (\%)$ M_{22}: TLNB hài lòng với sự tư vấn của bác sỹ về bệnh tật A_{22}: Số NB hài lòng với sự tư vấn của bác sỹ về bệnh tật B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
20	Hài lòng với sự hướng dẫn của ĐD về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, tư vấn sức khỏe	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự hướng dẫn của ĐD về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, tư vấn sức khỏe	$M_{23} = \frac{A_{23}}{A_{23} + B} \times 100\ (\%)$ M_{23}: TLNB hài lòng với sự hướng dẫn của ĐD về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, tư vấn sức khỏe A_{23}: Số NB hài lòng với sự hướng dẫn của ĐD về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, tư vấn sức khỏe B: Số NB không hài lòng	Phát vấn
21	Hài lòng với việc nghe và nhận tài liệu phổ biến nội quy và những thông tin cần thiết trong quá trình nằm viện	Là tỷ lệ NB hài lòng với việc nghe và phát tài liệu phổ biến nội quy và những thông tin cần thiết trong quá trình nằm viện	$M_{24} = \frac{A_{24}}{A_{24} + B} \times 100\ (\%)$ M_{24}: TLNB hài lòng với việc nghe và nhận tài liệu A_{24}: Số NB hài lòng với việc nghe và nhận tài liệu B: Số NB không hài lòng	Phát vấn

Sinh hoạt của người bệnh				
25	Hài lòng với giấc ngủ tại bệnh viện.	Là tỷ lệ NB hài lòng với giấc ngủ tại bệnh viện.	$M_{25}=\frac{A_{25}}{A_{25}+B}\times 100\ (\%)$ M_{25} : TLNB hài lòng với giấc ngủ tại bệnh viện. A_{25} : Số NB hài lòng với giấc ngủ tại bệnh viện. B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
26	Hài lòng với sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân	$M_{26}=\frac{A_{26}}{A_{26}+B}\times 100\ (\%)$ M_{26} : TLNB hài lòng sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân A_{26} : Số NB hài lòng với sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của người thân B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
27	Hài lòng với mức độ tự tin về khả năng làm việc đạt được sau PT	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự tự tin về năng lực làm việc.	$M_{28}=\frac{A_{28}}{A_{28}+B}\times 100\ (\%).$ M_{28} : TLNB hài lòng với khả năng làm việc A_{28} : Số NB hài lòng với khả năng làm việc B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
28	Hài lòng với mức độ tự tin khả năng tình dục của mình đạt được sau PT	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự tự tin khả năng tình dục đạt được sau PT.	$M_{29}=\frac{A_{29}}{A_{29}+B}\times 100\ (\%)$ M_{29} : TLNB hài lòng khả năng tình dục của mình. A_{29} : Số NB hài lòng với khả năng tình dục của mình. B : Số NB không hài lòng	Phát vấn

Cơ sở vật chất				
30	Hài lòng với cảnh quan của khoa PT Cột sống	Là tỷ lệ NB hài lòng với cảnh quan của khoa PT Cột sống	$M_{30}=\frac{A_{30}}{A_{30}+B}\times 100\ (\%)$ M_{30} : TLNB hài lòng với cảnh quan của khoa PT Cột sống A_{30} : Số NB hài lòng với cảnh quan của khoa PT Cột sống B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
31	Hài lòng với trang thiết bị y tế của khoa phòng.	Là tỷ lệ NB hài lòng với trang thiết bị y tế của khoa phòng.	$M_{31}=\frac{A_{31}}{A_{31}+B}\times 100\ (\%)$ M_{31} : TLNB hài lòng với trang thiết bị y tế của khoa phòng. A_{31} : Số NB hài lòng với trang thiết bị y tế của khoa phòng. B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
32	Hài lòng với ánh sáng của khoa phòng	Là tỷ lệ NB hài lòng với ánh sáng của khoa phòng	$M_{32}=\frac{A_{32}}{A_{32}+B}\times 100\ (\%).$ M_{32} : TLNB hài lòng với độ sáng của khoa phòng A_{32} : Số NB hài lòng với độ sáng của khoa phòng B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
33	Hài lòng với sự sạch sẽ của buồng bệnh	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự sạch sẽ của buồng bệnh	$M_{33}=\frac{A_{33}}{A_{33}+B}\times 100\ (\%)$ M_{33} : TLNB hài lòng với sự sự sạch sẽ của buồng bệnh A_{33} : Số NB hài lòng với sự sự sạch sẽ của buồng bệnh B : Số NB không hài lòng	Phát vấn

34	Hài lòng với chất lượng đồ vải của bệnh viện.	Là tỷ lệ NB hài lòng với chất lượng đồ vải tại bệnh viện.	$M_{34}=\frac{A_{34}}{A_{34}+B}\times 100\ (\%)$ M_{34} : TLNB hài lòng với chất lượng đồ vải tại bệnh viện. A_{34} : Số NB hài lòng với chất lượng đồ vải củabệnh viện. B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
35	Hài lòng với tiện nghị sinh hoạt của BV	Là tỷ lệ NB hài lòng với tiện nghi sinh hoạt của BV	$M_{35}=\frac{A_{35}}{A_{36}+B}\times 100\ (\%)$ M_{35} : TLNB hài lòng với tiện nghị sinh hoạt A_{35} : Số NB hài lòng với tiện nghị sinh hoạt B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
36	Hài lòng với diện tích của buồng bệnh?	Là tỷ lệ NB hài lòng với diện tích của buồng bệnh?	$M_{36}=\frac{A_{36}}{A_{36}+B}\times 100\ (\%).$ M_{36} : TLNB hài lòng với diện tích của buồng bệnh A_{36} : Số NB hài lòng với diện tích của buồng bệnh B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
37	Hài lòng với sạch sẽ trong khu vệ sinh của NB	Là tỷ lệ NB hài lòng với sạch sẽ trong khu vệ sinh của NB	$M_{36}=\frac{A_{36}}{A_{36}+B}\times 100\ (\%).$ M_{36} : TLNB hài lòng với diện tích của buồng bệnh A_{36} : Số NB hài lòng với diện tích của buồng bệnh B : Số NB không hài lòng	

Môi trường bệnh viện				
37	Hài lòng với an ninh trong bệnh viện	Là tỷ lệ NB hài lòng với an ninh trong bệnh viện	$M_{37}=\frac{A_{37}}{A_{37}+B}\times 100$ (%). M_{37} : TLNB hài lòng với an ninh trong bệnh viện A_{37} : Số NB hài lòng với an ninh trong bệnh viện B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
38	Hài lòng với sự sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện.	Là tỷ lệ NB hài lòng với sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện.	$M_{38}=\frac{A_{38}}{A_{38}+B}\times 100$ (%) M_{38} : TLNB hài lòng với sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện. A_{38} : Số NB hài lòng với sự sạch sẽ của khuôn viên bệnh viện. B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
39	Hài lòng với cây xanh trong bệnh viện	Là tỷ lệ NB hài lòng với cây xanh trong bệnh viện	$M_{39}=\frac{A_{39}}{A_{39}+B}\times 100$ (%) M_{39} : TLNB hài lòng với cây xanh trong bệnh viện A_{39} : Số NB hài lòng với cây xanh trong bệnh viện B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
40	Hài lòng với sự yên tĩnh trong bệnh viện.	Là tỷ lệ NB hài lòng với sự yên tĩnh trong bệnh viện.	$M_{40}=\frac{A_{40}}{A_{40}+B}\times 100$ (%) M_{40} : TLNB hài lòng với sự yên tĩnh trong bệnh viện A_{40} : Số NB hài lòng với sự sự yên tĩnh trong bệnh viện B : Số NB không hài lòng	Phát vấn

Hiệu quả và chi phí khám chữa bệnh				
41	Hài lòng với kết quả của đợt điều trị này.	Là tỷ lệ NB hài lòng với kết quả của đợt điều trị này.	$M_{41} = \frac{A_{41}}{A_{41} + B} \times 100\ (\%)$ M_{41} : TLNB hài lòng kết quả của đợt điều trị này. A_{41} : Số NB hài lòng với kết quả của đợt điều trị này. B Số NB không hài lòng	Phát vấn
42	Hài lòng với tổng chi phí của đợt điều trị này so với kết quả ông/bà đạt được sau PT	Là tỷ lệ NB hài lòng với tổng chi phí của đợt điều trị này so với kết quả ông/bà đạt được sau PT.	$M_{42} = \frac{A_{42}}{A_{42} + B} \times 100\ (\%)$ M_{42} : TLNB hài lòng với tổng chi phí của đợt điều trị này so với kết quả ông/bà đạt được sau PT A_{42} : Số NB hài lòng với tổng chi phí của đợt điều trị này so với kết quả ông/bà đạt được sau PT B : Số NB không hài lòng	Phát vấn
43	Hài lòng chung khi điều trị tại Khoa PTCS	Là tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh khi điều trị tại khoa PTCS	$M_{43} = \frac{A_{43}}{A_{43} + B} \times 100\ (\%)$ M_{43} : TLNB hài lòng chung khi điều trị tại Khoa PTCS A_{43} : Số NB hài lòng chung khi điều trị tại Khoa PTCS B : Số NB không hài lòng	Phát vấn

Bảng 2.5: Biến số và chỉ số cho mục tiêu 2

TT	Biến số/ chỉ số	Cách tính	Phương pháp thu thập
1	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng về thời gian tiếp cận dịch vụ của NB	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn
2	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng của người bệnh với sự chăm sóc của ĐD	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn
3	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng của người bệnh về với điều trị của bác sỹ	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn
4	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng của người bệnh về tư vấn giáo dục sức khỏe	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn
5	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng về sinh hoạt của NB	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn
6	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng của người bệnh về cơ sở vật chất	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn

7	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng của người bệnh về môi trường bệnh viện	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn
8	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng của người bệnh về hiệu quả và chi phí điều trị	OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn
9	Mối liên quan của các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng chung của người bệnh	. OR= $\frac{a \times d}{b \times c}$ (95% CI)	Phát vấn

Trong đó:

OR: Tỷ suất chênh của mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học theo biến (nhóm tuổi, giới, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hôn nhân, thu nhập trung bình, BHYT, số lần KCB tại khoa/năm, tiếp cận thông tin về khoa PTCS, sử dụng dịch vụ theo yêu cầu) với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh

a: Số NB hài lòng nhưng có mang các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (thời gian chờ đợi, tiếp cận NVYT, tư vấn GDSK, CSVC, MTBV,…) có liên quan đến nhân khẩu học được phân tích theo biến phù hợp

b: Số NB không hài lòng nhưng có mang cácyếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (thời gian chờ đợi, tiếp cận NVYT, tư vấn GDSK, CSVC, MTBV,…) có liên quan đến nhân khẩu học được phân tích theo biến phù hợp

c: Số NB hài lòng nhưng không mang các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (thời gian chờ đợi, tiếp cận NVYT, tư vấn GDSK, CSVC, MTBV,…) có liên quan đến nhân khẩu học được phân tích theo biến phù hợp

d: Số NB không hài lòng nhưng không mang yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (thời gian chờ đợi, tiếp cận NVYT, tư vấn GDSK, CSVC, MTBV,…) có liên quan đến nhân khẩu học được phân tích theo biến phù hợp.

(95% CI= 95% Confidence Interval): Khoảng tin cậy 95%.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **BỘ Y TẾ**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

VŨ HOÀNG ANH

Sù HµI LßNG CñA NG¦êI BÖNH PHÉU THUËT BÖNH Lý CéT SèNG T¹I VIÖN CHÊN TH¦¥NG CHØNH H×NH – BÖNH VIÖN H÷U NGHÞ VIÖT §øC

Chuyên ngành: Quản lý Bệnh viện

Mã số: 60720701

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

BS VŨ KHẮC LƯƠNG

Phó giáo sư, Tiến sĩ Y học

HÀ NỘI – 2015

LỜI CÁM ƠN

Trước tiên, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Viện Đào tạo Y học dự phòng – Y tế Công cộng Trường Đại học Y Hà nội đã mang đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời qua thời gian 2 năm học tại Trường.

Tôi xin trân trọng cám ơn các Thày, Cô Viện Đào tạo YHDP-YTCC và bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế đã truyền đạt, giảng dạy cho tôi trong suốt thời gian học tập cao học.

Tôi xin trân trọng biết ơn PGS.TS Vũ Khắc Lương, người Thày đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, đóng góp những ý kiến quý báu, trang bị kiến thức để tôi bước đi trên con đường nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc cho phép tôi được gửi tới PGS.TS Nguyễn Văn Thạch, người Thày đã tạo mọi điều kiện, dìu dắt, dạy dỗ, giúp tôi trưởng thành trong lĩnh vực chuyên môn và quản lý.

Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban Lãnh đạo cùng tập thể bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên Khoa Phẫu thuật Cột sống luôn bên cạnh giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Đây là món quà con kính dâng lên Người Cha đã khuất, Người Mẹ kính yêu đã sinh thành, nuôi dưỡng, luôn động viên giúp con có nghị lực và ý chí vươn lên.

Xin được gửi tình yêu thương tới gia đình: người bạn đời thân yêu, các con và cháu ngoại yêu quý là chỗ dựa tinh thần để tôi phấn đấu.

Và cuối cùng, xin cám ơn anh chị em, bạn bè, tập thể lớp cao học QLBV khóa 22 luôn bên cạnh động viên tôi hoàn thành khóa luận này.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Học viên

Vũ Hoàng Anh

LỜI CAM ĐOAN

Kính gửi:

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà nội

Phòng Đào tạo Sau Đại học – Viện Đào tạo YHDP và YTCC

Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế

Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, tất cả số liệu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Học viên

Vũ Hoàng Anh

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BHYT	Bảo hiểm y tế
BS	Bác sỹ
CBYT	Cán bộ y tế
CSSK	Chăm sóc sức khỏe
CĐ	Cao đẳng
CSVC	Cơ sở vật chất
CTCH	Chấn thương chỉnh hình
ĐH	Đại học
ĐD	Điều dưỡng
GDSK	Giáo dục sức khỏe
HL	Hài lòng
HSSV	Học sinh sinh viên
KCB	Khám chữa bệnh
KTV	Kỹ thuật viên
NB	Người bệnh
NVYT	Nhân viên y tế
PTCS	Phẫu thuật cột sống
PTTH	Phổ thông trung học
PHCN	Phục hồi chức năng
QĐ-BYT	Quyết định- Bộ y tế
SERVQUAL	Service Quality (Chất lượng dịch vụ)
TTB	Trang thiết bị
TTĐC	Thông tin đại chúng

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 1: TỔNG QUAN 3
1.1. Một số khái niệm cơ bản 3
1.1.1. Khái niệm và phân loại sự hài lòng 3
1.1.2. Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe 4
1.1.3. Mối quan hệ giữa sự hài lòng và chất lượng dịch vụ 5
1.2. Sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế. 6
1.2.1. Các nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh. 6
1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh. 12
1.4. Sơ lược về địa điểm thực hiện nghiên cứu: Khoa Phẫu thuật Cột sống- Viện Chấn thương Chỉnh hình- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 18
1.4.1. Viện Chấn thương Chỉnh hình 18
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
2.1. Khung lý thuyết 22
2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 23
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 23
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 24
2.4. Phương pháp nghiên cứu 24
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 24
2.4.2. Cỡ mẫu 24
2.4.3. Chọn mẫu 25
2.4.4. Các biến số/chỉ số nghiên cứu: 26
2.5. Công cụ nghiên cứu 29
2.5.1. Quá trình thiết kế Bộ câu hỏi phát vấn: 31
2.6. Thu thập thông tin và đánh giá 31
2.7. Sự phân chia mức độ hài lòng 32

2.8. Xử lý số liệu 32
2.9. Đạo đức nghiên cứu.....33
2.10. Sai số và cách khắc phục 33
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35
3.1. Sự hài lòng chung của người bệnh với một số yếu tố 35
3.2. Sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế tại khoa Phẫu thuật Cột sống...37
3.2.1. Thời gian tiếp cận dịch vụ y tế 37
3.2.2. Tiếp cận với chăm sóc của Điều dưỡng 38
3.2.3. Tiếp cận với điều trị của bác sỹ..... 39
3.2.4. Tư vấn giáo dục sức khỏe 40
3.2.5. Sinh hoạt của người bệnh..... 40
3.2.6. Cơ sở vật chất..... 41
3.2.7. Môi trường bệnh viện..... 42
3.2.8. Hiệu quả và chi phí KCB 43
3.2.9. Sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế tại khoa Phẫu thuật Cột sống. 43
3.3. Liên quan giữa các yếu tố với sự hài lòng của người bệnh 44
3.3.1. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng chung của người bệnh 44
3.3.2. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế..... 45
3.3.3. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với chăm sóc của ĐD 47
3.3.4. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với tư vấn giáo dục sức khỏe..... 48
3.3.5. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với sinh hoạt của người bệnh 50
3.3.6. Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh về chi phí chữa bệnh..... 51

Chương 4: BÀN LUẬN 53
4.1. Một số đặc điểm và sự hài lòng chung của người bệnh đến khám tại Khoa Phẫu thuật Cột sống - Viện Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Việt Đức. 53
4.2. Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Phẫu thuật Cột sống -Viện Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Việt Đức.. 56
4.3. Mối liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh 71
4.4. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu 77
4.4.1. Ưu điểm của nghiên cứu 77
4.4.2. Một số hạn chế của nghiên cứu 77
KẾT LUẬN 78
KHUYẾN NGHỊ 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Công cụ nghiên cứu 30
Bảng 3.1: Bảng phân bố sự hài lòng chung theo yếu tố nhân khẩu học 35
Bảng 3.2: Bảng phân bố sự hài lòng chung với một số yếu tố yếu tố dịch vụ KCB tại Khoa PTCS 36
Bảng 3.3: Sự hài lòng với thời gian chờ đợi tiếp cận dịch vụ y tế 37
Bảng 3.4: Sự hài lòng với chăm sóc của ĐD 38
Bảng 3.5: Sự hài lòng với điều trị của bác sỹ 39
Bảng 3.6: Sự hài lòng với tư vấn giáo dục sức khỏe 40
Bảng 3.7: Sự hài lòng với sinh hoạt người bệnh 40
Bảng 3.8: Sự hài lòng với cơ sở vật chất 41
Bảng 3.9: Sự hài lòng với môi trường bệnh viện 42
Bảng 3.10: Sự hài lòng với hiệu quả và chi phí KCB 43
Bảng 3.11: Sự hài lòng chung với dịch vụ tại khoa Phẫu thuật Cột sống 43
Bảng 3.12: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng chung của người bệnh 44
Bảng 3.13: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với thời gian tiếp cận dịch vụ y tế 45
Bảng 3.14: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với chăm sóc của ĐD 47
Bảng 3.15: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với tư vấn giáo dục sức khỏe 48
Bảng 3.16: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh với sinh hoạt của người bệnh 50
Bảng 3.17: Liên quan giữa một số yếu tố với sự hài lòng của người bệnh về chi phí chữa bệnh 51

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Khung lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng 12
Hình 1.2. Quy trình tiếp nhận, khám và điều trị nội trú tại Khoa Phẫu thuật Cột sống 21

Sơ đồ 2.1: Khung lý thuyết nghiên cứu..... 22